



**УЧИМ
ЗНАЕМ** ЗАБОТЛИВАЯ
ШКОЛА



**ГОСПИТАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА. ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ОБУЧЕНИЯ
ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ В
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И НА ДОМУ**

**Материалы 7-й Всероссийской
научно-практической конференции
с международным участием**

30 - 31 октября 2025 г.

г. Москва



Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Институт развития, здоровья и адаптации ребенка»
Лаборатория госпитальной педагогики

Департамент образования и науки города Москвы
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа № 109»
Проект госпитальных школ России «УчимЗнаем»
Центр знаний, профессиональных компетенций и наставничества
по госпитальной педагогике «Заботливая школа»

**ГОСПИТАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА. ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ОБУЧЕНИЯ
ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ В
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И НА ДОМУ**

Материалы 7-й Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием

30-31 октября 2025 г.
г. Москва

Под редакцией Шарикова С.В., И.Ю. Долуева, А.Ф. Лоскутова

Москва
2025

УДК 37
ББК 74
Г 72

Печатается по рекомендации программного комитета 7-й Всероссийской научно-практической конференции с международным участием

Рецензенты:

Ямбург Евгений Александрович, доктор педагогических наук, действительный член (академик) РАО, директор ГБОУ Школа № 109

Румянцев Александр Григорьевич, доктор медицинских наук, академик РАН, профессор, Президент НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева

Г 72 Госпитальная педагогика. Лучшие практики обучения детей, находящихся на длительном лечении в медицинских организациях и на дому: Материалы 7-й Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (Москва, 30-31 октября 2025 г.) / под ред. С.В. Шарикова, И.Ю. Долуева, А.Ф. Лоскутова. – 2025. – 179 с.

ISBN 978-5-6054932-2-8

В сборнике представлены материалы 7-й Всероссийской научно-практической конференции с международным участием **«Госпитальная педагогика. Лучшие практики обучения детей, находящихся на длительном лечении в медицинских организациях и на дому»** (далее – Конференция), которая состоялась 30-31 октября 2025 г. и была посвящена теоретическим и практическим вопросам обучения и воспитания длительно болеющих детей. Конференция организована Проектом госпитальных школ России «УчимЗнаем».

Ведущими специалистами сферы образования, здравоохранения, проектного офиса Проекта госпитальных школ «УчимЗнаем» и Лаборатории госпитальной педагогики Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт развития, здоровья и адаптации ребенка» обобщены теоретические, организационные и методические аспекты реализации программ для всех уровней общего образования в условиях медицинского стационара; опыт организации научно-методической и методической работы с педагогическими коллективами госпитальных школ, а также представлены примеры лучших образовательных практик работы с обучающимися на флагманской и региональных площадках Проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем».

© Коллектив авторов, 2025
© УчимЗнаем, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ

Шариков Сергей Витальевич

О проведении VII Всероссийской конференции с международным участием «Госпитальная педагогика. Лучшие практики обучения детей, находящихся на длительном лечении в медицинских организациях и на дому» 9

МАТЕРИАЛЫ ПЛЕНАРНЫХ ДОКЛАДОВ

Голованов Виктор Петрович

Семь социально-воспитательных нот симфонии госпитальной педагогики 13

Рыбакова Ольга Сергеевна

Нормативно-правовое обеспечение соблюдения конституционных прав на получение качественного доступного образования детей, нуждающихся в длительном лечении 22

Куртанова Юлия Евгеньевна

Психолого-педагогическая и социальная реинтеграция детей с онкологическими заболеваниями после длительного лечения 33

Волкова Алиса Георгиевна, Путинцева Анастасия Георгиевна,

Павлик Анжелика Витальевна, Тимофеева Марья Александровна

Значение оценки сенсомоторных функций у пациентов с онкологическими заболеваниями для построения образовательного процесса в госпитальной школе 37

Хазова Татьяна Викторовна

«Ареал культуры» как инструмент комплексной реабилитации 42

Храброва Анна Сергеевна

«Мечта о космосе» – проект без границ 47

МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА ПО ОБСУЖДЕНИЮ И АКТУАЛИЗАЦИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ НАУЧНО- ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ В МЕДИЦИНСКИХ СТАЦИОНАРАХ И НА ДОМУ

Поздеева Ольга Владимировна, Долуев Иван Юрьевич

Региональная практика организации образовательной деятельности для детей, находящихся на длительном лечении 50

МАТЕРИАЛЫ СЕКЦИОННЫХ ДОКЛАДОВ

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ

Лебедева Елена Владимировна

Подготовка к государственной итоговой аттестации подростков с особыми образовательными потребностями..... 56

Разбегин Тимофей Анатольевич, Глезь Александра Маратовна

Сопровождение имобилизованного ребенка при подготовке к единому государственному экзамену 60

Абаева Дарья Александровна, Широа Мария Феликсовна

Учебный эксперимент в обучении предметам естественно-научного цикла в госпитальной школе: проблемы и подходы..... 63

Медведева Анастасия Сергеевна

Учет индивидуальных психолого-педагогических особенностей учащихся госпитальной школы на уроках изучения нового материала по физике 66

Дзенис Анна Валерьевна

Особенности проведения первого урока химии с новым учеником в госпитальной школе (на примере 10 класса)..... 71

Кубрак Алёна Романовна

Оценивание с использованием мемов в госпитальной школе..... 76

Старцева Светлана Александровна

Особенности организации обучения на дому обучающихся с интеллектуальными нарушениями..... 78

Кузминич Наталья Анатольевна, Солдатенкова Анна Николаевна

Игровые приемы на уроках английского языка в госпитальной школе как средство формирования положительного эмоционального фона 84

Левченкова Алина Сергеевна

Особенности методики обучения русскому языку детей, находящихся на длительном лечении: реализация аксиологического подхода 87

Морозова Евгения Витальевна, Саломахина Наталья Владимировна

Обучение через творчество иностранному языку детей, попавших в трудную жизненную ситуацию 90

Засорина Ольга Петровна, Щепина Наталия Владимировна

Применение учебной дискуссии как средства развития коммуникативных универсальных учебных действий у учащихся начальных классов госпитальной школы 93

ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПРИ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ

Крымкова Марина Михайловна

Использование искусственного интеллекта на уроках английского языка в условиях госпитальной школы 96

Ширяев Сергей Дмитриевич, Лобанов Антон Валерьевич

Особенности использования технологий искусственного интеллекта при обучении химии детей с онкологическими нозологиями 98

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ВОСПИТАНИЯ В ГОСПИТАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Константинов Василий Васильевич, Щурова Александра Николаевна

Социокультурный проект как средство формирования гражданской идентичности у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 102

Бабенков Николай Дмитриевич, Гавриленко Алексей Дмитриевич

Формирование здорового образа жизни и патриотизма через программу «Спортивный калейдоскоп» в госпитальной школе 108

Ляховецкий Александр Петрович, Шакиров Рустэм Равилевич

Использование стендового моделизма для мотивации к обучению и гражданско-патриотического становления детей в госпитальной школе 111

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ГОСПИТАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Ветрова Галина Анатольевна

Настольные игры как инструмент педагога госпитальной школы для диагностики и коррекции поведения детей, находящихся на длительном лечении 115

Чурилова Валерия Левановна

Интеграция шахмат в учебные предметы госпитальной школы 119

Мазанова Ольга Юрьевна

Участие в конкурсах по финансовой грамотности, как путь преодоления неуспешности детей в процессе обучения в условиях госпитальной школы... 121

Фролова Светлана Александровна

Участие в конкурсах и олимпиадах детей дошкольного возраста в госпитальной школе как способ поддержки детской инициативы 124

**Теплякова Ксения Олеговна, Солдатенкова Мария Дмитриевна,
Чулкова Галина Меркурьевна**
Обучение физике в условиях госпитальных школ через современные
высокотехнологичные экспериментальные задачи 127

Пустохайлова Анастасия Алексеевна
Английский язык как окно в мир: как изучение иностранного языка помогает
детям, находящимся на длительном лечении, раскрыть свой потенциал 130

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ

Савранский Илья Евгеньевич
Психолого-педагогическое сопровождение детей, пострадавших в результате
проведения специальной военной операции. Первый опыт..... 135

Бабенков Николай Дмитриевич, Макаров Лев Геннадьевич
Роль профессиональной ориентации у старшеклассников в госпитальной школе
..... 137

**Киреева Айгуль Альбертовна, Макаров Лев Геннадьевич,
Макарова Маргарита Федоровна**
Путешествие во взрослую жизнь: игровая развивающая среда для ранней
профориентации (методологические основы и инструментарий)..... 140

Адамян Арег Грайрович
Альтернативная и дополнительная коммуникация на занятиях
в реабилитационном центре 144

Бабенкова Екатерина Николаевна, Ковалева Наталья Николаевна
Нейроигры в работе учителя-логопеда в госпитальной школе 147

Фёдоров Андрей Владимирович, Шиблева Ирина Эдуардовна
Академическая и социальная реабилитация детей дошкольного возраста..... 150

ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ГОСПИТАЛЬНЫХ ШКОЛ

Зык Александр Николаевич

Формирование и развитие профессиональных компетенций госпитальных педагогов: современные образовательные подходы..... 153

Лоскутов Александр Федорович, Бабенков Николай Дмитриевич

Опыт организации практики магистрантов в госпитальной школе как важный инструмент развития профессиональной компетентности будущего педагога..... 165

Родецкая Виктория Алексеевна, Бочаров Виктор Викторович

Особенности выгорания госпитальных педагогов 169

Гущина Людмила Ивановна, Кот Татьяна Викторовна

Теория и практика госпитальной педагогики: ресурсы системы дополнительного профессионального образования 174

ВСТУПЛЕНИЕ

УДК 376.1

О ПРОВЕДЕНИИ VII ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ГОСПИТАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА. ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И НА ДОМУ»

Шариков Сергей Витальевич

PhD

профессор

Руководитель проектного офиса Проекта госпитальных школ
«УчимЗнаем»

Почетный работник общего образования Российской Федерации

Лауреат Премии Правительства Российской Федерации
в области образования

Лауреат Премии города Москвы в области образования

ON THE HELD OF THE VII ALL-RUSSIAN CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION "HOSPITAL PEDAGOGY. BEST PRACTICES OF TEACHING CHILDREN WHO ARE UNDER LONG-TERM TREATMENT IN MEDICAL ORGANIZATIONS AND AT HOME"

Sharikov Sergey Vitalievich

PhD

Professor

Head of the Project Office of the "Hospital school "We Teach/They Learn"

Honored Worker of General Education of the Russian Federation

Winner of the Government of the Russian Federation Prize
in the Field of Education

Winner of the Moscow City Prize in the Field of Education

Всероссийская конференция с международным участием «Госпитальная педагогика. Лучшие практики обучения детей, находящихся на длительном лечении в медицинских организациях и на дому» состоялась 30-31 октября 2025 года. Конференция проходила в смешанном формате на двух площадках: в Московском центре качества образования (МЦКО) по адресу: г. Москва, Семеновская площадь, д. 4 и в НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Саморы Машела, д. 1.

Организаторами Конференции являлись Проект госпитальных школ России «УчимЗнаем», Федеральное государственное бюджетное научной учреждение «Институт развития, здоровья и адаптации ребенка» Министерства

просвещения Российской Федерации при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации.

В работе конференции приняли участие представители Российской Федерации, Республики Узбекистан и Киргизской Республики, Республики Беларусь.

Целями проведения Конференции выступали создание международной площадки для профессионального и общественного обсуждения теоретических и практических подходов к решению актуальных проблем в области госпитальной педагогики, обмен опытом и знаниями по организации образования детей, находящихся на длительном лечении в медицинских стационарах и на дому.

Ключевыми направлениями работы конференции были:

- единое пространство обучения и воспитания детей, находящихся на длительном лечении;
- научно-методологические аспекты обучения и воспитания детей, находящихся на длительном лечении;
- научно-исследовательская деятельность в области госпитальной педагогики;
- сетевое сотрудничество региональных площадок Проекта «УчимЗнаем»;
- цифровая образовательная среда госпитальной школы.

В рамках Конференции был проведен круглый стол на тему: «Обеспечение конституционного права на получение качественного и доступного образования детьми, находящимися на длительном лечении в медицинских организациях и на дому», в рамках которого прошло обсуждение законодательной инициативы в части обеспечения конституционного права на образование детей, находящихся на длительном лечении в медицинских организациях и на дому.

Программа конференции включала:

1. Пленарное заседание «Проект «УчимЗнаем» – 10 лет позади, 10 лет впереди»;

2. Параллельные секции по темам:

«Партнеры Проекта «УчимЗнаем» – детям, находящимся на длительном лечении»;

«Академическая, социальная и психологическая реабилитация в пространстве госпитальной школы»;

«Идеи научной школы В.С. Мухиной в практике работы специалистов госпитальных школ»;

«Круглый стол с представителями органов региональной исполнительной власти в сфере образования, региональных инновационных площадок «УчимЗнаем», общеобразовательных организаций»;

«Палитра методов, форм и средств основного и дополнительного образования для детей, находящихся на длительном лечении»;

«Актуальная исследовательская проблематика в области госпитальной педагогики»;

«Актуальные методические разработки в области госпитальной педагогики»

3. Конкурс научно-исследовательских проектов по тематике госпитальной педагогики среди молодых ученых.

Участники конференции: в работе конференции приняли участие руководители и работники органов управления образованием; руководители научных и образовательных учреждений, учебных заведений всех уровней образования; научные работники в области общей и специальной педагогики; преподаватели образовательных организаций высшего образования и научных учреждений; педагоги общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы на базе медицинских учреждений (госпитальных школ); представители родительской общественности; слушатели программ профессиональной переподготовки, курсов повышения квалификации, студенты и аспиранты профильных направлений подготовки.

В рамках двух дней работы конференциями в гибридном формате слушателями стали более 5000 специалистов. Более 500 человек приняли очное участие в Конференции.

В рамках 7 секций и Пленарного заседания приняли участие 103 спикера, было представлено более 70 докладов и мастер-классов. Среди докладчиков 33 участника имеют ученую степень, из них 10 докторов наук (из них 5 академиков Российской академии образования, 1 академик Российской академии наук), 23 кандидата наук различных отраслей научного знания.

География очных участников конференции представлена 43 регионами Российской Федерации: Алтайский край, Астраханская область, Белгородская область, Волгоградская область, Воронежская область, Забайкальский край, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Кемеровская область, Кемеровская область, Ленинградская область, Москва, Московская область, Нижегородская область, Орловская область, Пермский край, Приморский край, Республика Башкортостан, Республика Коми, Республика Удмуртия, Ростовская область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Ставропольский край, Тамбовская область, Тульская область, Хабаровский край, Челябинская область, Республика Саха Якутия, Ярославская область, Ульяновская область, Мурманская область, Брянская область, Саратовская область, Омская область, Тверская область, Новосибирская область, Рязанская область, Псковская область, Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Липецкая область, Оренбургская область.

В ходе конференции были подведены итоги практической и научной деятельности Проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем», направленной на становление и формирование госпитальной педагогики как отдельного раздела общей педагогики.

В соответствии с целями и задачами конференции на пленарных и секционных сессиях:

- прошло профессионально-общественное обсуждение вопросов соблюдения прав детей, находящихся на длительном лечении, на получение качественного образования; вопросов нормативного правового регулирования

организации получения образования детьми, находящимися на длительном лечении, в медицинских стационарах, единого содержания региональных нормативных правовых актов, регламентирующих организацию обучения детей, находящихся на длительном лечении, вопросов взаимодействия ведомств в сфере образования и здравоохранения;

- прошло обсуждение особенностей реализации модели госпитальных школ в Российской Федерации;
- проведен анализ актуального состояния, тенденций и перспектив развития госпитальной педагогики;
- актуализированы междисциплинарные научно-практические задачи образования детей, находящихся на длительном лечении в медицинских стационарах и на дому,
- рассмотрены вопросы междисциплинарного, межрегионального и международного сотрудничества в целях обеспечения и поддержания благополучия длительно болеющих детей.

В рамках Всероссийской конференции состоялись семь параллельных секций, посвященных широкому спектру вопросов. К наиболее актуальным из них относятся:

1. нормативно-правовое обеспечение Конституционного права ребенка, нуждающегося в длительном лечении, на получение качественного и доступного образования;
2. здоровьесберегающая деятельность госпитальной школы как вектор социально-образовательного проектирования;
3. профессиональная позиция специалиста госпитальной школы как педагога-исследователя;
4. успешность как фактор всестороннего развития длительно болеющего ребенка;
5. реализация ключевых научно-исследовательских задач в работе молодого ученого в госпитальной школе;
6. участие специалиста госпитальной школы в обеспечении комплексной медико-социо-психолого-педагогической реабилитации длительно болеющих детей.

Каждый представленный доклад – это не только научное осмысление, но и живая практика, проверенная реальными условиями, судьбами и историями детей. Эти материалы демонстрируют, что госпитальная педагогика сегодня – это отдельное научное направление современного образования с собственной методологией.

Мы искренне надеемся, что данный сборник станет полезным инструментом для педагогов, руководителей образовательных организаций, специалистов медицинских учреждений, научных работников и всех, кто разделяет ценности заботливого и доступного образования для каждого ребёнка, независимо от жизненных обстоятельств.

Уверен, что представленные материалы станут основой для дальнейших исследований, профессионального диалога и внедрения лучших практик в интересах детей, нуждающихся в особой образовательной поддержке.

МАТЕРИАЛЫ ПЛЕНАРНЫХ ДОКЛАДОВ

УДК 371.2

СЕМЬ СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ НОТ СИМФОНИИ ГОСПИТАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ

Голованов Виктор Петрович

доктор педагогических наук, профессор
заведующий лабораторией детства

НП Центр развития образования, науки и культуры «Обнинский полис»

Председатель Общероссийского общественного

детско-молодежного движения авторской песни «Многоголосье»

эксперт АНО ДПО «Академия инновационного образования и развития»

почетный профессор МарГУ

член Президиума, академик «Академия детско-юношеского туризма и

краеведения» им А.А. Остапца-Свешникова,

Заслуженный учитель РФ

Почетный работник общего образования РФ

Почетный работник сферы молодежной политики РФ

заместитель председателя Научного совета по

дополнительному образованию детей

при Отделении образования и культуры

Российской академии образования,

член Научного совета по проблемам воспитания подрастающего поколения

при Отделении философии образования и теоретической педагогики

Российской академии образования

советник Российской Федерации 3 класса

vpgolovanov@mail.ru

SEVEN SOCIO-EDUCATIONAL NOTES SYMPHONIES OF HOSPITAL PEDAGOGY

Golovanov Viktor Petrovich

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Head of the Laboratory of Childhood

Non-Profit Partnership Center for the Development of Education, Science and

Culture "Obninsky Polis"

Chairman of the All-Russian Public

children's and youth movement of the author's song "Polyphony"

Expert of the Academy of Innovative Education and Development, Honorary

Professor of MarSU

Member of the Presidium, Academician of the Academy of Children and Youth

Tourism and Local History named after A.O. Ostapets-Sveshnikov

Honored Teacher of the Russian Federation
Honorary Worker of General Education of the Russian Federation
Honorary Worker of the Youth Policy of the Russian Federation
Deputy Chairman of the Scientific Council for
additional education for children
at the Department of Education and Culture
Russian Academy of Education
Member of the Scientific Council on the Problems
of Educating the Younger Generation
at the Department of Philosophy of Education and Theoretical Pedagogy of the
Russian Academy of Education
Counsellor of the Russian Federation, 3rd Class
vpgolovanov@mail.ru

Аннотация. В статье анализируется научное осмысление госпитальной педагогики на протяжении семи лет в ходе проведения ежегодных международных конференций. Подтверждается, что госпитальная педагогика одно из перспективных направлений научной мысли и самостоятельный раздел педагогики, получивший современное звучание в России в 2014 году в рамках инновационного проекта «УчимЗнаем». Рассматривается социально-воспитательная составляющая госпитальной педагогики. Воспитание в условиях госпитальной педагогики образно представлено с сочинением сложных музыкальных произведений – симфонии полноценной жизни. В основе – семь социально-воспитательных нот симфонии госпитальной педагогики

Ключевые слова: воспитательный потенциал, воспитание через преодоление, госпитальная педагогика, инклюзия, дополнительное образование детей, интеграция медицины и образования.

Abstract. The article analyzes the scientific comprehension of hospital pedagogy for seven years during annual international conferences. It is confirmed that hospital pedagogy is one of the promising areas of scientific thought and an independent section of pedagogy, which received a modern sound in Russia in 2014 within the framework of the innovative project "We Teach/They Learn". The socio-educational component of hospital pedagogy is considered. Education in the conditions of hospital pedagogy is figuratively presented with the composition of complex musical works - a symphony of a full life. It is based on seven socio-educational notes of the symphony of hospital pedagogy

Keywords: educational potential, education through overcoming, hospital pedagogy, inclusion, additional education of children, integration of medicine and education.

Смысл жизни – процесс преодоления жизненных трудностей. Актуальность проблемы социально-воспитательного потенциала современной госпитальной педагогики определяется наличием рисков современной социализации: *риски для психического здоровья; риски для физического здоровья; риски для безопасности*

страны; риски социализации не снимаются воспитанием, хотя могут быть уменьшены; риски узковедомственного подхода к образованию. Значит, это дело не только системы образования, но всей социальной сферы государства и общества. Подтверждением этому служит возрождение на новом историческом витке цивилизации понятие «госпитальная педагогика». Вот уже в седьмой раз неравнодушные педагоги, медики, управленцы собрались в конце октября 2025 года на VII Всероссийскую конференцию с международным участием «УЧИМЗНАЕМ» – ЗАБОТЛИВАЯ ШКОЛА – 2025, что еще и еще раз выверить госпитальный вектор современной педагогики и медицины.

В данном контексте важно и *социально-воспитательное осмысление теории и практики госпитальной педагогики*, связанное с обучением и воспитанием детей, находящихся на длительном лечении в медицинских стационарах.

Современная госпитальная педагогика – это музыкально-философский образ симфония из семи нот: *время, исцеление, общение, забота, терпение, реабилитация, открытия*; а когда одна из них выпадает, тогда слышна какофония управленческого цинизма, формализма и равнодушия. Госпитальная педагогика - СИМфония «полноценности жизни». Госпитальная педагогика — это не только образование, это симфония *СИлы воли, надежды и веры* в будущее и большая тема *МУЖЕСТВА!*

Социально-воспитательная миссия госпитальной педагогики заключается в создании условий и возможности непрерывного физического, психического и социального развития ребёнка в условиях длительного пребывания в лечебном учреждении. Социально-воспитательная практика госпитальных школ убедительно подтверждает, что часто сердечное и заботливое взаимоотношение детей и взрослых в госпитальной школе помогает улучшить эмоциональное состояние растущего человека, способствует преодолевать болезни и улучшить свое физическое состояние. Социально-воспитательная значимость современной госпитальной педагогики, как подтверждает практика, способствует полноценной жизни ребёнка в период борьбы с тяжелой и длительной болезнью, его реабилитации, выздоровлению, социализации, воспитанию и успешному возвращению в обычную социально-образовательную среду. Воздействие педагога и родителей, направленное на воспитание ребенка, призвано вызвать соответствующее ему действие растущего человека, способствующее самовоспитанию. Отсюда следует, что методы воспитания бинарные.

Отрадно отметить, что сегодня благодаря проекту «УчимЗнаем» становится доступным образование средствами госпитальной педагогики, дающим возможность получения полноценного образования детьми, которые находятся на длительном лечении и не могут по состоянию здоровья посещать образовательные организации. Звучит нота ДО...ДОступность образования средствами госпитальной педагогики.

Главное ДОстояние и ДОстоинство госпитальной педагогики — это значимые неравнодушные люди: педагоги и медики... Госпитальный педагог – особый педагог, одна из особенностей заботливых педагогов - необходимость учитывать персональные траектории лечения и текущее состояние здоровья

своих подопечных детей школьного возраста, а также «глубокое знание позитивного и негативного начала в детской субкультуре». Для этого в госпитальной педагогике необходимы знания на стыке педагогики, педиатрии, психологии, нейропсихологии и других направлений.

Ключевая задача педагогов, работающих в госпитальной школе, сделать жизнь проходящего длительное лечение ребенка и его семьи полноценной. Нужны: *персонализированный подход, создание ситуации успеха, поддержка в осознании ценности жизни, формирование положительного опыта и др.* Госпитальных педагогов требуется необходимость постоянного контроля собственных эмоций, и при этом – честность, открытость и готовность реагировать на различные вызовы душевно и искренне.

Дополнительное образование детей = госпитальная педагогика. Приоритет в госпитальной педагогике должен быть отдан различным формам дополнительного образования детей. Госпитальная педагогика средствами дополнительного образования детей расширяет сферу понимания всеми педагогами каждого ребёнка, независимо от той жизненной ситуации, в которой он может оказаться. Современное Дополнительное образование детей - важный

Фактор стабилизации окружающего Мира для ребенка, формирования его мотивации к выздоровлению, дает новую возможность думать о будущем, создает тоненькую ниточку, протянутую к новым возможностям, к тому, что будет «потом».

Содержание Дополнительного образования, предлагаемого детям, рассчитано не только на учёт имеющихся ограничений, сколько на компенсацию недостающих возможностей. Этому способствуют функции Дополнительного образования в госпитальной школе: *образовательная* – обучение ребенка по дополнительным общеобразовательным программам, получение новых знаний; *компенсаторная* – освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования; *профессиональное определение* – формирование устойчивого интереса к социально значимым видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая предпрофессиональную и профессиональную подготовку; *креативная* – создание гибкой системы для реализации личностных творческих интересов личности; *рекреационная* – организация содержательного культурного досуга как сферы восстановления психофизических сил ребенка; *воспитательная* – формирование культурной среды, определение на этой основе четких нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к общезначимым ценностям; *социализационная* – освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни; *самореализации* – самоопределение ребенка в социально и культурно значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие; *здоровьеформирующая* – реабилитация и укрепление здоровья ребенка; *интеграционная* – создание единого социокультурного пространства госпитальной школы.

Речь может идти о содержательной основе педагогики госпитального ДОполнительного образования детей, параллельной уровням образования (семейному, дошкольному, школьному, среднему профессиональному). Тем более, что для современного ДОполнительного образования детей характерно наличие инклюзивного потенциала: *приучение ценить и понимать разницу между людьми, вместо того чтобы пытаться её изменить; стимулирование достижений, доказательство того, что все дети могут быть успешными, если им оказывать необходимую помощь, поддержку и сопровождение; возможность социализации в атмосфере сочувствия, равенства, сотрудничества; расширение профессиональных знаний педагогов, требующее новых и более гибких способов обучения, разработки дополнительных образовательных программ, максимально эффективных для всех детей* [1].

Для теории дополнительного образования детей в госпитальной школе одним из оснований является теория свободной школы и свободного воспитания К.Н. Венцеля, одного из исследователей внешкольного образования. Созданная К.Н. Венцелем «Декларация прав ребенка» является прообразом современной парадигмы дополнительного образования детей: *каждый ребенок имеет право на существование, на гарантированную совокупность жизненных условий, на бесплатное воспитание и образование, соответствующее его индивидуальности, на выбор воспитателей, на свободу и уважение* [2].

Параллельность дополнительного образования детей и его программ формализованному обучению, *благодаря* чему для каждого ребенка *они* становятся уникальной социально-воспитательной практикой само-открытия ценностей, целей, способов и результатов образования, приобретения навыков самостоятельности, сотрудничества, опыта общения, личностного и профессионального самоопределения, осознанного самовоспитания.

ДОминанта воспитания в госпитальной педагогике. В центре воспитания детей, находящихся на длительном лечении, лежит преодоление различных трудностей: длительной болезни, социальной изоляции, стресса, неопределённости и непредсказуемости развития ситуации, прерывания процесса обучения в школе, потери ребёнком уверенности в своём будущем. Вспомним и Н.И. Пирогова, врача и педагога, который стал инициатором идеи объединения усилий медицины и педагогики, считая, что совместной деятельностью врачей и педагогов можно эффективно бороться с некоторыми заболеваниями. Он обозначил идею объединения усилий медицины и педагогики тогда, когда «медицина одна не справляется», «направлению взаимодействия с больными необходимо обучать будущих медиков» [3].

Воспитание через преодоление. Ресурсы для этого: *актуализация возможностей детей к творчеству, широкое использование методов арттерапии, музыкотерапии, сказкотерапии, робототехники, лего-конструирования, радиотеатра для адаптации детей к изменившимся условиям жизни в период госпитализации, тренинги личностного роста, самопознания, развития коммуникативных навыков.*

Ещё К.Д. Ушинский проводил аналогии между педагогикой и медициной в деятельности умелого врача и опытного педагога: «*Леча больного, доктор*

помогает природе; точно так же и наставник должен только помогать воспитаннику бороться с трудностями постижения того или другого предмета; не учить, а только помогать учиться» [4].

Образ детства – самая радостная, счастливая и невозвратимая пора жизни человека. Современная социально-воспитательная стратегия госпитальной педагогики – любить и понимать ребенка. Борьба с длительной болезнью даёт понимание растущему человеку о ценности каждого прожитого дня, учит выстраивать приоритеты, обращает внимание на смыслы и ценности в его жизни, позволяющих найти основу и силы к преодолению трудной жизненной ситуации. Ребенок, находясь на длительном лечении, погружается в воспитательное пространство госпитальной педагогики, которое помогает им, хотя бы в течение нескольких лет, познать радость детства, уважение личности и прав ребенка.

Таким образом в современной практике госпитальной педагогики реализуется ключевая педагогическая идея Януша Корчака - безусловное понимание жизненной Ситуации каждого ребенка, особая чуткость к состоянию ребенка как пациента детской больницы без излишней жалости, уважение к личности, именно все это делает социально-воспитательное пространство госпитальной школы в стенах детской больницы комфортным и притягательным для детей.

Миссия проекта «УчимЗнаем» направлена на РЕализацию конституционного права на образование детей, находящихся на длительном лечении в стационарах медицинских учреждений, посредством создания интегрированной образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья как среды для реализации неограниченных возможностей личности и полноценной медико-социальной реабилитации болеющих детей совместно с членами их семей. Идет постоянный поиск решений для доступности и результативности образования для детей, не посещающих школу по причине длительной болезни, преодоления существующего образовательного неравенства, реализации потенциала личностно-персонифицированного образования, создания условий и возможностей, способствующих личному темпу ребенка в освоении образовательных программ, восполнению пробелов и повышению мотивации.

Ценностно-смысловые ориентиры в образовании – основа устойчивого развития госпитальной педагогики с приоритетом личности РЕбенка. Воспитание в госпитальной педагогике — это особым образом организованная жизнедеятельность детей, находящихся на длительном лечении. Главная цель — сохранение жизни ребёнка, изменение качества жизни детей и их семей. Госпитальная школа содействует переключению ребёнка с постоянных мыслей о болезни и лечении, и таким образом вернуть повседневный ритм жизнедеятельности.

РЕтроспектива госпитальной педагогики имеет свой социально-воспитательный потенциал. В отечественной педагогике обучение и воспитание «особых» детей как проблема острого социально-педагогического характера была поставлена в еще начале XX в. в работах В.П. Кащенко и других ученых.

Всеволод Петрович писал: *«Одно дело – безнадежное с медицинской точки зрения состояние..., это в компетенции врачей-специалистов, а другое – такие дети нуждаются в лечебной педагогике, синтезе медико-терапевтических, учебно-педагогических и воспитательных приемов, имеющих коррекционную направленность»* [5].

Нота МИ связана с отражением МИссия госпитальной педагогики: *забота - исцеление - реабилитация - обучение – открытия*. А это: преодоление негативных последствий длительного лечения, создание комфортной образовательной (воспитательной) среды, поддержка и сопровождение Реабилитации, а главное формирование событийности прожитого дня жизни ребёнка.

Главными МИссионерами госпитальной педагогики стали *Евгений Александрович Ямбург, Александр Григорьевич Румянцев и Сергей Витальевич Шариков* — три специалиста-профессионала, которые объединили свой профессиональный психолого-педагогический и медицинский опыт и создали проект госпитальных школ в России.

МИссионерами выступают и педагоги госпитальной школы, осуществляющими МИссию госпитальной педагогики. Именно от них зависит обеспечение непрерывности физического, психического и социального развития детей в условиях длительного лечения в медицинских организациях.

Благодаря их уникальности госпитальная педагогика выступает ФАктором жизни. Госпитальная педагогика, как ФАктор жизни, играет значимую роль в жизнедеятельности и жизнестойкости детей, находящихся на длительном лечении, способствуя их реабилитации, адаптации и социализации как в процессе обучения и лечения, так и после болезни.

Госпитальная школа становится сегодня ФАктором воспитания юного россиянина в социальной среде и организации всей его жизни, помогая осознать ее ценность.

Ключевую роль в госпитальной школе играет госпитальный педагог как нота СОЛЬ госпитальной педагогики. Именно он окружает РЕбенка любовью, заботой и ненавязчивым вниманием, поддерживая и сопровождая их в условиях длительного лечения. Госпитальный педагог: осуществляет постоянное взаимодействие с ребёнком, его семьей и медицинским персоналом, контролирует свои эмоции, проявляя при этом искренность, честность, открытость и готовность искренне реагировать на различные вызовы и барьеры, обладает углублёнными знаниями, владение базовыми методами дефектологии, учитывая, что у многих детей в ходе лечения наблюдаются нарушения когнитивных и регулятивных функций, у него развиты коммуникативные навыки, умение коммуницировать с разными людьми: детьми, медицинским персоналом, коллегами, родителями [6].

Нота ЛЯ связана с некоторыми ЛЯпами (проблемами), имеющимися в деятельности госпитальной школы: неготовность отойти от общей установки на достижения и академическую успешность, недостаточность знаний о формах, технологиях и методах взаимодействия с детьми, требующих особого подхода, сложности с налаживанием коммуникации, Не владение грамотными

коммуникативными навыками и не умение их транслировать, проблемы с РЕинтеграцией.

Очень важно с детьми в госпитальной школе разговаривать и чувствовать, готовы они к занятиям в конкретный момент или нет.

Нота СИ определяет СИстему госпитального образования и госпитальной педагогики, которая охватывает ключевые этапы развития: дошкольную подготовку, программы школьного и дополнительного образования детей. Особенности СИстемы госпитального образования: персональность, личностно-персонифицированный подход, акцент на посильную нагрузку, РЕабилитационный потенциал внеаудиторной деятельности, внешкольного воспитания и дополнительного образования детей, наличие связи с родной школой [7].

СИстема госпитальной педагогики направлена на обеспечение не только образовательного (дидактического) процесса, но и способствует социально-воспитательной, медико-социальной реабилитации и адаптации детей. СИстема госпитальной педагогики опирается на СИнергитический подход в госпитальной педагогике. СИнергия госпитальной педагогики проявляется в объединение ресурсов семьи, больницы и школы [8].

Медицинская организация предоставляет помещения для образовательной деятельности, рекомендации врачей по содержанию и объёму учебной нагрузки, корректировку образовательной программы с учётом текущего состояния здоровья ребенка.

Образовательная организация объединяет свои ресурсы: педагогические кадры, рабочие учебные программы, средства обучения, дидактические материалы, электронные образовательные ресурсы и другое.

Семья выступает первичным агентом социализации детей, одним из основных ресурсов материальной и психоэмоциональной поддержки.

Организаторы и участники флагманской площадки проекта «УчимЗнаем» выступают образцом поведения и ведения своей деятельности. Различные разработки и материалы флагманской площадки полезны и применимы для педагогов и руководителей региональных площадок.

Госпитальная школа – это хрупкий музыкальный инструмент. Дисгармония в воспитании – вещь не редкая, поэтому чтобы добиться лада, приходится вертеться на все лады, иначе строя не добьешься. Желаем всем организаторам госпитальной педагогики, чтобы в симфонии госпитальной педагогики, основанной на гармонии любящих сердец, никогда не звучало ФАльшивых нот формализма, имитации и фальши. Пусть в мелодии госпитальной педагогики никогда не врывается дикая, безумная какофония равнодушия, бессердечности, бюрократизма. Пусть Ваши сердца всегда бьются в унисон!

Литература

1. Голованов, В.П. Инклюзивный потенциал современного дополнительного образования детей / В.П. Голованов // Дополнительное образование и воспитание. – 2015. – № 1. – С. 3-7.

2. Венцель, К.Н. Декларации прав ребенка (25 сентября 1917 г.) / К.Н. Венцель // Свободное воспитание и свободная школа. – 1918. – № 1-3. – С. 15-19.
3. Пирогов, Н.И. Вопросы жизни / Н.И. Пирогов // Избранные педагогические сочинения. – М.: Педагогика. – 1985. – 496 с.
4. Ушинский, К.Д. Человек как предмет воспитания: Опыт педагогической антропологии / К.Д. Ушинский. – М.: Педагогика. – 1990. – Т. 5. – 528 с.
5. Кащенко, В.П. Педагогическая коррекция: Испр. недостатков характера у детей и подростков: Кн. для учителя. / В.П. Кащенко. – М.: Просвещение. – 1994. – 178 с.
6. Шевелева, Д.Е. Профессиональная подготовка и компетенции педагогов для работы в госпитальных школах. / Д.Е. Шевелева // Коррекционно-педагогическое образование. – 2025. – № 2. – С. 34-41.
7. Шариков, С.В. Госпитальная педагогика как мотивация развития прогрессивного сознания общества и социальной инклюзии / С.В. Шариков, Т.В. Волкова // Современное дошкольное образование: теория и практика. Электронный журнал. – 2023. – № 10. – С. 2–23.
8. Лоскутов, А.Ф. Госпитальная педагогика как современное направление в педагогической науке / А.Ф. Лоскутов, С.В. Шариков, Е.А. Ямбург, А.Г. Румянцев // Народное образование. – 2023. – №1. – С. 166-173.

References

1. Golovanov, V.P. Inklyuzivny`j potencial sovremennogo dopolnitel`nogo obrazovaniya detej / V.P. Golovanov // Dopolnitel`noe obrazovanie i vospitanie. – 2015. – № 1. – S. 3-7.
2. Vencel`, K.N. Deklaracii prav rebenka (25 sentyabrya 1917 g.) / K.N. Vencel` // Svobodnoe vospitanie i svobodnaya shkola. – 1918. – № 1-3. – S. 15-19.
3. Pirogov, N.I. Voprosy` zhizni / N.I. Pirogov // Izbranny`e pedagogicheskie sochineniya. – M.: Pedagogika. – 1985. – 496 s.
4. Ushinskij, K.D. Chelovek kak predmet vospitaniya: Opy`t pedagogicheskoy antropologii / K.D. Ushinskij. – M.: Pedagogika. – 1990. – T. 5. – 528 s.
5. Kashhenko, V.P. Pedagogicheskaya korrekciya: Ispr. nedostatkov haraktera u detej i podrostkov: Kn. dlya uchitelya. / V.P. Kashhenko. – M.: Prosveshhenie. – 1994. – 178 s.
6. Sheveleva, D.E. Professional`naya podgotovka i kompetencii pedagogov dlya raboty` v gospital`ny`x shkolax. / D.E. Sheveleva // Korrekcionno-pedagogicheskoe obrazovanie. – 2025. – № 2. – S. 34-41.
7. Sharikov, S.V. Gospital`naya pedagogika kak motivaciya razvitiya progressivnogo soznaniya obshhestva i social`noj inklyuzii / S.V. Sharikov, T.V. Volkova // Sovremennoe doshkol`noe obrazovanie: teoriya i praktika. E`lektronny`j zhurnal. – 2023. – № 10. – S. 2–23.
8. Loskutov, A.F. Gospital`naya pedagogika kak sovremennoe napravlenie v pedagogicheskoy nauke / A.F. Loskutov, S.V. Sharikov, E.A. Yamburg, A.G. Rumyancev // Narodnoe obrazovanie. – 2023. – №1. – S. 166-173.

УДК 342.733

**НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО
ДОСТУПНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ,
НУЖДАЮЩИХСЯ В ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ**

Рыбакова Ольга Сергеевна

кандидат юридических наук

доцент кафедры конституционного и муниципального права

ФГАОУ ВО «Московский государственный

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

orro21@yandex.ru

**REGULATORY AND LEGAL SUPPORT FOR THE CONSTITUTIONAL
RIGHTS OF CHILDREN IN NEED OF LONG-TERM TREATMENT TO
QUALITY AND ACCESSIBLE EDUCATION**

Rybakova Olga Sergeevna

Cand. Sci. (Law)

Associate professor of the Department of Constitutional and

Municipal Law of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL)

orro21@yandex.ru

Аннотация. Автором представлен анализ конституционных и законодательных положений, обеспечивающих систему государственных гарантий реализации прав детей, нуждающихся в длительном лечении, в сфере образования. Обозначены основные проблемы, требующих законодательных решений, в частности, необходимость закрепления понятия «длительное лечение». Акцентируется внимание на принципах неделимости и взаимообусловленности прав ребёнка, которые в системном единстве не допускают противопоставление и конкурентную реализацию одних прав в ущерб другим. Права ребёнка составляют важнейший социальный институт, объективно отражающий возможности его дальнейшей интеграции в общество.

Ключевые слова: социальное государство, конституционные гарантии, право на охрану здоровья, право на доступ к медицинской помощи, право на образование, образовательная политика, госпитальные школы, длительное лечение.

Abstract. The author presents an analysis of the constitutional and legislative provisions that ensure the system of state guarantees for the implementation of the rights of children in need of long-term treatment in the field of education. The main issues that require legislative solutions are identified, including the need to define the concept of "long-term treatment." The article emphasizes the principles of the indivisibility and interdependence of children's rights, which, when considered as a

system, do not allow for the juxtaposition or competitive implementation of certain rights at the expense of others. Children's rights constitute a crucial social institution that objectively reflects their potential for further integration into society.

Keywords: social state, constitutional guarantees, right to health protection, right to medical care, right to education, educational policy, hospital schools, long-term treatment

Закрепленный в российской Конституции принцип высшей ценности человека, его прав и свобод (ст. 2), который согласуется со статусом социального государства, определяющий приоритеты социально ориентированной политики, обеспечивающей достойную жизнь и свободное развитие индивида (ч. 2 ст.7), реализуется через систему гарантий обеспечения и защиты обозначенных конституционных ценностей. Данный подход не только отражает обязательства государства в социальной сфере, но выступает ключевым фактором социальной стабильности и устойчивого развития страны. В ходе конституционной реформы 2020 получила закрепление важная гарантия реализации прав ребёнка в форме обязанности государства по созданию условий для его жизнеобеспечения и всестороннего развития. Законом о поправке к Конституции Российской Федерации [1] добавлена новая статья – 67.1, где в части четвертой закреплена норма, о том, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России, что свидетельствует о признании факта, что защита и охрана прав ребёнка являются важнейшими векторами государственной политики, стратегическими целями развития государства.

Права человека (ребёнка) носят неделимый характер, составляют важнейший социальный институт, объективно отражающий возможности его дальнейшей интеграции в общество. В конституционном дискурсе права ребёнка рассматриваются в контексте прав человека [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7], принадлежащие каждому от рождения, вне зависимости от социального происхождения, состояния здоровья, места жительства, возможностей родителей (лиц, их заменяющих) и иных обстоятельств. Ребёнок, в силу его возрастных, физиологических особенностей нуждается в особой защите со стороны родителей, общества и государства. Принадлежащие с рождения каждому ребёнку права – право на жизнь (ч. 1 ст. 20), защиту достоинства (ст. 21), на свободу, личную неприкосновенность (ч. 1 ст. 22), защиту частной жизни (ч. 1 ст. 23), право на информацию (ст. 29), право на свободное использование своих способностей (ст. 34, ч. 1), право на труд и отдых (ст. 37), право на социальное обеспечение (ст. 39), право на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41), право на образование (ст. 43) и др. обеспечиваются системой гарантий их реализации.

Принципы неделимости и взаимообусловленности прав предполагают, что все права носят одинаково важный для ребёнка характер, исключая противопоставление и конкурентную реализацию одних прав в ущерб другим. Эффективная реализация прав – гарантия доступа к законным формам реализации интересов ребёнка, духовным и материальным благам, в также возможностям его физического, духовного, нравственного, интеллектуального

развития, сохранения достоинства. Данный подход корреспондирует положениям Конвенции о правах ребенка [8], которая обязывает подписавшие её государства формировать систему гарантий обеспечения каждому ребёнку необходимых для его благополучия заботу, что предполагает их институционализацию и государственно-правовое обеспечение.

В целях обеспечения права ребёнка на образование принят целый ряд нормативных правовых актов, которые в системном единстве направлены на достижение основной цели социального государства – создание благоприятных условий для получения каждым ребёнком образования: Федеральный закон № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» [9] (далее – Федеральный закон о гарантиях прав ребёнка), Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [10] (далее – Федеральный закон об образовании), Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [11] и др.

Федеральным законом об образовании названы базовые принципы образовательной политики, среди которых: обеспечение права каждого на образование, недопустимость дискриминации в сфере образования; приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития; единство образовательного пространства свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека; создание условий для самореализации человека, свободное развитие его способностей; адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека; поддержка различных форм образования и самообразования с учетом интересов и потребностей человека (ст. 3), что обеспечивается путем создания федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления соответствующих социально-экономических условий для его получения, расширения возможностей удовлетворять потребности человека в получении образования различных уровня и направленности в течение всей жизни (ст. 5). Важнейшей функцией Российской Федерации как социального государства является обеспечение права каждого на образование, в том числе основное общее, бесплатность и общедоступность которого в государственных или муниципальных образовательных учреждениях гарантируется (ч. 1 и 2 ст. 43 Конституции РФ) на основе конституционного принципа юридического равенства.

Содержание принципа доступности образования нами предлагается рассматривать в трех аспектах: *территориальная доступность*, предполагающая близость нахождения образовательной организации к месту проживания ребёнка; *физическая доступность* – создание безбарьерной среды для детей с особыми потребностями, имеющих особенности здоровья и развития; *социально-экономическая доступность*, исключающая взимание платы на образовательные услуги, предоставляемые в рамках государственных образовательных стандартов; *информационная доступность*, предполагающая наличие актуальной достоверной информации о возможностях обучения, размещенной в открытом доступе с целью информирования родителей (лиц, их

заменяющих) и детей. По своему содержанию право на общедоступное и бесплатное основное общее образование в системной связи с конституционными принципами равенства и социальной справедливости означает, что каждый ребёнок, в том числе, находящийся на длительном лечении, имеет равную с другими детьми возможность получения образования, соответствующего уровня.

В соответствии с требованиями ст. 41 (ч. 5 и 6), ст. 66 (ч. 10 и 11) Федерального закона № 273-ФЗ, порядок регламентации отношений, возникающих в связи с обучением ребёнка, нуждающегося в длительном лечении, определяется нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и осуществляется из средств региональных бюджетов, выделенных на образование. Проведенный нами мониторинг региональных актов позволяет констатировать неоднородность положений о перечне государственных гарантий в сфере обучения таких детей. Так, например, в Московской области закреплено положение об обязанности образовательной организации предоставить в бесплатное пользование учебники и учебные пособия, иную учебную литературу, имеющуюся в библиотеке образовательной организации; осуществлять кадровое обеспечение образовательной деятельности; оказывать психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь обучающимся; осуществлять аттестацию ребёнка, выдать успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию документ об образовании (п. 8) [12]. В аналогичных актах многих других субъектов Российской Федерации подобные положения не получили закрепления, что, полагаем, может способствовать снижению качества образования, ограничению права на доступную образовательную среду, отвечающей принципам конституционного равенства и социальной справедливости. Государственные гарантии в сфере образования не должны трансформироваться в сторону минимизации в зависимости от финансовых возможностей региона проживания ребёнка.

Как правило, региональные акты, регулирующие отношения в сфере организации обучения детей, нуждающихся в длительном лечении, распространяют свое действие и на детей-инвалидов [13; 14]. Вместе с тем, следует констатировать, что дети, нуждающиеся в длительном лечении не отнесены законодателем к категориям детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, перечисленных в абзаце третьем статьи 1 Федерального закона о гарантиях прав ребёнка, как, например, дети – инвалиды и дети с ОВЗ, что ставит их в неравное положение с другими пациентами, нуждающимся в длительном лечении. Полагаем, было бы целесообразным, закрепить актом Правительства Российской Федерации содержание понятия «длительное лечение», после чего рассмотреть возможность включения детей, нуждающихся в таком лечении, в категорию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

По смыслу статьи 43 Конституции РФ, родители (лица, их заменяющие) обязаны обеспечить получение ребёнком основного общего образования (ч. 4), что согласуется с их правом и основной обязанностью по его воспитанию (ч. 2 ст. 38), формированию основ его физического, нравственного и интеллектуального развития. Тем самым, основная обязанность по обеспечению

образования ребёнку лежит на его родителях (лиц, их заменяющих), которые имеют право на выбор методов и форм обучения, образовательной организации для своего ребёнка с учетом его мнения. Если в силу объективных обстоятельств состояние здоровья ребёнка требует длительного лечения, то перед родителями стоят минимум две важные задачи: во-первых, обеспечить ребёнку скорейшее выздоровление, во-вторых, создать условия для получения ребёнком необходимого образования в соответствии с возрастом и особенностями развития. При этом, как было отмечено выше, право на охрану здоровья и право на образование не должны конкурировать между собой, являясь одинаково важными для ребёнка.

Законодатель определил несколько вариантов получения образования ребёнком, нуждающимся в длительном лечении. В соответствии с положениями Федерального закона об образовании, для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном лечении, образование может быть организовано в следующих формах: путем посещения специальной образовательной организации (в т.ч. санаторной), в которой для ребёнка одновременно проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия; в форме обучения на дому (в случае наличия заболевания, входящего в Перечень, утверждаемый Минздравом России [15]); обучение по месту пребывания ребёнка в медицинской организации (ч. 5, ст. 41). Перевод ребёнка на указанные формы осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей).

Каждая из трех моделей требует выполнения алгоритма коммуникации между родителями ребёнка (лицами их заменяющими), медицинской организацией и образовательной организацией, к которой прикреплен ребёнок. Совместно с родителями документально определяются (например, в договоре) следующие важные элементы образовательного процесса: форма обучения и индивидуальный учебный план, расписание занятий и режим обучения; особые образовательные потребности ребёнка, обусловленные лечением и текущим состоянием здоровья; способы информирования родителями школы о перемещении ребёнка в стационары; порядок информирования о результатах обучения и корректировках индивидуального учебного плана; формы социальной поддержки ребёнка со стороны участников образовательного процесса и др. Любой из перечисленных элементов может быть скорректирован с учетом состояния здоровья и индивидуальных потребностей ребёнка, что может быть закреплено в положениях регионального подзаконного акта. Так, например, в Свердловской области, согласно акту регионального правительства, «продолжительность учебных занятий по индивидуальному учебному плану может быть изменена с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося, рекомендаций медицинской организации, психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии)» [16].

Согласимся со специалистами, что обучение ребёнка, нуждающегося в длительном лечении, имеет ряд особенностей. Во-первых, дети данной категории нуждаются в построении индивидуального образовательного маршрута, который

должен учитывать, как требования программы, предусмотренной образовательным стандартом, так и рекомендации лечащего врача, с учетом состояния здоровья обучающегося. Во-вторых, получение образования во время лечения является важным звеном социальной и психологической реабилитации, способствующим профилактике социальной депривации и дезадаптации пациента. В-третьих, на практике имеются случаи, когда после завершения лечения при наступлении ремиссии, благодаря правильно выстроенной персонализации и индивидуализации образовательного процесса, ребенок без потерь возвращается в свою родную школу [17, 18, 19].

В связи с чем заслуживают положительной оценки, подготовленные при участии Проектного офиса Проекта госпитальных школ «УчимЗнаем» и Лаборатории междисциплинарных исследований ФГБНУ «Институт возрастной физиологии Российской академии образования», Разъяснения по вопросам организации обучения детей, нуждающихся в длительном лечении <...> [20], которые содержат рекомендации по организации образовательного пространства для таких детей. Документом предлагается определение понятия обучающегося, нуждающегося в длительном лечении, под которым понимается «обучающийся, осваивающий основные общеобразовательные и (или) дополнительные программы, которому по заключению медицинской организации проводится лечение или медицинская реабилитация продолжительностью более 21 дня в медицинских организациях или на дому». Авторами документа выделяется две категории детей, которые могут нуждаться в длительном лечении, что обуславливается созданием специальных условий для каждой из них. К первой группе пациентов отнесены дети с хроническими соматическими заболеваниями, проходящие лечение в онкологических, гематологических, иммунологических медицинских центрах, центрах трансплантологии и пересадки органов, туберкулезных диспансерах и других. Ко второй – дети, имеющие психические расстройства и расстройства поведения, болезни нервной системы, образовательный процесс которых строится на принципах и содержании коррекционной педагогики и специальной психологии, а обучение, как правило, ведется в соответствии с федеральной адаптированной основной общеобразовательной программой обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (раздел 2). Данный подход к формированию благоприятной для обучающихся образовательной среды требует соответствующего кадрового обеспечения, подготовки специалистов, умеющих выстраивать индивидуальную траекторию обучения, своевременно и адекватно реагировать на состояние здоровья ребёнка.

Подводя итог, следует обратить внимание на то, что нормативное обеспечение прав ребёнка в сфере образования должно носить сбалансированный характер, отвечать принципу правовой определенности и социальной справедливости. В связи с чем, можно прогнозировать дальнейшее развитие российского законодательства в направлении укрепления системы государственных гарантий, обеспечивающих каждому ребёнку, нуждающемуся в длительном лечении, доступной и качественной образовательной среды с учетом

особенностей его здоровья и индивидуальных потребностей, защиты его прав и интересов, способствующих его полноценному жизнеобеспечению и развитию.

Литература

1. Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» // Собрание законодательства РФ, 16.03.2020, № 11, ст. 1416. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346019/ (Дата обращения 29.11.2025).
2. Рыбаков, О.Ю. Безопасность детства: социальные проблемы и правовые способы их решения / О.Ю. Рыбаков, Е.А. Антонян, Э.И. Атагимова, Ю.Ф. Беспалов [и др.]. – М.: ООО «Проспект». – 2021. – 424 с.
3. Борисова, Н.Е. Конституционные приоритеты защиты прав ребенка / Н.Е. Борисова // Вестник МГПУ. Серия: Юридические науки. – 2015. – № 4(20). – С. 55-62.
4. Борисова, Н.Е. Дети как приоритет государственной политики в свете конституционной реформы 2020 года / Н.Е. Борисова // Вестник МГПУ. Серия: Юридические науки. – 2021. – № 1(41). – С. 71-77.
5. Мустафина, Л.Р. Детство как элемент конституционно-правового пространства Российской Федерации / Л.Р. Мустафина // Евразийский юридический журнал. – 2024. – № 6(193). – С. 122-123.
6. Ростова, О.С. Правовая охрана материнства и детства в Советском государстве : дис. канд. юрид. наук : 12.00.01 / Ростова Ольга Сергеевна. – Саратов. – 2007. – 213 с.
7. Рыбакова, О.С. Детство – конституционная ценность и категория конституционного права / О.С. Рыбакова // Детство – территория безопасности: Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Москва, 19–20 декабря 2024 года. – М., Саратов: Издательство «Саратовский источник». – 2024. – С. 32-36.
8. Конвенция о правах ребенка, принята Резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1989 // Ведомости Съезда НД СССР и ВС СССР, № 45, 1990, ст. 955. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/ (Дата обращения 29.11.2025).
9. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (в ред. от 04.11.2025) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, № 31, 03.08.98, ст. 3802. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/ (Дата обращения 29.11.2025).
10. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 15.10.2025) «Об образовании в Российской Федерации». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (Дата обращения 29.11.2025).

11. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (в ред. от 01.09.2025) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации, № 48, 28.11.2011, ст. 6724. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/ (Дата обращения 29.11.2025).

12. Порядок регламентации и оформления отношений государственной образовательной организации Московской области и муниципальной образовательной организации в Московской области и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, утв. приказом министра образования Московской области от 26.02.2014 № 780. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/537995794?ysclid=mi680ervt1744802828> (Дата обращения 13.09.2025).

13. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 09.12.2013 № 585 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части организации обучения по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских организациях». – URL: <https://base.garant.ru/17763024/> (Дата обращения 29.11.2025).

14. Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 13.12.2021 № 3723, приказ Министерства здравоохранения Краснодарского края от 13.12.2021 № 7158 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной общеобразовательных организаций и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях». – URL: <https://base.garant.ru/403210330/> (Дата обращения 29.11.2025).

15. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 июня 2016 г. №436н «Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным общеобразовательным программам на дому». – URL: <https://base.garant.ru/71449638/> (Дата обращения 29.11.2025).

16. Постановление Правительства Свердловской области от 11.06.2025 № 318-ПП «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной образовательной организации Свердловской области и муниципальной образовательной организации с обучающимися, нуждающимися в длительном лечении, детьми-инвалидами и (или) их родителями (законными представителями) в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях». – URL: <https://base.garant.ru/412164566/> (Дата обращения 29.11.2025).

17. Шариков, С.В. Педагогическая поддержка образовательных возможностей детей, находящихся на длительном лечении в медицинских

стационарах / С.В. Шариков // Альманах Института коррекционной педагогики. – 2020. – № 40. – С. 22-42.

18. Гусев, И.А. Карта индивидуальных особых потребностей обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, как инструмент построения образовательного маршрута ученика госпитальной школы: выявление психолого-педагогических характеристик / И.А. Гусев, И.Ю. Долуев, Е.С. Зорина, Д.А. Соловьев // Перспективы науки и образования. – 2024. – № 2(68). – С. 488-512.

19. Долуев, И.Ю. Российская модель госпитальных школ / И.Ю. Долуев // Вестник Мининского университета. – 2025. – Т. 13. – № 1(50). – С. 1-7.

20. Разъяснения по вопросам организации обучения по основным общеобразовательным и дополнительным общеразвивающим программам для детей, нуждающихся в длительном лечении в медицинских организациях / письмо Минпросвещения России №ТВ-1693/03, Минздрава России №1/и/2-15398 от 24.08.2023. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_455872/ (Дата обращения 25.11.2025).

References

1. Zakon RF o popravke k Konstitucii RF ot 14.03.2020 № 1-FKZ «Osovershenstvovaniy regulirovaniya otdel'ny'x voprosov organizacii ifunkcionirovaniya publichnoj vlasti» // Sobranie zakonodatel'stva RF, 16.03.2020. № 11, st. 1416. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346019/ (Accessed 29.11.2025).

2. Ry'bakov, O.Yu. Bezopasnost' detstva: social'ny'e problemy i pravovy'e sposoby ix resheniya / O.Yu. Ry'bakov, E.A. Antonyan, E'.I. Atagimova, Yu.F. Bepalov [i dr.]. – M.: ООО «Prospekt». – 2021. – 424 s.

3. Borisova, N.E. Konstitucionny'e priority' zashhity prav rebenka / N.E. Borisova // Vestnik MGPU. Seriya: Yuridicheskie nauki. – 2015. – № 4(20). – S. 55-62.

4. Borisova, N.E. Deti kak prioritet gosudarstvennoj politiki v svete konstitucionnoj reformy 2020 goda / N.E. Borisova // Vestnik MGPU. Seriya: Yuridicheskie nauki. – 2021. – № 1(41). – S. 71-77.

5. Mustafina, L.R. Detstvo kak e'lement konstitucionno-pravovogo prostranstva Rossijskoj Federacii / L.R. Mustafina // Evrazijskij yuridicheskij zhurnal. – 2024. – № 6(193). – S. 122-123.

6. Rostova, O.S. Pravovaya oxrana materinstva i detstva v Sovetskom gosudarstve : dis. kand. yurid. nauk : 12.00.01 / Rostova Ol'ga Sergeevna. – Saratov. – 2007. – 213 s.

7. Ry'bakova, O.S. Detstvo – konstitucionnaya cennost' i kategoriya konstitucionnogo prava / O.S. Ry'bakova // Detstvo – territoriya bezopasnosti: Materialy VII Vserossijskoj nauchno-prakticheskoy konferencii s mezhdunarodny'm uchastiem, Moskva, 19–20 dekabrya 2024 goda. – M., Saratov: Izdatel'stvo «Saratovskij istochnik». – 2024. – S. 32-36.

8. Konvenciya o pravax rebenka, prinyata Rezolyuciej 44/25 General'noj Assamblei OON ot 20.11.1989 // Vedomosti S'ezda ND SSSR i VS SSSR. – № 45, 1990, st. 955. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/ (Accessed 29.11.2025).

9. Federal'nyj zakon ot 24.07.1998 № 124-FZ (v red. ot 04.11.2025) «Ob osnovnyx garantiyax prav rebenka v Rossijskoj Federacii» // Sobranie zakonodatel'stva RF, № 31, 03.08.98, st. 3802. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/ (Accessed 29.11.2025).

10. Federal'nyj zakon ot 29.12.2012 № 273-FZ (red. ot 15.10.2025) «Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (Accessed 29.11.2025).

11. Federal'nyj zakon ot 21.11.2011 № 323-FZ (v red. ot 01.09.2025) «Ob osnovax ohrany zdorov'ya grazhdan v Rossijskoj Federacii» // Sobranie zakonodatel'stva Rossijskoj Federacii, № 48, 28.11.2011, st. 6724. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/ (Accessed 29.11.2025).

12. Poryadok reglamentacii i оформleniya otnoshenij gosudarstvennoj obrazovatel'noj organizacii Moskovskoj oblasti i municipal'noj obrazovatel'noj organizacii v Moskovskoj oblasti i roditel'j (zakonnyx predstavitelej) obuchayushhixsya, nuzhdayushhixsya v dlitel'nom lechenii, a takzhe detej-invalidov, v chasti organizacii obucheniya po osnovny'm obshheobrazovatel'ny'm programmam na domu ili v medicinskix organizacijax, utv. prikazom ministra obrazovaniya Moskovskoj oblasti ot 26.02.2014 № 780. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/537995794?ysclid=mi680ervt1744802828> (Accessed 13.09.2025).

13. Postanovlenie Pravitel'stva Respubliki Bashkortostan ot 09.12.2013 № 585 «Ob utverzhdenii Poryadka reglamentacii i оформleniya otnoshenij gosudarstvennoj ili municipal'noj obrazovatel'noj organizacii s obuchayushhimisya i (ili) ix roditelyami (zakonny'mi predstavitelyami) v chasti organizacii obucheniya po obrazovatel'ny'm programmam nachal'nogo obshhego, osnovnogo obshhego i srednego obshhego obrazovaniya na domu ili v medicinskix organizacijax». – URL: <https://base.garant.ru/17763024/> (Accessed 29.11.2025).

14. Prikaz Ministerstva obrazovaniya, nauki i molodezhnoj politiki Krasnodarskogo kraja ot 13.12.2021 № 3723, prikaz Ministerstva zdravooxraneniya Krasnodarskogo kraja ot 13.12.2021 № 7158 «Ob utverzhdenii Poryadka reglamentacii i оформleniya otnoshenij gosudarstvennoj i municipal'noj obshheobrazovatel'nyx organizacij i roditel'j (zakonnyx predstavitelej) obuchayushhixsya, nuzhdayushhixsya v dlitel'nom lechenii, a takzhe detej-invalidov v chasti organizacii obucheniya po obshheobrazovatel'ny'm programmam na domu ili v medicinskix organizacijax». – URL: <https://base.garant.ru/403210330/> (Accessed 29.11.2025).

15. Prikaz Ministerstva zdravooxraneniya RF ot 30 iyunya 2016 g. №436n «Ob utverzhdenii perechenya zabolevanij, nalichie kotoryx daet pravo na obuchenie

po osnovny'm obshheobrazovatel'ny'm programmam na domu». – URL: <https://base.garant.ru/71449638/> (Accessed 29.11.2025).

16. Postanovlenie Pravitel'stva Sverdlovskoj oblasti ot 11.06.2025 № 318-PP «Ob utverzhdenii Poryadka reglamentacii i oformleniya otnoshenij gosudarstvennoj obrazovatel'noj organizacii Sverdlovskoj oblasti i municipal'noj obrazovatel'noj organizacii s obuchayushhimisya, nuzhdayushhimisya v dlitel'nom lechenii, det'mi-invalidami i (ili) ix roditelyami (zakonny'mi predstavatelyami) v chasti organizacii obucheniya po osnovny'm obshheobrazovatel'ny'm programmam na domu ili v medicinskix organizacijax». – URL: <https://base.garant.ru/412164566/> (Accessed 29.11.2025).

17. Sharikov S.V. Pedagogicheskaya podderzhka obrazovatel'ny'x vozmozhnostej detej, naxodyashhixsya na dlitel'nom lechenii v medicinskix stacionarax / S.V. Sharikov // Al'manax Instituta korrekcionnoj pedagogiki. – 2020. – № 40. – S. 22-42.

18. Gusev, I.A. Karta individual'ny'x osoby'x potrebnostej obuchayushhixsya, nuzhdayushhixsya v dlitel'nom lechenii, kak instrument postroeniya obrazovatel'nogo marshruta uchenika gospital'noj shkoly': vy'yavlenie psixologo-pedagogicheskix xarakteristik / I.A. Gusev, I.Yu. Doluev, E.S. Zorina, D.A. Solov'ev // Perspektivy nauki i obrazovaniya. – 2024. – № 2(68). – S. 488-512.

19. Doluev, I.Yu. Rossijskaya model' gospital'ny'x shkol / I.Yu. Doluev // Vestnik Mininskogo universiteta. – 2025. – T. 13, № 1(50). – S. 1-7.

20. Raz'yasneniya po voprosam organizacii obucheniya po osnovny'm obshheobrazovatel'ny'm i dopolnitel'ny'm obshherazvivayushhim programmam dlya detej, nuzhdayushhixsya v dlitel'nom lechenii v medicinskix organizacijax / pis'mo Minprosveshheniya Rossii №TV-1693/03, Minzdrava Rossii №1/i/2-15398 ot 24.08.2023. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_455872/ (Accessed 25.11.2025).

УДК 159.9.07

**ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РЕИНТЕГРАЦИЯ
ДЕТЕЙ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОСЛЕ
ДЛИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ**

Куртанова Юлия Евгеньевна
кандидат психологических наук
ФГБОУ ВО МГППУ
заведующий кафедрой
kurtanovayue@mgppu.ru

**PSYCHOLOGICAL, PEDAGOGICAL AND SOCIAL REINTEGRATION OF
CHILDREN WITH CANCER AFTER LONG-TERM TREATMENT**

Kurtanova Yulia Evgenievna
Candidate of Psychological Sciences
FSBEI HE MSUPE
Head of the Department
kurtanovayue@mgppu.ru

Аннотация. Представлено исследование особенностей реинтеграции в социум детей младшего школьного возраста с онкологическими заболеваниями после длительного лечения. Для повышения успешности социальной реинтеграции предложена комплексная программа психологической реабилитации, которая реализуется на этапе лечения в медицинском учреждении.

Ключевые слова: дети, онкологические заболевания, длительное лечение, реинтеграция в социум, психолого-педагогическое сопровождение, психологическая реабилитация.

Abstract. This paper presents a study examining the social reintegration of primary school-aged children with cancer after long-term treatment. To improve the success of social reintegration, a comprehensive psychological rehabilitation program is proposed, implemented during treatment at a medical facility.

Keywords: children, cancer, long-term treatment, social reintegration, psychological and pedagogical support, psychological rehabilitation.

Дети с онкологическими заболеваниями, находящиеся на длительном лечении в медицинском учреждении, оказываются в сложной ситуации развития. Длительная изоляция, эмоциональное напряжение, тяжелое лечение, гиперопека зачастую приводят к трудностям в социальных контактах, астенизации, снижению когнитивных функций и, как результат, сложностям в социальной реинтеграции после выписки из стационара.

Социальная реинтеграция детей после длительного лечения – это сложный многоэтапный процесс, включающий в себя возможность продолжить

образование, возобновить социальные контакты, расширять свои интересы, реализовать свои возможности, что положительно влияет на качество жизни ребенка и всей семьи. Важным условием является создание поддерживающей социальной среды и особой атмосферы принятия, в которой ребенок сможет чувствовать безопасность и свободно развиваться.

Восстановление внутрисемейных отношений, снижение последствий социальной депривации, когнитивных дефицитов детей с онкологическими заболеваниями зачастую требует вмешательства специалистов по психологическому сопровождению. Актуальность психолого-педагогического сопровождения семей с детьми с онкопатологией и разработки программ психосоциальной реабилитации приобретает большое значение в госпитальных школах детских медицинских учреждений, что объясняется активным развитием госпитальной педагогики в нашей стране и требует поиска инструментов психолого-педагогического сопровождения детей с целью повышения их психологических ресурсов, обеспечивающих успешность включения их в социум после продолжительного лечения [1].

Научная группа преподавателей факультета Клинической и специальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета провела исследование особенностей психологического развития детей младшего школьного возраста с онкологическими заболеваниями. По результатам исследования было выявлено, что у детей данной категории отмечается снижение когнитивных функций (внимания, памяти, вербально-логического мышления), снижены показатели социальной активности и социальной адаптированности, повышен показатель социальной желательности. При изучении образа друга у детей с онкопатологией было выявлено искажение этого образа, размытое понимание дружбы, включение в понятие «друг» случайных знакомых, родителей и других родственников [2]. Такие результаты могут быть связаны с особой социальной ситуацией, в которой развивается ребенок с онкологическим заболеванием, а также с воздействием ситуации тяжелого лечения и длительной госпитализации.

Эти данные согласуются с анализом запросов психолого-педагогического сопровождения семей с детьми, перенесшими онкологические и гематологические заболевания, проведенным И.Ю. Долуевым с соавторами. И.Ю. Долуев отмечает, что одним из основных запросов является решение проблемы социализации и развития коммуникативных навыков у детей [3].

Полученные результаты исследования стали обоснованием для разработки программы психологической реабилитации, направленной на снижение психологической травматизации детей и ближайшего взрослого, который находится в стационаре с ребенком, снижение социальной депривации и когнитивных дефицитов. Программа психологической реабилитации рассчитана на три месяца и включила в себя арт-терапевтические занятия с детьми для стабилизации эмоционального состояния, социальный тренинг, направленный на расширение коммуникативных возможностей детей, занятия на развитие когнитивных функций и консультации родителей [4].

Программа психологической реабилитации была реализована на нескольких площадках проекта госпитальных школ УчимЗнаем. Участниками программы стали 56 детей 7-11 лет с онкологическими заболеваниями, находящиеся на длительном лечении. В результате проведения программы психологической реабилитации были выявлены положительные изменения в развитии когнитивных функций у детей, повысились значения показателей социальной адаптированности и социальной активности, снизились показатели социальной желательности. Дети стали более открыто рассказывать о своих негативных эмоциях и переживаниях, связанных с лечением и длительной госпитализацией. Родители смогли увидеть личностные качества детей, их потребность в общении, понять значимость социализации, не смотря на наличие онкологических заболеваний.

Отсроченная диагностика этой группы детей через 3 и 6 месяцев после выписки из медицинского учреждения показала стойкость психологических изменений у детей в результате прохождения программы психологической реабилитации, что положительно повлияло на успешность социальной реинтеграции. Детям было не сложно встроиться в учебный процесс в школе по месту жительства, вернуться к общению с прежней социальной группой, установить контакт с новыми друзьями. Они получают психологическую поддержку от ближайших взрослых, их социальная ситуация развития достаточно стабильна и отличается принятием со стороны социального окружения, учетом личностных особенностей и потребностей ребенка.

Проведенное исследование показало значимость реализации подобного рода программ психологической реабилитации. Подготовка к социальной реинтеграции должна быть комплексной, начинаться на этапе длительного лечения в стационаре и включать в себя широкий спектр мероприятий по психолого-педагогической реабилитации. В программу психолого-педагогической и психосоциальной реабилитации должны быть включены занятия по нормализации эмоционального состояния, развитию коммуникативных навыков, когнитивных функций, а также консультации для родителей. Такая работа может быть реализована в рамках работы психолого-педагогических служб госпитальных школ в медицинских учреждениях.

Таким образом, подготовка к активной социальной жизни является целенаправленным психолого-педагогическим процессом, в котором должны быть учтены психологические особенности и социальные потребности детей с онкологическими заболеваниями.

Литература

1. Шариков, С.В. Педагогическая поддержка образовательных возможностей детей, находящихся на длительном лечении в медицинских стационарах / С.В. Шариков // Альманах Института коррекционной педагогики. – 2020. – № 40. – С. 22–42.
2. Куртанова, Ю.Е. Когнитивные, эмоциональные и социальные особенности детей младшего школьного возраста с онкологическими заболеваниями / Ю.Е. Куртанова, Ю.А. Бурдукова, А.М. Щербакова, Е.С.

Зорина, О.В. Белозерская, Н.С. Лыкова, В.Д. Щукина, А.А. Бриллиантова // Новые психологические исследования. – 2023. – Том 3. – №3. – С.108-126.

3. Долуев, И.Ю. Выявление актуальных запросов психолого-педагогического сопровождения семей с детьми, перенесшими онкологические и гематологические заболевания / И.Ю. Долуев, Е.С. Зорина, Д.А. Соловьев // Перспективы Науки и Образования. – 2023. – №1. – С. 451–468.

4. Куртанова, Ю.Е. Проблемы реинтеграции в социум после продолжительного лечения детей младшего школьного возраста с онкологическими заболеваниями / Ю.Е. Куртанова, Ю.А. Бурдукова, О.В. Белозерская, В.Д. Щукина // Вопросы психического здоровья детей и подростков. – 2022. – №4. – С.64-73.

References

1. Sharikov, S.V. Pedagogicheskaya podderzhka obrazovatel'ny'x vozmozhnostej detej, naxodyashhixsya na dlitel'nom lechenii v medicinskix stacionarax / S.V. Sharikov // Al'manax Instituta korrekcionnoj pedagogiki. – 2020. – № 40. – S. 22–42.

2. Kurtanova, Yu.E. Kognitivny'e, e'mocional'ny'e i social'ny'e osobennosti detej mladshego shkol'nogo vozrasta s onkologicheskimi zabolevaniyami / Yu.E. Kurtanova, Yu.A. Burdukova, A.M. Shherbakova, E.S. Zorina, O.V. Belozerskaya, N.S. Ly'kova, V.D. Shhukina, A.A. Brilliantova // Novy'e psixologicheskie issledovaniya. – 2023. – Том 3. – №3. – S.108-126.

3. Doluev, I.Yu. Vy'yavlenie aktual'ny'x zaprosov psixologo-pedagogicheskogo soprovozhdeniya semej s det'mi, perenesshimi onkologicheskie i gematologicheskie zabolevaniya / I.Yu. Doluev, E.S. Zorina, D.A. Solov'ev // Perspektivy` Nauki i Obrazovaniya. – 2023. – №1. – S. 451–468.

4. Kurtanova, Yu.E. Problemy` reintegracii v socium posle prodolzhitel'nogo lecheniya detej mladshego shkol'nogo vozrasta s onkologicheskimi zabolevaniyami / Yu.E. Kurtanova, Yu.A. Burdukova, O.V. Belozerskaya, V.D. Shhukina // Voprosy` psixicheskogo zdorov'ya detej i podrostkov. – 2022. – №4. – S.64-73.

УДК 616-006

**ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ СЕНСОМОТОРНЫХ ФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ
С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ГОСПИТАЛЬНОЙ ШКОЛЕ**

Волкова Алиса Георгиевна

кандидат медицинских наук

НИИ ДОГиТ им. Р.М. Горбачёвой

ПСПбГМУ им. И.П. Павлова

врач-гематолог

заведующий отделением медицинской реабилитации

Путинцева Анастасия Георгиевна

НИИ ДОГиТ им. Р.М. Горбачёвой

ПСПбГМУ им. И.П. Павлова

медицинский психолог отделения медицинской реабилитации

Павлик Анжелика Витальевна

НИИ ДОГиТ им. Р.М. Горбачёвой

ПСПбГМУ им. И.П. Павлова

медицинский психолог отделения медицинской реабилитации

Тимофеева Марья Александровна

НИИ ДОГиТ им. Р.М. Горбачёвой

ПСПбГМУ им. И.П. Павлова

специалист по физической реабилитации медицинской реабилитации

**THE IMPORTANCE OF ASSESSING SENSORIMOTOR FUNCTIONS IN
PATIENTS WITH ONCOLOGY FOR DEVELOPING THE EDUCATIONAL
PROCESS IN A HOSPITAL SCHOOL**

Volkova Alisa Georgievna

PhD

R.M. Gorbacheva Memorial Research Institute of Children Oncology

Hematology and Transplantation

I.P. Pavlov First Saint-Petersburg State Medical University

hematologist, head of the medical rehabilitation department

Putintseva Anastasia Georgievna

R.M. Gorbacheva Memorial Research Institute of Children Oncology,

Hematology and Transplantation

I.P. Pavlov First Saint-Petersburg State Medical University

clinical psychologist of the medical rehabilitation department

Pavlik Anzhelika Vitalievna

R.M. Gorbacheva Memorial Research Institute of Children Oncology,
Hematology and Transplantation

I.P. Pavlov First Saint-Petersburg State Medical University
clinical psychologist of the medical rehabilitation department

Timofeeva Maria Aleksandrovna

R.M. Gorbacheva Memorial Research Institute of Children Oncology,
Hematology and Transplantation

I.P. Pavlov First Saint-Petersburg State Medical University
physical rehabilitation specialist
of the medical rehabilitation department

Аннотация. Диагностика сенсомоторных функций у детей, проходящих лечение по поводу онкологического заболевания, имеет решающее значение для создания эффективного образовательного пути и реабилитационного плана, поскольку ранние и долгосрочные эффекты лечения могут привести к нарушениям, влияющим на когнитивные функции данных пациентов. Эта диагностика помогает выявить специфические нарушения, такие как нарушения равновесия, мелкой моторики и проприоцепции, что позволяет разработать персонализированные целевые программы, такие как сенсомоторные тренировки и программы упражнений. Понимание степени и характера этих нарушений позволяет разработать индивидуальный подход для сохранения функциональных возможностей, улучшения качества жизни и потенциального предотвращения дальнейших осложнений.

Ключевые слова: сенсорные и моторные функции, дети с онкологическими заболеваниями, академическая успеваемость.

Abstract. Assessing sensorimotor function in children undergoing cancer treatment is crucial for creating an effective educational pathway and rehabilitation plan, as the early and long-term effects of treatment can lead to impairments that affect cognitive function in these patients. This assessment helps identify specific impairments, such as balance, fine motor, and proprioceptive deficits, enabling the development of personalized targeted programs, such as sensorimotor training and exercise programs. Understanding the extent and nature of these impairments allows for the development of a personalized approach to preserve functional capacity, improve quality of life, and potentially prevent further complications.

Keywords: sensory and motor functions, children with cancer, academic performance.

Актуальность. Сенсомоторные функции у детей с онкологическими заболеваниями могут ухудшаться на фоне течения болезни и лечения, что приводит к нарушениям координированных двигательных действий в ответ на интерпретацию ощущений. У детей школьного возраста помимо первичных

ощущений (обоняния, зрения, слуха, вкуса и тактильных ощущений), вестибулярные и проприоцептивные ощущения также важны для сенсомоторных функций. Оценка данных функций фокусируется на понимании влияния гностических и практических функций на перцептивную, двигательную и академическую успеваемость [1]. Отсроченные последствия химиотерапии и лучевой терапии могут вызывать сенсомоторные нарушения и влиять на когнитивные функции [2]. В результате дети могут столкнуться с трудностями в выполнении задач, требующих мелкой моторики, снижением концентрации внимания, памяти, нарастанием истощаемости, нарушением поддержания равновесия тела, что приводит к социальным, психологическим и академическим проблемам [1, 3]. Сенсомоторные функции имеют решающее значение для общего адаптивного поведения и успешного выполнения повседневной личной и социальной деятельности у детей школьного возраста [4, 5].

Понимание того, как неврологические проблемы детей с онкологическими заболеваниями могут быть решены в школьной среде, имеет решающее значение для всех специалистов, кто работает с детьми, находящимися на длительном лечении.

Нейрокогнитивные нарушения стали одной из основных причин неблагоприятных исходов после лечения онкологического заболевания. Когнитивная дисфункция влияет на качество жизни, приверженность к лечению, регуляторные функции. Ранняя диагностика может не отражать весь спектр когнитивных нарушений, поэтому важно регулярно проводить скрининги для своевременного проведения реабилитационных мероприятий. Школьная нейропсихология объединяет школьную психологию с детской клинической нейропсихологией и играет важную роль в изучении, понимании функциональных проявлений и профилей сильных и слабых сторон учащихся, с которыми работают специалисты мультидисциплинарной команды.

Технологические достижения в области нейровизуализации дали начало специализированным направлениям школьной нейропсихологии и педагогической нейронауки (the International Mind, Brain and Education Society (IMBES) and the special interest group Neuroscience and Education).

Работа школьных нейропсихологов фокусируется на конкретных когнитивных сферах, таких как сенсомоторные навыки, внимание, обучение и память, зрительно-пространственная обработка, слуховая обработка, исполнительные функции, языковые навыки и скорость обработки информации.

Цель исследования: оценить сенсомоторные и когнитивные функции у пациентов с ОЛЛ школьного возраста для создания индивидуального образовательного маршрута в рамках госпитальной школы.

Материалы и методы:

Исследование проводилось на базе НИИ ДОГиТ им. Р.М. Горбачевой, в котором приняли участие 13 детей с ОЛЛ. Распределение по возрасту: 9-11 лет – 54% (7) ; 12-14 лет – 23% (3); 15-17 лет – 23% (3); распределение по ТКМ: до ТКМ 38% (5), после ТКМ 62% (8).

Оценка включала в себя способность к ориентации в пространстве и времени, внимание, компоненты мышления, краткосрочную и долгосрочную

память, эмоциональную лабильность. В диагностике использовались компьютеризированный аппарат SCHUHFRIED Vienna Test System со следующими тестами: Когнитрон (COG/S4), Вербальный NBack (VNB/S1), Детерминационный тест (DTRI/S1), Интерференционный тест по Струпу (STROOP/S7), а также аппаратно-программный комплекс "Светофон": Поиск цвета, Цвет по команде, Цифры по команде, Сопоставление цвета и значения, Парный алфавит.

Результаты: Тест Когнитрон (COG/S4) показал, что скорость обработки информации, устойчивость и распределение процессов внимания снижена у 38% детей.

Тест Вербальный NBack (VNB/S1), демонстрирующий кратковременную механическую память, в котором 31% детей находятся ниже нормативного интервала. При легкой заторможенности процессов воспроизведения информации у 46% детей отмечаются результаты ниже нормы.

Детерминационный тест (DTRI/S1) определил снижение устойчивости и переключение процессов внимания у 15% детей, нарастание истощения с игнорированием субъективно незначимых стимулов регистрируется у 69% детей, психомоторный темп средний.

Интерференционный тест по Струпу (STROOP/S7) демонстрирует нарастание интерференции когнитивной деятельности, замедленное усвоение информации и адаптации к стрессовым условиям у 69% детей, называние и интерференция называния ниже нормы у 39% детей.

При выполнении методик на АПК "Светофон" отмечалась сохранность сенсомоторных и оптико-пространственных функций при нарастающем истощении и снижении процессов внимания у 53% детей. Выявлено увеличение используемого времени для выполнения методик, снижение скорости реакции выполнения при отклике на стимульный материал с графиком по гипостеническому типу.

Выводы:

1. Пациенты с ОЛЛ имели нормальные показатели процессов внимания и памяти, целостность оптико-пространственного гнозиса. Отклонения от возрастной нормы были выявлены в снижении психомоторного темпа, в нарастании процессов истощения и интерференции, в снижении скорости воспроизведения информации и чтения, а также в снижении ориентации в пространстве и в качестве сенсомоторных функций.

2. Результаты сенсомоторного исследования необходимы при составлении реабилитационных программ пациента и составлении или коррекции образовательных программ.

3. Цифровые технологии подходят для диагностики и коррекции сенсомоторных и когнитивных функций у пациентов с онкологическими заболеваниями на разных этапах лечения и для динамического наблюдения в отдаленном периоде после лечения.

4. Необходимы дальнейшие исследования и координация специалистов разного профиля в области изучения сенсомоторных и когнитивных функций у

пациентов, находящихся на длительном лечении по поводу онкологических заболеваний.

Литература

1. Ковалева, А.В. Точная количественная оценка слухомоторной синхронизации у детей и взрослых с помощью программно-аппаратного комплекса сенсомоторной ритмографии / А.В. Ковалева, В.Н. Анисимов, А.В. Красноперов // Лечебная физкультура и спортивная медицина. – 2019. – № 153(3). – С. 24-31.
2. Deviaterikova, A. Visual-Motor Functions and Associated Cognitive Outcomes in Pediatric Cancer Survivors / A. Deviaterikova // Medical Sciences. – 2025. – №13(2). – URL: <https://www.mdpi.com/2076-3271/13/2/41> (Дата обращения 27.11.2025).
3. Лихоманова, Е.Н. Связь утомляемости, связанной с раком, с вегетативными и сенсомоторными функциями у детей, лечившихся от опухолей головного мозга: обсервационное исследование / Е.Н. Лихоманова, А.В. Ковалева // Вестник восстановительной медицины. – 2022. – №21(4). – С. 60-70.
4. Davies, P.L. Maturation of sensory gating performance in children with and without sensory processing disorders / P.L. Davies, W.P. Chang, W.J. Gavin // International Journal of Psychophysiology. – 2009. – №72(2). – P. 187-197.
5. Reitan, R.M. The significance of sensory-motor functions as indicators of brain dysfunction in children / R.M. Reitan, D. Wolfson // Archives of Clinical Neuropsychology. – 2003. – №18(1). – P. 11-18.

References

1. Kovaleva, A.V. Tochnaya kolichestvennaya ocenka sluhomotornoj sinhronizacii u detej i vzroslyh s pomoshch'yu programmno-apparatnogo kompleksa sensomotornoj ritmografii / A.V. Kovaleva, V.N. Anisimov, A.V. Krasnoperov // Lechebnaya fizkul'tura i sportivnaya medicina. – 2019. – № 153(3). – S. 24-31.
2. Deviaterikova, A. Visual-Motor Functions and Associated Cognitive Outcomes in Pediatric Cancer Survivors / A. Deviaterikova // Medical Sciences. – 2025. – №13(2). – URL: <https://www.mdpi.com/2076-3271/13/2/41> (Accessed 27.11.2025).
3. Lihomanova, E.N. Svyaz' utomlyaemosti, svyazannoj s rakom, s vegetativnymi i sensomotornymi funkciyami u detej, lechivshih'sya ot opuholej golovnogo mozga: observacionnoe issledovanie / E.N. Lihomanova, A.V. Kovaleva // Vestnik vosstanovitel'noj mediciny. – 2022. – №21(4). – S. 60-70.
4. Davies, P.L. Maturation of sensory gating performance in children with and without sensory processing disorders / P.L. Davies, W.P. Chang, W.J. Gavin // International Journal of Psychophysiology. – 2009. – №72(2). – P. 187-197.
5. Reitan, R.M. The significance of sensory-motor functions as indicators of brain dysfunction in children / R.M. Reitan, D. Wolfson // Archives of Clinical Neuropsychology. – 2003. – №18(1). – P. 11-18.

УДК 364.48

«АРЕАЛ КУЛЬТУРЫ» КАК ИНСТРУМЕНТ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Хазова Татьяна Викторовна

кандидат экономических наук

АНО «МастАРТ»

директор по организации и

проведению социокультурных проектов

tatiana@mustartgallery.ru

"CULTURE AREA" AS A TOOL FOR COMPREHENSIVE REHABILITATION

Khazova Tatyana Viktorovna

PhD in Economics

ANO "MustART"

Director for the Organization and Implementation of Sociocultural

tatiana@mustartgallery.ru

Аннотация. Статья посвящена уникальному художественно-просветительскому проекту «Ареал культуры», который предполагает создание в интерьерах детских больниц, школ, детских садов и других учреждений особой образовательной среды и превращение их привычной обстановки в яркий интерактивный музей.

Ключевые слова: гуманитарное образование, реабилитация, дополнительное образование, культурный контекст, искусство.

Abstract. This article is dedicated to the unique artistic and educational project "Culture Area," which involves creating a special educational environment within children's hospitals, schools, kindergartens, and other institutions, transforming their familiar surroundings into vibrant interactive museums.

Keywords: humanities education, rehabilitation, supplementary education, cultural context, art.

Детский возраст – один из самых важных этапов в жизни человека. В этот период формируются основы морально-нравственных качеств ребёнка, мировоззрения, системы взглядов и ценностей. От того, в какой информационной и культурной среде будет происходить социализация человека, зависит вся его дальнейшая жизнь. К сожалению, для детей, находящихся на длительном лечении, нарушен полноценный доступ к источникам культуры – музеям, выставкам, библиотекам, редким книгам. Проект «Ареал культуры» способен восполнить имеющийся дисбаланс и помочь интеграции представителей подрастающего поколения в богатый культурный контекст.

«Ареал культуры» – это яркий интерактивный музей, который превращает бездушные серые стены школ, больниц, детских садов в увлекательный художественный мир; коридоры становятся местом, где можно познакомиться с величайшими произведениями мирового искусства, проследить историю развития современной культуры, узнать интересные факты о создании картин, судьбе авторов, их творчестве и источниках вдохновения.

В основе художественно-просветительского проекта «Ареал культуры» лежит набор репродукций мировых шедевров, следующих друг за другом в хронологическом порядке, согласно эпохам в истории искусства – от Древнего Египта до наших дней. Экспозиция состоит из 12 периодов, в каждом из которых представлено 25 изображений, отобранных профессиональными искусствоведами. Все картины являются частью собраний Государственной Третьяковской галереи, Государственного Эрмитажа, ГМИИ им. Пушкина, Метрополитен музея, Лувра, Прадо, Старой Пинакотеки и др.

Каждая репродукция сопровождается короткой аннотацией, подготовленной опытными искусствоведами специально для этого проекта. Небольшие очерки рассказывают о картине, её особенностях, об авторе и его стиле. Частью экспозиции в блоке является и особый вводный лист, который даёт характеристику всей эпохе.

Уникальной чертой проекта «Ареал культуры» является то, что он создан с учётом особенностей восприятия детьми визуальной информации. Весь материал расположен на уровне глаз ребёнка в помещениях, где дети пребывают наибольшее количество времени. Проходя мимо экспозиции каждый день, ребёнок запоминает произведения, вдумывается в их смысл, изучает искусствоведческий очерк, обсуждает сюжеты увиденного с взрослыми и сверстниками.

Проект особенно актуален в детских больницах, где дети, находящиеся на длительном лечении, не имеют возможности посещать общеобразовательные учреждения. В этом случае репродукции «Ареала культуры» могут стать наглядным пособием для проведения тематических занятий по истории, литературе, обществознанию. Кроме этого, создаётся дополнительный позитивный и эмоциональный фон для скорейшего выздоровления пациентов. Юные зрители не только расширяют свой кругозор и приобщаются к мировому искусству, но и проходят этапы реабилитации и социальной адаптации.

Ежемесячно периоды меняются, и за год дети знакомятся с тремя сотнями величайших произведений. Помимо простого созерцания, они также принимают участие в увлекательных творческих занятиях, проводимых педагогами-искусствоведами на основе определенного периода, интересных квестах, слушают лекции по истории искусства.

Проект рассчитан на детей и подростков, по разным причинам имеющих ограниченный доступ к культуре и образованию. Посредством искусства мы решаем важную задачу просвещения детей, формирования у них образного мышления, нравственных и эстетических ориентиров, понимания исторических и социальных процессов, повышению уровня их гуманитарного образования,

широте взглядов, формированию национального самосознания, укреплению их интеллектуальных и культурных связей с прошлым и настоящим.

Проект существует и активно развивается с 2016 года по всей стране. «Ареал культуры» уже успешно внедрён в:

- больничной школе Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва (НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва);

- Государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Морозовская детская городская клиническая больница Департамента здравоохранения города Москвы» (ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»);

- больничной школе Российской детской клинической больницы федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (РДКБ ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России);

- трёх Государственных бюджетных образовательных учреждений города Севастополя (Образовательный центр «Казачья бухта», Детский сад «Акварель», Образовательный центр имени В. Д. Ревякина);

- Государственном бюджетном учреждении здравоохранения города Севастополя «Городская больница № 5» «Центр охраны здоровья матери и ребенка»;

- Государственном бюджетном учреждении здравоохранения города Москвы «Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков имени Г. Е. Сухаревой Департамента здравоохранения города Москвы» (ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г. Е. Сухаревой ДЗМ»);

- Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Воробьевы горы» и др.

В 2018 году проект стал победителем конкурса Грантов Мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций и конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. В начале 2019 года при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы и головного отделения ПАО «Сбербанк» было проведено масштабное обучающее занятие на базе «Ареала культуры» для воспитанников 10 московских детских домов. По итогам мероприятия организаторами было принято решение о внедрении данного проекта в воспитательный процесс детей-сирот из центров содействия семейному воспитанию на регулярной основе.

Проект всё больше привлекает не только детей и родителей, но и руководство культурно-досуговых центров, других медицинских и образовательных учреждений, которое видит положительный эффект от проекта и активно заявляет о желании разместить экспозицию в своих стенах. Работа над «Ареалом культуры» постоянно продолжается, так как в нём заложен принцип сменности и ротации материала; возникают дополнительные запросы как на увеличение числа экспонируемых комплектов, так и на расширение

представленных тем истории искусства, более глубокую их детализацию. В дальнейшем мы планируем издание энциклопедии по изобразительному искусству и настольной игры для ежедневного изучения основ мировой художественной культуры в кругу семьи. Важным этапом является также создание мобильной версии энциклопедии, что сделает её ещё более доступной и понятной подрастающему поколению.

Литература

1. Карамзин, Н.М. История государства Российского. Т.I-IV / Карамзин Н. М. – Калуга: Золотая аллея. – 1993. – 560 с.
2. Флоренский, П.А. Избранные труды по искусству / П.А. Флоренский. – Москва: Изобраз. искусство: Центр изучения охраны и реставрации наследия священника П. Флоренского, Б. г. – 1996. – 372 с.
3. Давыдова, Е.А. Русская живопись. История и шедевры / Е.А. Давыдова. – М.: Белый город. – 2007. – 1487 с.
4. Лазарев, В.Н. Русская средневековая живопись: Статьи и исследования / А.Н. Лазарев. – М.: Наука. – 1970. – 343 с.
5. Алпатов, М.В. Этюды по истории русского искусства / М.В. Алпатов. – М.: Искусство. – 1967. – 214 с.
6. Репин, И.Е. Об искусстве: живопись, литература, музыка: из книги «Далекое и близкое» / И.Е. Репин. – М.: Слово/Slovo. – 2019. – 534 с.
7. Бенуа, А.Н. Русская школа живописи / А.Н. Бенуа. – М.: Арт-Родник. – 1997. – 334 с.
8. Стернин, Г.Ю. Два века: XIX-XX: очерки русской художественной культуры / Г.Ю. Стернин. – М.: Галарт. – 2007. – 381 с.
9. Малевич, К.С. О новых системах в искусстве. Статика и скорость. Установление А / К.С. Малевич. – Витебск: Артель худ. труда при Витсвомасе. – 1919. – 32 с.
10. Кандинский, В.В. О духовном в искусстве / В.В. Кандинский. – М.: Архимед. – 1992. – 107 с.
11. Харджиев, Н.И. Статьи об авангарде: в 2 т. / Н.И. Харджиев. – М.: РА. – 1997. – 712 с.

References

1. Karamzin, N.M. Istoriya gosudarstva Rossijskogo. T.I-IV / Karamzin N. M. – Kaluga: Zolotaya alleya. – 1993. – 560 s.
2. Florenskij, P.A. Izbrannye trudy po iskusstvu / P.A. Florenskij. – Moskva: Izobraz. iskusstvo: Centr izucheniya ohrany i restavracii naslediyasvyashchennika P. Florenskogo, B. g. – 1996. – 372 s.
3. Davydova, E.A. Russkaya zhivopis'. Istoriya i shedevry / E.A. Davydova. – M.: Belyj gorod. – 2007. – 1487 s.
4. Lazarev, V.N. Russkaya srednevekovaya zhivopis': Stat'i i issledovaniya / A.N. Lazarev. – M.: Nauka. – 1970. – 343 s.
5. Alpatov, M.V. Etyudy po istorii russkogo iskusstva / M.V. Alpatov. – M.: Iskusstvo. – 1967. – 214 s.

6. Repin, I.E. Ob iskusstve: zhivopis', literatura, muzyka: iz knigi "Dalekoe iblizkoe" / I.E. Repin. – M.: Slovo/Slovo. – 2019. – 534 s.
7. Benua, A.N. Russkaya shkola zhivopisi / A.N. Benua. – M.: Art-Rodnik. – 1997. – 334 s.
8. Sternin, G.YU. Dva veka: XIX-XX: ocherki russkoj hudozhestvennoj kul'tury / G.YU. Sternin. – M.: Galart. – 2007. – 381 s.
9. Malevich, K.S. O novyh sistemah v iskusstve. Statika i skorost'. Ustanovlenie A / K.S. Malevich. – Vitebsk: Artel' hud. truda pri Vitsvomase. – 1919. – 32 s.
10. Kandinskij, V.V. O duhovnom v iskusstve / V.V. Kandinskij. – M.: Arhimed. – 1992. – 107 s.
11. Hardzhiev, N.I. Stat'i ob avangarde: v 2 t. / N.I. Hardzhiev. – M.: RA. – 1997. – 712 s.

УДК 364.48

«МЕЧТА О КОСМОСЕ» – ПРОЕКТ БЕЗ ГРАНИЦ

Храброва Анна Сергеевна

ГБУК «Мемориальный музей космонавтики»

заместитель заведующего отделом научно-методической работы

khrabrovaas2@culture.mos.ru

«THE DREAM OF SPACE» – A PROJECT WITHOUT BORDERS

Khrabrova Anna Sergeevna

«Memorial Museum of Cosmonautics»

deputy Head of the Department of Scientific and Methodological Work

khrabrovaas2@culture.mos.ru

Аннотация. Рассматривается совместный проект Госпитальных школ «УчимЗнаем» и Музея космонавтики по созданию уникального сувенира-индикатора невесомости, который смог продемонстрировать симбиоз современных тенденций музейной педагогики, педагогики соучастия и новых форм взаимодействия детей, находящихся на длительном лечении, в образовательный и воспитательный процесс.

Ключевые слова: музейная педагогика, госпитальная педагогика, космонавтика, инклюзия, творческая рефлексия, воспитательные практики, педагогика соучастия.

Abstract. A joint project of the “Hospital school “We Teach/They Learn” and the Museum of Cosmonautics is being considered to create a unique souvenir-an indicator of weightlessness, which was able to demonstrate a unique symbiosis of modern trends in museum pedagogy, the pedagogy of complicity and new forms of interaction between children undergoing long-term treatment in the educational and educational process.

Keywords: museum pedagogy, hospital pedagogy, cosmonautics, inclusion, creative reflection, educational practices, pedagogy of participation.

Современная образовательная парадигма все больше смещается в сторону персонализации, инклюзии и практико-ориентированного подхода. Особую актуальность эти принципы приобретают в контексте госпитальной педагогики, где задача не только в передаче знаний, но и в психолого-педагогической поддержке, социализации и поддержании мотивации к обучению у детей, переживающих серьезные заболевания. Флагманом в этой области в Российской Федерации является проект «УчимЗнаем», который создает среду для полноценного школьного образования в условиях медицинских стационаров [1].

Одним из наиболее ярких примеров интеграции госпитальной педагогики с ресурсами учреждений культуры и реального сектора является совместный

проект с Музеем космонавтики в Москве [2]. Данная статья ставит целью проанализировать педагогическую и реабилитационную эффективность этого проекта, в рамках которого дети-учащиеся госпитальной школы разработали действующий индикатор невесомости для Героя России, летчика-космонавта Ивана Викторовича Вагнера.

Проект «УчимЗнаем» зарекомендовал себя как эффективная модель создания развивающей образовательной среды («образовательный оазис») в стенах стационаров. Однако выход за его пределы является логичным и необходимым этапом реабилитации. Музей космонавтики, как центр хранения и актуализации научно-технического наследия, предоставляет уникальную площадку для такого «выхода». Он становится не просто местом экскурсии, а живой лабораторией, где абстрактные знания из школьных курсов физики, информатики и технологии обретают практический смысл.

Сотрудничество в данном случае строится на принципах социального партнерства: Музей предоставляет экспертную, материально-техническую и символическую ресурсную базу, а педагоги проекта «УчимЗнаем» интегрируют музейный контент в индивидуальные образовательные маршруты детей.

В отличие от сугубо технических проектов, где главной целью является создание работающего устройства, данный кейс сочетал в себе несколько взаимодополняющих аспектов:

Технико-символический: задача, поставленная космонавтом Иваном Викторовичем Вагнером, – создать индикатор невесомости – была решена нестандартно. Вместо использования микроконтроллеров и датчиков был выбран творческий, арт-педагогический подход.

Эмоционально-личностный: выбор материала – фетра – не случаен. Это мягкий, тактильно приятный, «живой» материал, работа с которым доступна детям с разными возможностями здоровья и уровнями технической подготовки. Создание ракеты своими руками превращало ее из прибора в личное послание, в «частичку себя», отправляемую в космос.

Социально-коммуникативный: процесс коллективного творчества в стенах Музея космонавтики создавал особую атмосферу сопричастности. Дети работали не над абстрактным заданием, а над подарком для конкретного человека – космонавта, что формировало уникальную эмоциональную связь.

Ключевым элементом, определяющим эффективность проекта, стал его полный «жизненный цикл»:

Этап создания: на этом этапе происходила активизация творческого потенциала, развитие мелкой моторики, формирование командного духа. Музейная среда выступала как вдохновляющий контекст, насыщенный подлинными образцами космической техники.

Этап отправки и использования: передача ракеты космонавту и ее последующий полет на МКС придали детскому труду высочайшую социальную значимость. Дети видели свой артефакт на фотографиях, что являлось мощнейшим антиподом чувства изоляции. Они становились не пассивными зрителями, а активными участниками космической программы.

Этап возвращения: возвращение ракеты на Землю после завершения экспедиции и ее торжественная передача Иваном Викторовичем Вагнером обратно в госпитальную школу является кульминационным реабилитационным актом.

Участие в таком проекте оказало комплексное воздействие на его участников:

Психологическая реабилитация: проект позволил преодолеть барьер «больной/здоровый мир». Дети, находящиеся в стенах госпиталя, своими руками создали объект, который достиг вершины человеческих устремлений – космоса. Это мощно повысило их самооценку и сформировало установку на преодоление [3].

Симбиоз образовательных областей: проект гармонично объединил технологии, искусство, физику, космонавтику.

Возвращенная ракета стала материальным якорем положительных воспоминаний и чувства гордости для всего коллектива госпитальной школы, вдохновляя новых учеников.

Проект «Мечта о космосе» по созданию индикатора невесомости в виде ракеты из фетра выходит далеко за рамки частного случая. Он представляет собой успешную модель построения реабилитационной образовательной среды, в которой Музей космонавтики выступает как со-творец и со-участник педагогического процесса, предоставляя не просто площадку, а смысловой контекст. Создание ракеты становится более эффективным инструментом личностной реабилитации, чем разработка сложного технического устройства, так как вкладывает в проект глубокий эмоциональный компонент. Ее полный цикл жизни (создание – полет – возвращение) создает мощную нарративную структуру, в которую ребенок вписывает себя как успешный и значимый деятель.

Подобный опыт демонстрирует, что будущее госпитальной педагогики лежит в создании «живых», эмоционально насыщенных проектов, результат которых является не только оценкой в журнале, но осязаемым, обладающим собственной историей артефактом, укрепляющим веру ребенка в свои силы и свою нужность миру.

Литература

1. Официальный сайт проекта «УчимЗнаем». – URL: <https://www.uchiznaem.ru> (Дата обращения 29.11.2025).
2. Официальный сайт Музея космонавтики. – URL: <https://www.kosmo-museum.ru> (Дата обращения 29.11.2025).
3. Медведева, Е.А. Арт-педагогика и арт-терапия в специальном образовании / Учеб. для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений / Е.А. Медведева, И.Ю. Левченко, Л.Н. Комиссарова, Т.А. Добровольская. — М.: Издательский центр «Академия». – 2001. – 248 с.

References

1. Oficial'ny`j sajt proekta «UchimZnaem». – URL: <https://www.uchiznaem.ru> (Accessed 29.11.2025).
2. Oficial'ny`j sajt Muzeya kosmonavtiki. – URL: <https://www.kosmo-museum.ru> (Accessed 29.11.2025).
3. Medvedeva, E.A. Art-pedagogika i art-terapiya v special'nom obrazovanii / Ucheb. dlya stud. sred. i vy`ssh. ped. ucheb. zavedenij / E.A. Medvedeva, I.Yu. Levchenko, L.N. Komissarova, T.A. Dobrovol'skaya. — M.: Izdatel'skij centr «Akademiya». – 2001. – 248 s.

**МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА ПО ОБСУЖДЕНИЮ
И АКТУАЛИЗАЦИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ В МЕДИЦИНСКИХ СТАЦИОНАРАХ
И НА ДОМУ**

УДК 376.1

**РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ**

Поздеева Ольга Владимировна

специализированное структурное подразделение
ГБОУ Школа № 109 «Госпитальная школа «УчимЗнаем»
заведующий учебной частью, старший методист
лаборатория госпитальной педагогики ФГБНУ «ИРЗАР»
младший научный сотрудник
pozdeeva.ov@uchimznaem.ru

Долуев Иван Юрьевич

кандидат исторических наук
проект госпитальных школ «УчимЗнаем»
заместитель руководителя
лаборатория госпитальной педагогики ФГБНУ «ИРЗАР»
заведующий
doluev.iy@uchimznaem.ru

**REGIONAL PRACTICE OF ORGANIZING EDUCATIONAL ACTIVITIES
FOR CHILDREN UNDER LONG-TERM TREATMENT**

Pozdeeva Olga Vladimirovna

specialized structural unit GBOU School № 109
“Hospital school “We Teach/They Learn”
Head of the Academic Department, Senior Methodologist
Institute of Child Development, Health, and Adaptation
pozdeeva.ov@uchimznaem.ru

Ivan Yuryevich Doluev

Candidate of Historical Sciences
Project of Hospital Schools "We Teach / They Learn"
deputy Head
Hospital Pedagogics Laboratory, Federal State Budgetary Scientific Institution
"IRZAR"
head
doluev.iy@uchimznaem.ru

Аннотация. В материале представлена региональная практика организации образовательной деятельности для детей, находящихся на длительном лечении, обсуждены проблемные вопросы, предложения для урегулирования образовательной деятельности в медицинских учреждениях, представлен опыт межрегионального взаимодействия на примере Дальневосточного федерального округа.

Ключевые слова: образовательная деятельность, госпитальная школа, длительное лечение, региональная практика.

Abstract. The article presents the regional practice of organizing educational activities for children undergoing long-term treatment, discusses problematic issues and proposals for regulating educational activities in medical organizations, and presents positive experience of interregional cooperation in the Far Eastern Federal District.

Keywords: educational activities, hospital school, long-term treatment, regional practice.

Вопросы организации образовательной деятельности в медицинских учреждениях остаются актуальными на сегодняшний день. Необходимо отметить, что эффективным становится обмен опытом между региональной и флагманской площадками Проекта госпитальных школ «УчимЗнаем», отражающий практическое решение проблемных вопросов. В рамках VII Всероссийской конференции с международным участием «УчимЗнаем – Заботливая школа – 2025» состоялся круглый стол по обсуждению и актуализации междисциплинарных научно-практических задач образования детей, находящихся на длительном лечении в медицинских стационарах и на дому (далее - Круглый стол). «Научно-практическая деятельность становится неотъемлемой частью, потому что много вопросов остаются не до конца изучены. Вовлечение педагогов в научно-исследовательскую деятельность создают точки профессионального и личностного развития, а связь науки и практики дает возможность находить новые формы работы с детьми» – отмечает руководитель проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем» С.В. Шариков [1].

Целью проведения Круглого стола стало профессионально-общественное обсуждение вопросов соблюдения прав детей, находящихся на длительном лечении, на получение ими качественного образования; нормативного правового регулирования организации получения образования детьми, находящимися на длительном лечении, в медицинских стационарах, единое содержание региональных нормативных правовых актов, регламентирующих организацию обучения детей, находящихся на длительном лечении, вопросы взаимодействия ведомств в сфере образования и здравоохранения, организация взаимодействия госпитальных школ «УчимЗнаем» и организаций, не являющихся участниками Проекта «УчимЗнаем», но осуществляющих обучение детей в медицинских организациях.

Участниками Круглого стола стали руководители и представители региональных органов исполнительной власти в сфере образования и здравоохранения, представители флагманской площадки Проекта госпитальных школ «УчимЗнаем», представители региональных площадок «УчимЗнаем».

На заседании Круглого стола было представлено выступление заместителя руководителя Проекта госпитальных школ «УчимЗнаем», заведующего Лабораторией госпитальной педагогики ФГБНУ «ИРЗАР», председателя Координационного совета Проекта «УчимЗнаем» И.Ю. Долуева и младшего научного сотрудника Лабораторией госпитальной педагогики ФГБНУ «ИРЗАР» О.В. Поздеевой о полученных статистических данных по организации образовательной деятельности в медицинских организациях в субъектах Российской Федерации. «В госпитальных школах важно обеспечить сотрудничество и взаимодействие между специалистами медицинских и образовательных организаций для того, чтобы учитывать особые потребности детей и разрабатывать соответствующие учебные планы. Согласованная работа междисциплинарной команды специалистов – важное условие для реализации реабилитационного потенциала ребенка» – отмечает И.Ю. Долуев [2].

По итогам проведенного в 2025 году мониторинга региональных нормативных правовых актов, регламентирующих отношения родителей (законных представителей) детей, находящихся на длительном лечении и образовательной организацией, выявлено расхождение по структуре и по содержанию направлений, включенных в указанные порядки по регионам РФ (далее – Порядок). В связи с полномочиями субъектов РФ по урегулированию вопроса организации образовательной деятельности в медицинских организациях, структура и содержание Порядков в разных регионах отличаются. Участники Круглого стола отмечают необходимость разработки типового Порядка на федеральном уровне, чтобы сохранить единообразие Порядков в субъектах РФ, прийти к единому порядку организации и содержания образовательной деятельности в медицинских организациях.

Кроме этого, в типовом Порядке предлагается отразить компетенции организаций в сфере образования и здравоохранения при организации обучения детей, находящихся на длительном лечении.

Также была представлена информация по количеству общеобразовательных организаций, организующих обучение детей, находящихся на длительном лечении в медицинских организациях по субъектам РФ. Получена актуальная статистика по школам, не являющимся участниками Проекта «УчимЗнаем», но наделенным регионами РФ полномочиями по обучению детей, находящихся на длительном лечении в медицинских организациях. Всего общеобразовательных организаций, занимающихся обучением детей в медицинских организациях – 214, их них 163 – муниципальные, 51 – государственная. Данная статистика позволит организовать работу по взаимодействию всех образовательных организаций в регионах, которые осуществляют образовательную деятельность в различных медицинских организациях.

Региональная практика организации образовательной деятельности для детей, находящихся на длительном лечении, была представлена докладами:

Крымовой Э.И., заместителя директора по методической работе ГОУ «Кузбасский центр образования», координатора региональной площадки Проекта «УчимЗнаем» – Кемеровская область» (г. Кемерово) – одного из успешных регионов, по открытию и функционированию госпитальных школ (7 госпитальных школ в регионе). «В Кузбассе работают госпитальные школы не только в детских онкологических отделениях. Это и противотуберкулёзный диспансер Новокузнецка, и центр реабилитации «Золотая рыбка» в Кемерове, и противотуберкулёзный санаторий п. Барзас, и отделение кардиохирургии Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний. Готовится к открытию седьмая школа в Кузбасском клиническом физиопульмонологическом медицинском центре имени И.Ф. Копыловой в г. Кемерово» [3];

Гаврик И.В., учителя, методиста КБОУ «Школа дистанционного образования», координатора региональной площадки Проекта «УчимЗнаем» – Красноярский край» (г. Красноярск);

Индюковой Ю.И., заместителя директора по учебно-воспитательной работе, куратор МРЦ ДО МБОУ СОШ № 13, координатора региональной площадки Проекта «УчимЗнаем» – Красноярский край» (г. Норильск);

Дроздовой О.В., тьютора МБОУ СОШ № 42, координатора региональной площадки Проекта «УчимЗнаем» – Ставропольский край» (г. Ставрополь);

Милинцовой В.А., учителя, педагога-психолога МОУ средней общеобразовательной школы «Образовательный комплекс № 10», координатора региональной площадки Проекта «УчимЗнаем» – Ярославская область» (г. Ярославль).

Каждый из представленных регионов представил уникальные решения организации образовательной деятельности в госпитальных школах с учетом специфики региона, механизмов финансирования, направленности медицинского учреждения, выстроенной работы между заинтересованными ведомствами.

На рамках проведения Круглого стола был представлен первый опыт реализации в 2025 году комплексного плана по повышению качества организации образовательной деятельности в госпитальных школах Дальневосточного федерального округа в докладах:

Александровой Т.А., начальника отдела по сопровождению длительно болеющих детей, детей с ОВЗ и детей, обучающихся на дому КГАНО «Краевой центр образования», координатора региональной площадки Проекта «УчимЗнаем» – Хабаровский край» (г. Хабаровск);

Глазуновой Ю.В., заместителя директора по УМР ГОУ Забайкальский центр специального образования и развития «Открытый мир», координатора региональной площадки Проекта «УчимЗнаем» – Забайкальский край» (г. Чита);

Дашинимаевой С.М., руководителя Ресурсного центра по поддержке образования детей с особыми образовательными потребностями ГБОУ

«Республиканский центр образования», координатора региональной площадки Проекта «УчимЗнаем» – Республика Бурятия» (г. Улан-Удэ). Площадка открыта в 2025 году, но уже активно включена в деятельность Проекта.

За период реализации комплексного плана в госпитальных школах Дальневосточном федеральном округе прошли межрегиональные мероприятия, направленные на обмен научно-методическими идеями и практическим опытом, на повышение цифровой грамотности у детей (конкурс), на воспитание духовно-нравственных ценностей (национальные праздники). Мероприятия проводились очно на площадках, с применением видеоконференцсвязи. Всего проведено четыре межрегиональных мероприятия с охватом около 100 участников. Организация межрегионального взаимодействия позволила объединить ресурсы для повышения качества образовательной деятельности в госпитальной школе, получить возможности проведения интересных встреч для детей и родителей в больницах в едином часовом поясе.

В завершении заседания Круглого стола в качестве яркого примера влияния госпитальной школы на выбор профессии в будущем, стало выступление бывшего пациента и выпускника госпитальной школы «УчимЗнаем», а сегодня – педагога Губаревой Е.В., тьютора ССП Школа № 109 «Госпитальная школа «УчимЗнаем» (г. Москва). Педагог поделилась опытом преодоления трудных периодов жизни, связанных с лечением болезни, будучи обучающейся госпитальной школы. Эта грань образования важна для руководителей госпитальных школ, поскольку выпускник сам прошедший тяготы лечения, может стать тьютором госпитальной школы, и с учетом своего жизненного опыта будет обучать школьников, находящихся на длительном лечении, оказывать психологическую поддержку, как когда-то получал ее сам от педагогов госпитальной школы «УчимЗнаем».

В завершении заседания Круглого стола специалисты и представители родительского сообщества задали интересующие их вопросы спикерам и модераторам. Вопросы касались организации деятельности госпитальных школ, выстраивания межведомственного и внутри ведомственного взаимодействия в регионе и правового регулирования деятельности госпитальных школ.

В ходе заседания Круглого стола состоялся конструктивный диалог, участники которого поддержали необходимость создания единого типового Порядка регламентации отношений между общеобразовательной организацией и родителями (законными представителями) детей, находящихся на длительном лечении, на федеральном уровне. Руководитель проекта «УчимЗнаем» С.В. Шариков выделяет «одним из главных векторов развития системы обучения детей, находящихся на длительном лечении – создание единого образовательного пространства» [4].

Участники отмечают необходимость выстраивания взаимодействия госпитальных школ «УчимЗнаем» и школ, не являющихся участниками Проекта «УчимЗнаем», но обучающихся детей, находящихся на длительном лечении, в целях создания единого образовательного пространства и оказания методической помощи.

Литература

1. Ракова, М. Сергей Шариков: Госпитальная педагогика – это уход от шаблонов / М. Ракова // Народный контроль. – 2022. – URL: https://nkpress.ru/news/true/sergey_sharikov_gospitalnaya_pedagogika_eto_ukhod_ot_shablonov/?ysclid=mj5pkt31t497804437 (Дата обращения 14.12.2025).
2. Долуев, И.Ю. Российская модель госпитальных школ / Долуев И.Ю. // Вестник Мининского университета. – 2025. – Том 13. – №1. – URL: <https://www.minin-vestnik.ru/jour/article/view/1696/1054> (Дата обращения 14.12.2025).
3. Городкова, А. «Легче отпускают смерть». Как онкобольные дети учатся в госпитальных школах / А. Городкова // Аргументы и факты. – 2025. – URL: <https://kuzbass.aif.ru/society/education/-legche-otpuskayut-smert-gospitalnyy-pedagog-o-tom-chto-vazhnee-onkodetyam> (Дата обращения 14.12.2025).
4. Шариков, С.В. Проект «УчимЗнаем» - Заботливая школа: десять лет позади, десять лет впереди. Российские векторы развития системы обучения детей, находящихся на длительном лечении / С.В. Шариков // VII Всероссийская конференция с международным участием «УчимЗнаем» - Заботливая школа. – 2025. – URL: <https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FgA2eWTIueh%2B%2FvLOzHWfil7IFTQKGBedc9at5ckRJZpQwK85wCqFkGhQwGrvfODYWq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&name=ШАРИКОВ%20СВ%20VII%20КОНФЕРЕНЦИЯ%2030102025%20-%20ОСНОВНАЯ.pdf> (Дата обращения 14.12.2025).

References

1. Rakova, M. Sergej Sharikov: Gospital'naya pedagogika – e'to uxod ot shablonov / M. Rakova // Narodny'j kontrol'. – 2022. – URL: https://nkpress.ru/news/true/sergey_sharikov_gospitalnaya_pedagogika_eto_ukhod_ot_shablonov/?ysclid=mj5pkt31t497804437 (Accessed 14.12.2025).
2. Doluev, I.Yu. Rossijskaya model' gospital'ny'x shkol / Doluev I.Yu. // Vestnik Mininskogo universiteta. – 2025. – Tom 13, №1. – URL: <https://www.minin-vestnik.ru/jour/article/view/1696/1054> (Accessed 14.12.2025).
3. Gorodkova, A. «Legche otpuskayut smert'». Kak onkopol'ny'e deti uchatsya v gospital'ny'x shkolax / A. Gorodkova // Argumenty' i fakty'. – 2025. – URL: <https://kuzbass.aif.ru/society/education/-legche-otpuskayut-smert-gospitalnyy-pedagog-o-tom-chto-vazhnee-onkodetyam> (Accessed 14.12.2025).
4. Sharikov, S.V. Proekt «UchimZnaem» - Zabotlivaya shkola: desyat' let pozadi, desyat' let vperedi. Rossijskie vektory' razvitiya sistemy' obucheniya detej, naxodyashhixsya na dlitel'nom lechenii / S.V. Sharikov // VII Vserossijskaya konferenciya s mezhdunarodny'm uchastiem «UchimZnaem» - Zabotlivaya shkola. – 2025. – URL: <https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FgA2eWTIueh%2B%2FvLOzHWfil7IFTQKGBedc9at5ckRJZpQwK85wCqFkGhQwGrvfODYWq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&name=ShARIKOV%20SV%20VII%20KONFERENCIYA%2030102025%20-%20OSNOVNAYA.pdf> (Accessed 14.12.2025).

МАТЕРИАЛЫ СЕКЦИОННЫХ ДОКЛАДОВ

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ

УДК 372.881.161.1

ПОДГОТОВКА К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПОДРОСТКОВ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

Лебедева Елена Владимировна

специализированное структурное подразделение
ГБОУ Школа № 109 «Госпитальная школа «УчимЗнаем»

тьютор

lebedeva.ev@uchimznaem.ru

PREPARATION OF ADOLESCENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS FOR STATE FINAL EXAMINATION

Lebedeva Elena Vladimirovna

specialized structural unit GBOU School № 109
“Hospital school “We Teach/They Learn”

tutor

lebedeva.ev@uchimznaem.ru

Аннотация. Представлен опыт подготовки к государственной итоговой аттестации в формате единого государственного экзамена (ЕГЭ) учащихся с особыми образовательными возможностями на примере учащегося с временным отсутствием речи после нейрохирургического вмешательства и обучающегося с полной потерей зрения вследствие онкологического заболевания. Описан опыт обучения учащихся с указанными патологиями, реализующий индивидуальный подход в рамках госпитальной школы.

Ключевые слова: госпитальная педагогика, госпитальная школа, особые образовательные потребности, восстановительное обучение, итоговая аттестация.

Abstract. This article presents the experience of preparing students with special educational needs for the state final assessment in the form of the Unified State Exams (USEs) as a case study. This article explores a student with temporary speech disorders following neurosurgery and a student with complete vision loss due to cancer. The article also describes the experience of teaching students with these conditions, using an individualized approach within a hospital school setting.

Keywords: hospital pedagogy, hospital school, special educational needs, rehabilitation training, final certification.

Профессиональная деятельность современного учителя связана с высокой степенью неопределенности, которая естественно влияет на характер и результаты его работы [1]. Необходимо отметить, что педагогическая деятельность учителя госпитальной школы сопряжена с еще большей неопределенностью, которая заключается в невозможности прогнозирования индивидуальных образовательных возможностей и образовательных потребностей учащихся, обусловленных течением болезни и ее последствиями. «Нестабильность образовательных возможностей» учащихся, нуждающихся в длительном лечении, объясняет профессиональную специфику педагогов госпитальных школ в отличие от педагога обычных школ [2, 3].

Каждый новый ученик в силу тех или иных трудностей в обучении ставит перед учителем новые задачи, решение которых нельзя прогнозировать заранее. В практике работы учителя госпитальной школы встречаются уникальные случаи, требующие особого подхода, методов и средств обучения (включая методы нейропсихологической коррекции), отличающиеся от всех ранее применяемых учителем [4, 5].

Рассмотрим опыт организации учебного процесса с двумя учащимися, один из которых после инсульта временно утратил функцию речи (кейс 1), а другой - тотально ослеп как следствие онкологического заболевания (кейс 2). Оба кейса схожи тем, что указанные учащиеся обучались в 11 классе и находились на длительном лечении и восстановлении в высокотехнологических медицинских стационарах: НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии – Клинике доктора Рошала.

Отметим, что учащиеся обоих кейсов имеют статус инвалидов. При этом у обоих учащихся отмечаются сохраненные когнитивные функции, наблюдается высокий уровень учебной мотивации, проявляющейся в цели, которую они перед собой поставили: принять участие в государственной итоговой аттестации по русскому языку и литературе не в формате государственного выпускного экзамена (ГВЭ), а в более сложном формате – единого государственного экзамена ЕГЭ. В связи с этим перед учителем стояла трудная задача - выстроить коммуникацию и взаимодействие с этими учащимися с учетом не только образовательного запроса, но и ограниченных возможностей их здоровья.

У учащегося (кейс 1) во время плановой операции по устранению патологии сосудов головного мозга произошел обрыв катетера с последующим обширным кровоизлиянием в головной мозг. Ребенок был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Вследствие болезни девочка утратила функцию речи и находилась на реабилитации в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, после которой смогла начать учебу с педагогами Проекта госпитальных школ «УчимЗнаем». Работа с данным учащимся была построена на основе рекомендаций нейропсихологов центра и психолого-педагогических принципов восстановительного обучения, основанных на

принципах: от простого к сложному, учета объема и степени разнообразия материала, учета эмоциональной сложности материала и др. [6, 7].

Из-за отсутствия речи вербальная коммуникация с данным обучающимся строилась особым образом: говорил только педагог, а ребенок слушал и давал обратную связь письменно. Темп коммуникации в таком случае медленным, что приводило к быстрой утомляемости и влияло на продуктивность занятий. Для реализации поставленной цели: написать итоговое сочинение, получить допуск к экзамену и сдать ЕГЭ по русскому языку обучающемуся было предложено на некоторое время отказаться от привычного письма, вместо этого использовать блокнот планшета. Задания строились с учетом поступательной динамики, постепенного перехода от простого к сложному: тесты были разделены на тематические группы и преобразованы в карточки с количеством заданий от 1 до 3. Для выполнения работы необходимо было учитывать продолжительность занятия, согласованную с врачами отделения.

В рамках работы с обучающимся (кейс 2, потеря зрения из-за ретинобластомы) осложнялась личным запросом – отказом от использования Брайля на уроках. Ученик предпочитает пользоваться другими системами расшифровки текстов, в отличие от Брайля, экономящих его время и силы.

Все тестовые задания необходимо было переводить в электронную форму так как приложение для слепых уже преобразует в звуковой файл. Отказавшись от Брайля, использовали на уроке компьютер с установленной программой для слепых (проговаривание слов). Большое внимание было отведено устной словарной работе: изучение значений слов, поиск синонимов и антонимов. Если на занятиях было решено отказаться от Брайля, то домашнюю работу выполняли с помощью тактильной системы письма, так как экзамен необходимо было сдавать на Брайле.

В связи с тем, что второй обучающийся поставил цель сдать не только русский язык, но и литературу возникли другие трудности, связанные с написанием письменных работ. В таких случаях необходимо с помощью специального приложения переводить Брайль в текст и проверять работу. Особую сложность представляли задания, связанные с изучением лирики. Из-за недостатка личного жизненного опыта и знаний графических схем стихотворных размеров учащемуся поэтические произведения вызвали трудности. При подготовке по русскому языку трудности вызвали задания на сопоставление, так как при записи ответа на Брайле нет пропусков: всю комбинацию цифр нужно было удержать в памяти.

Оба учащиеся успешно прошли итоговую аттестацию в формате ЕГЭ, что подтвердило правильность выстроенной с ними работы. Данный опыт может быть использован тьюторами госпитальных школ при работе с другими учащимися, имеющими особые образовательные потребности.

Литература

1. Баева, И.А. Психологическое проектирование профессиональной деятельности педагога в условиях неопределенности / И.А. Баева, А.Н. Тауренис // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. – 2017. – № 186. – С. 13-19.
2. Шариков, С.В. Госпитальная педагогика как мотивация развития прогрессивного сознания общества и социальной инклюзии / С.В. Шариков, Т.В.

Волкова // Современное дошкольное образование: теория и практика. Электронный журнал. – 2023. – № 10. – С. 2-23.

3. Обухов, А.С. Профессиональный путь госпитального педагога / А.С. Обухов, А.А. Грошева, В.В. Умрихина // Проблемы современного образования. – 2023. – № 6. – С. 104-116.

4. Закрепина, А.В. Коррекционное обучение детей с тяжелой черепно-мозговой травмой в условиях стационара / А.В. Закрепина / Специальное образование. – 2014. – № II (X). – С. 105-108.

5. Аутина, Т.В. Нейропсихолог в школе. Пособие для педагогов. Индивидуальный подход к детям с трудностями обучения в условиях общего образования / Т.В. Аутина, И.О. Камардина, Н.М. Пылаева. – М.: В. Секачев. – 2024. – 57 с.

6. Цветкова, Л.С. Восстановительное обучение при локальных поражениях мозга. – М.: МГУ. – 1972. – 376 с.

7. Асмерзаева, С.И. Психологическое сопровождение детей, находящихся на длительном лечении : Методические рекомендации для специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение детей с соматическими заболеваниями в госпитальных школах и на домашнем обучении / С.И. Асмерзаева, А.А. Бриллиантова, В.Д. Володенков [и др.]. – Москва : Московский государственный психолого-педагогический университет. – 2024. – 133 с.

References

1. Baeva, I.A. Psixologicheskoe proektirovanie professional'noj deyatel'nosti pedagoga v usloviyax neopredelennosti / I.A. Baeva, A.N. Taurenis // Izvestiya RGPU im. A. I. Gercena. – 2017. – № 186. – S. 13-19.

2. Sharikov, S.V. Gospital'naya pedagogika kak motivaciya razvitiya progressivnogo soznaniya obshhestva i social'noj inklyuzii / S.V. Sharikov, T.V. Volkova // Sovremennoe doshkol'noe obrazovanie: teoriya i praktika. E'lektronny'j zhurnal. – 2023. – № 10. – S. 2-23.

3. Obuxov, A.S. Professional'ny'j put' gospital'nogo pedagoga / A.S. Obuxov, A.A. Grosheva, V.V. Umrixina // Problemy' sovremennogo obrazovaniya. – 2023. – № 6. – S. 104-116.

4. Zakrepina, A.V. Korrekcionnoe obuchenie detej s tyazhelej cherepno-mozgovoj travmoj v usloviyax stacionara / A.V. Zakrepina / Special'noe obrazovanie. – 2014. – № II (X). – S. 105-108.

5. Autina, T.V. Nejropsixolog v shkole. Posobie dlya pedagogov. Individual'ny'j podxod k detyam s trudnostyami obucheniya v usloviyax obshhego obrazovaniya / T.V. Autina, I.O. Kamardina, N.M. Py'laeva. – M.: V. Sekachev. – 2024. – 57 s.

6. Czvetkova, L.S. Vosstanovitel'noe obuchenie pri lokal'ny'x porazheniyax mozga. – M.: MGU. – 1972. – 376 s.

7. Asmerzaeva, S.I. Psixologicheskoe soprovozhdenie detej, naxodyashhixsya na dlitel'nom lechenii : Metodicheskie rekomendacii dlya specialistov, osushhestvlyayushhix psixologo-pedagogicheskoe soprovozhdenie detej s somaticheskimi zabolevaniyami v gospital'ny'x shkolax i na domashnem obuchenii / S.I. Asmerzaeva, A.A. Brilliantova, V.D. Volodenkov [i dr.]. – Moskva : Moskovskij gosudarstvenny'j psixologo-pedagogicheskij universitet. – 2024. – 133 s.

УДК 376.23

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИММОБИЛИЗИРОВАННОГО РЕБЕНКА ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЕДИНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ

Разбегин Тимофей Анатольевич

специализированное структурное подразделение
ГБОУ Школа № 109 «Госпитальная школа «УчимЗнаем»

тьютор

razbegin.ta@uchimznaem.ru

Глезь Александра Маратовна

специализированное структурное подразделение
ГБОУ Школа № 109 «Госпитальная школа «УчимЗнаем»

тьютор

glez.am@uchimznaem.ru

SUPPORTING AN IMMOBILIZED CHILD IN PREPARATION FOR THE UNIFIED STATE EXAM (USE)

Razbegin Timofei Anatolyevich

specialized structural unit GBOU School № 109
“Hospital school “We Teach/They Learn”

tutor

razbegin.ta@uchimznaem.ru

Glez Alexandra Maratovna

specialized structural unit GBOU School № 109
“Hospital school “We Teach/They Learn”

tutor

glez.am@uchimznaem.ru

Аннотация. Подготовка к единому государственному экзамену имобилизированного ребенка в госпитальной школе требует особого подхода. Ключевыми аспектами являются психологическая поддержка для снижения тревожности и создание гибкого индивидуального образовательного маршрута. Важную роль играет использование адаптированных форматов работы, включая дистанционные технологии, современную аппаратуру и тесное взаимодействие педагога с медицинским персоналом, психологом и семьёй. Главная цель – интегрировать подготовку к экзамену в процесс реабилитации, минимизируя стресс и поддерживая учебную мотивацию ребёнка.

Ключевые слова: госпитальная педагогика, имобилизированный ребёнок, единый государственный экзамен, психологическая поддержка, индивидуальный образовательный маршрут, айтирекер, адаптация обучения, междисциплинарное взаимодействие, реабилитация.

Abstract. Preparing an immobile child for the Unified State Exam (USE) in a hospital school requires a specific strategy. Key aspects include psychological support to reduce anxiety and the creation of a flexible, individualized educational plan. The use of adapted formats, including remote technologies, modern equipment and close collaboration between the teacher, medical staff, psychologist, and the family is crucial. The main goal is to integrate exam preparation into the rehabilitation process, minimizing stress and supporting the child's learning motivation.

Keywords: hospital pedagogy, immobile child, Unified State Exam, psychological support, individualized educational plan, eye tracker, learning adaptation, interdisciplinary collaboration, rehabilitation.

Сопровождение иммобилизованного ребенка в период подготовки к государственной итоговой аттестации (ГИА) представляет собой сложную педагогическую и психологическую задачу, требующую выхода за рамки традиционного индивидуализированного подхода, а также использование методов альтернативной коммуникации. Такой подход полностью соответствует принципам госпитальной педагогики, которая, как отмечают А.Ф. Лоскутов, С.В. Шариков и др., является современным направлением, призванным обеспечить непрерывность образовательного процесса для детей, находящихся на длительном лечении, и интегрировать обучение в процесс реабилитации [1]. Ключевой приоритет в этой работе – создание эмоционально безопасной среды, где снижение ситуативной и личностной тревожности, а также целенаправленное формирование уверенности в себе становятся не просто фоном, а основой для эффективного усвоения знаний.

Работа тьюторов-предметников (по русскому языку и математике) выстраивается на основе гибкого индивидуального образовательного маршрута (ИОМ). Его гибкость заключается в постоянной корректировке, учитывающей не только академические пробелы ученика, но и его ежедневное физическое и психоэмоциональное состояние. ИОМ становится динамичным инструментом, который позволяет дозировать учебную нагрузку, чередовать формы работы и адаптировать содержание материала. Особое значение приобретает использование адаптивных форматов работы с применением дистанционных технологий, которые обеспечивают непрерывность образовательного процесса даже при ухудшении состояния ребенка. Использование специализированного оборудования, например, айтрекера (устройства, определяющего направление взгляда), позволяет организовать учебную деятельность для детей с выраженными ограничениями мобильности, обеспечивая им доступ к цифровой образовательной среде и возможность коммуникации с педагогом.

Важнейшим условием успеха является тесное междисциплинарное взаимодействие. Изолированные усилия тьютора не будут эффективны без интеграции в общую систему поддержки ребенка. Это взаимодействие включает:

1. Координацию действий с врачами и реабилитологами: для понимания режима нагрузок, периодов активности и усталости, влияния медикаментов на когнитивные функции.

2. Сотрудничество со специалистами службы психолого-педагогического и социального сопровождения: для выработки единой стратегии по снижению тревожности и поддержанию мотивации.

3. Партнерство с семьей: как подчеркивают О.А. Подольская и И.В. Яковлева, психолого-педагогическое сопровождение семьи, находящейся в ситуации кризиса, является неотъемлемой частью успешной адаптации и развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья [2]. Родители становятся активными участниками образовательного процесса, а тьютор оказывает им консультативную поддержку.

Только такой комплексный подход позволяет сделать подготовку к ЕГЭ не источником дополнительного стресса, а осмысленной и управляемой деятельностью, которая становится гармоничной частью общей реабилитационной программы.

В работе с детьми, имеющими тяжелые и прогрессирующие заболевания, необходимо проявлять особую чуткость и гибкость. Как указывает С.В. Шариков, обучение таких детей требует смещения акцентов с академических результатов на качество жизни, развитие личности и поддержание социальных связей [3]. В контексте подготовки к ЕГЭ это означает, что образовательный маршрут должен включать «точки гибкости», где планы могут быть оперативно пересмотрены в пользу психологического комфорта ребенка. Задача педагога — видеть в ребенке прежде всего личность, а не ученика, сдающего экзамен.

Таким образом, сопровождение имобилизованного ребенка при подготовке к ЕГЭ — это комплексная деятельность, основанная на принципах госпитальной педагогики. Она интегрирует в себе адаптивное обучение с использованием современных технологий, выстроенное на основе гибкого ИОМ, и опирается на прочную систему междисциплинарного взаимодействия тьюторов, медицинских работников, психологов и семьи. Такой подход позволяет минимизировать стресс и сделать образовательный процесс поддерживающим элементом в трудной жизненной ситуации семьи и ребенка

Литература

1. Лоскутов, А.Ф. Госпитальная педагогика как современное направление в педагогической науке / А.Ф. Лоскутов, С.В. Шариков, Е.А. Ямбург, А.Г. Румянцев // Народное образование. – 2023. – № 1. – С. 166-173.
2. Подольская, О.А. Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзии: учебное пособие / О.А. Подольская, И.В. Яковлева // Директ-Медиа. – 2020. – 76 с.
3. Шариков, С.В. Обучение детей с прогрессирующими заболеваниями, ограничивающими продолжительность жизни. Начало пути / С.В. Шариков // Паллиативная и хосписная помощь. PALLIUM. Российский научно-практический журнал. – 2020. – № 2 (7). – С. 23-31.

References

1. Loskutov, A.F. Hospital'naya pedagogika kak sovremennoe napravlenie v pedagogicheskoy nauke / A.F. Loskutov, S.V. SHarikov, E.A. YAmburg, A.G. Rumyanцев // Narodnoe obrazovanie. – 2023. – № 1. – S. 166-173.
2. Podol'skaya, O.A. Psihologo-pedagogicheskoe soprovozhdenie sem'i rebenka s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorov'ya v usloviyah inklyuzii: uchebnoe posobie / O.A. Podol'skaya, I.V. YAkovleva // Direkt-Media. 2020. – 76 s.
3. SHarikov, S.V. Obuchenie detej s progressiruyushchimi zabolevaniyami, ogranichivayushchimi prodolzhitel'nost' zhizni. Nachalo puti / S.V. SHarikov // Palliativnaya i hospisnaya pomoshch'. PALLIUM. Rossijskij nauchno-prakticheskij zhurnal. – 2020. – № 2 (7). – S. 23-31.

УДК 372.853, 372.854

**УЧЕБНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В ОБУЧЕНИИ ПРЕДМЕТАМ
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ЦИКЛА В ГОСПИТАЛЬНОЙ ШКОЛЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ПОДХОДЫ**

Абаева Дарья Александровна
специализированное структурное подразделение
ГБОУ Школа № 109 «Госпитальная школа «УчимЗнаем»
тьютор
abaeva.da@uchimznaem.ru

Широва Мария Феликсовна
специализированное структурное подразделение
ГБОУ Школа № 109 «Госпитальная школа «УчимЗнаем»
тьютор
shirova.mf@uchimznaem.ru

**EDUCATIONAL EXPERIMENT IN TEACHING SCIENCE
SUBJECTS IN HOSPITAL SCHOOLS: PROBLEMS AND APPROACHES**

Abaeva Daria Aleksandrovna
specialized structural unit GBOU School № 109
“Hospital school “We Teach/They Learn”
tutor
abaeva.da@uchimznaem.ru

Shirova Mariya Feliksovna
specialized structural unit GBOU School № 109
“Hospital school “We Teach/They Learn”
tutor
shirova.mf@uchimznaem.ru

Аннотация. Рассматриваются проблемы в реализации требований федерального государственного образовательного стандарта к достижениям образовательных результатов учащимися госпитальных школ по предметам естественно-научного цикла, связанных с учебным экспериментом. Охарактеризованы различные научно-методические подходы к использованию видео- и натурного эксперимента в урочной и внеурочной деятельности.

Ключевые слова: учебный эксперимент, натурный эксперимент, видео-эксперимент, процесс обучения физике и химии в госпитальной школе, длительно болеющие школьники.

Abstract. The report is devoted to the difficulties of implementing the Federal State Educational Standards requirements for achieving learning outcomes in science subjects related to educational experiment for students in hospital schools. A range of scientific and methodological approaches of using video and natural experiments in classroom and extracurricular activities are described.

Keywords: educational experiment, natural experiment, video experiment, the process of teaching physics and chemistry in hospital schools, students undergoing long-term medical treatment.

Важность учебного эксперимента регламентирована Федеральным государственным образовательным стандартом [1]. Физика и химия – это предметы, которые должны преподаваться на экспериментальной основе, поскольку учебный эксперимент в предметах естественно-научного цикла является как специфическим методом познания, так и средством обучения, а также мощным средством развития познавательного интереса к предмету [2], средством мотивации и развития учащихся. Только через эксперимент ученик может увидеть связь теории с реальным миром, окружающим нас.

В госпитальной школе существуют некоторые особенности, осложняющие проведение учебного эксперимента [3, 4]:

1. Особенности состояния здоровья учеников.
2. Санитарно-эпидемиологические требования высокотехнологичных медицинских стационаров; отсутствие профильных кабинетов и проведение уроков в больничных палатах, что препятствует использованию общепринятого учебного оборудования по физике и химии, а также химических реактивов.
3. Различие в предельной нагрузке в учебном плане госпитальной и общеобразовательной школ: на физику и химию выделяется всего один час в неделю.
4. Наличие обеспечения смешанного и гибридного формата занятий.

Совокупность указанных факторов приводит к необходимости в адаптации учебного эксперимента и методики его проведения к условиям работы в медицинском стационаре.

Практика обучения химии в госпитальной школе показывает, что наиболее оптимальной альтернативой реальному химическому эксперименту является видеозапись соответствующего опыта.

При обучении физике, помимо видео-эксперимента, используется натурный эксперимент с оборудованием, адаптированным к условиям госпитальной школы, то есть, отвечающим следующим требованиям: мобильность и возможность санитарно-гигиенической обработки.

Использование видео-эксперимента на уроках физики и химии осуществляется с применением особых средств обучения: рабочих листов с заданиями, тестовых опросов с опорой на видео-опыт и готовых лабораторных журналов.

Натурный эксперимент, являясь инструментом формирования познавательного интереса, используется и во внеурочной деятельности: при проведении межпредметных интегрированных мероприятий проектно-

исследовательского характера, при выполнении домашних творческих работ, является частью проектной деятельности учащихся.

Обозначенные подходы при проведении учебного эксперимента в госпитальной школе позволяют создать условия, при которых у школьников, находящихся в изолированном пространстве больничного стационара, могут быть сформированы следующие экспериментальные умения: выдвигать гипотезы, наблюдать явления, представлять результаты эксперимента в форме выводов и доказательств, устанавливать связи между реально наблюдаемыми явлениями и процессами, происходящими в макро- и микро-мире [1]. Способствуют развитию познавательного интереса к изучению предметов естественно-научного цикла и, как следствие, формированию устойчивой учебной мотивации и созданию благоприятного эмоционального фона.

Литература

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287. – URL: <https://fgosreestr.edsoo.ru/federal-standard/30> (Дата обращения 10.09.2025).
2. Пак, М.С. Дидактика химии : учебное пособие для студ.высш.учеб. заведений / М.С. Пак. – М. : Гуманитарн. изд. центр ВЛАДОС. – 2004. – 315 с.
3. Лоскутов, А.Ф. Обучение физике школьников, находящихся на длительном лечении в стационарах медицинских учреждений: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Лоскутов Александр Фёдорович ; науч. рук. Н. С. Пурышева ; МПГУ. – Москва. – 2020. – 218 с.
4. Шариков, С.В. Педагогическая поддержка образовательных возможностей детей, находящихся на длительном лечении в медицинских стационарах / С.В. Шариков // Альманах Института коррекционной педагогики. – 2020. – № 40. – С. 22-42.

References

1. Federal'nyj gosudarstvennyj obrazovatel'nyj standart osnovnogo obshhego obrazovaniya / Prikaz Minprosveshheniya Rossii ot 31.05.2021 № 287. – URL: <https://fgosreestr.edsoo.ru/federal-standard/30> (Data obrashheniya 10.09.2025).
2. Pak, M.S. Didaktika khimii : uchebnoe posobie dlya stud.vy'ssh.ucheb. zavedenij / M.S. Pak. – M. : Gumanitarn. izd. centr VLADOS. – 2004. – 315 s.
3. Loskutov, A.F. Obuchenie fizike shkol'nikov, naxodyashhixsya na dlitel'nom lechenii v stacionarax medicinskix uchrezhdenij: dis. ... kand. ped. nauk : 13.00.02 / Loskutov Aleksandr Fyodorovich ; nauch. ruk. N. S. Pury'sheva ; MPGU. – Moskva. – 2020. – 218 s.
4. Sharikov, S.V. Pedagogicheskaya podderzhka obrazovatel'ny'x vozmozhnostej detej, naxodyashhixsya na dlitel'nom lechenii v medicinskix stacionarax / S.V. Sharikov // Al'manax Instituta korrekcionnoj pedagogiki. – 2020. – № 40. – S. 22-42.

УДК 372.853

**УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ ГОСПИТАЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА
УРОКАХ ИЗУЧЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА ПО ФИЗИКЕ**

Медведева Анастасия Сергеевна
специализированное структурное подразделение ГБОУ Школа № 109
«Госпитальная школа «УчимЗнаем»
тьютор
Medvedeva.as@uchimznaem.ru

**CONSIDERATION OF INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL AND
PEDAGOGICAL CHARACTERISTICS IN HOSPITAL SCHOOL
STUDENTS IN PHYSICS LESSONS ON NEW TOPICS**

Medvedeva Anastasia Sergeevna
specialized structural unit GBOU School № 109
“Hospital school “We Teach/They Learn”
tutor
Medvedeva.as@uchimznaem.ru

Аннотация. В статье поднимается вопрос организации уроков изучения нового материала по физике в госпитальной школе. Раскрывается использование карт индивидуальных особых потребностей для учета индивидуальных психолого-педагогических особенностей детей, обучающихся в госпитальной школе. Приводятся примеры организации уроков изучения нового материала по физике при выполнении мини-проектов и организации исследовательской деятельности.

Ключевые слова: уроки изучения нового материала, групповая форма работы, учебное исследование, психолого-педагогические особенности, госпитальная школа, дети, находящиеся на длительном лечении.

Abstract. This article focuses on the issue of organizing physics lessons on new topic in a hospital school. It describes the use of individual special needs profiles to address the individual psychological and pedagogical characteristics of students in a hospital school. Examples of organizing lessons on learning new physics topic through mini-projects and research activities are provided.

Keywords: lessons on learning new topic, group work, educational research, psychological and pedagogical features, hospital school, children undergoing long-term treatment.

Современная система образования в России нацелена на предоставление равного доступа к качественному обучению для всех детей [1]. Госпитальная школа, как уникальная образовательная среда, сталкивается с множеством вызовов, которые существенно отличаются от тех, что существуют в обычных школах [2]. Один из вызовов заключается в том, что учителю необходимо не только обеспечить усвоение знаний согласно Федеральному государственному образовательному стандарту, но и учитывать разнообразные психофизические и эмоциональные состояния ребенка, вызванные его болезнью.

Ключевым моментом в изучении любой дисциплины, включая физику, является освоение нового материала, которое закладывает основу для понимания законов природы и формирования научного мировоззрения. Однако в условиях госпитальной школы, где обучение носит прерывистый характер из-за медицинских процедур и переменчивого самочувствия учеников, общепринятый фронтальный метод объяснения нового материала становится нерезультативным и даже в некоторых случаях невозможным. Это ставит перед педагогом задачу по индивидуализации образовательного процесса.

Длительное пребывание в больнице и борьба с жизнеугрожающим заболеванием оказывают негативное воздействие на психофизиологическое состояние ребенка. Помимо физических страданий, дети сталкиваются с комплексом психологических трудностей, включая тревогу, страх, депрессию, а также чувство изоляции и беспомощности [3]. Исследования показывают, что у детей с онкологическими заболеваниями часто развиваются тревожные расстройства, наблюдается эмоциональная неустойчивость. Это может проявляться в страхе перед медицинскими процедурами, изменениях в поведении и потере интереса к играм и общению со сверстниками [4].

При обучении физике детей, находящихся на длительном лечении, важно принимать во внимание их психоэмоциональное состояние, уровень тревожности, страхи, депрессию, а также возможные проблемы с концентрацией, памятью и мотивацией к учебе [5].

В госпитальных школах образовательный процесс строится на принципах смешанного и гибридного обучения [6, 7]. Такая модель необходима из-за индивидуальных особенностей каждого ребенка, разной стадии лечения, самочувствия и возможности посещать занятия. Учитывая, что не все дети одинаково усваивают информацию при онлайн-занятиях и самостоятельной работе, требуется разработка индивидуальных подходов.

В качестве одного из подходов, отвечающего указанным выше требованиям, является изучение нового материала по физике посредством организации кратковременной проектной или исследовательской групповой работы. Содержание мини-проекта или исследовательской, практической работы базируется на основных положениях нового материала. Такой подход возможен в следующих ситуациях:

1. Рассматриваются свойства физического явления (например, явление испарения жидкостей и т.п.).
2. Изучается эмпирическая зависимость или закон (например, закон Ома для участка цепи, формула для давления твердых тел и т.д.).

3. Анализируется суть фундаментального опыта или принцип действия технического устройства.

Групповая форма работы организуется по заранее определенным учителем ролям, а сами роли определяются исходя из особенностей данной конкретной группы учащихся. Для каждого учащегося подбирается индивидуальное задание, которое, с одной стороны, учитывает его психолого-педагогические особенности, а с другой стороны – направлено на развитие тех универсальных учебных действий, в которых у данного ребенка отмечаются дефициты. Обязательным условием является организация взаимодействия учащихся в процессе выполнения работы. Для этого используется взаимозависимость результатов обучающихся, так как оценивается не столько личный вклад, сколько общие результаты по достижению поставленной цели. Кроме того, по возможности организуется взаимопомощь в парах для более результативной работы с учетом физиологических особенностей обучающихся. При проведении итогов работы уделяется внимание не только всем необходимым элементам нового материала, но и всем аспектам деятельности учащихся по достижению результата.

Приведем два примера организации занятий изучения нового материала с использованием исследовательской работы и мини-проекта. В первом примере рассмотрим группу учащихся, которые занимаются в гибридном формате. Укажем особенности детей в данной группе, которые описаны в картах индивидуальных образовательных потребностей (КИОП).

Анна. Имеет ограниченную подвижность рук, однако обладает большим интересом к экспериментам. Лучше всего воспринимает информацию через прикосновения и визуально.

Максим. Быстро устает и испытывает трудности с концентрацией внимания. Ему нужны четкие инструкции и быстрые результаты.

Кирилл. Из-за болезни находится в лежачем положении. Хорошо воспринимает информацию на слух и имеет глубокие знания в математике.

Урок начинается с проблемного вопроса, стимулирующего размышления: «Почему лыжи не проваливаются в снег?». Обсуждение проходит в классе с использованием видеозвонка, чтобы Кирилл мог участвовать в уроке.

После обсуждения проводится практическая работа. Ученики проводят эксперимент, используя пластилин, грузики разной массы и набор палочек. Цель эксперимента: выяснить, как площадь опоры и масса грузов влияет на глубину погружения груза в пластилин.

У каждого ученика своя роль в эксперименте. Анна совместно с учителем проводит эксперимент. Максим записывает результаты в специальную таблицу, которая открыта на онлайн-доске. Кирилл выступает в роли аналитика. На основе полученных данных он делает выводы о зависимости величин.

После проведения эксперимента и его обсуждения проводится первичное закрепление полученных знаний. На онлайн-доске появляются задачи с рисунками. Кириллу предлагается отдельное дополнительное задание.

На втором примере рассмотрим группу учащихся, которые занимаются в смешанном формате. Укажем особенности детей в данной группе, которые описаны в КИОПах.

Мария. Часто пропускает занятия из-за плохого самочувствия. Общительная, предпочитает творческие задания.

Артем. Малообщительный. Лучше всего работает с текстами и схемами.

Света. Слабовидящая. Хорошо воспринимает информацию на слух. Может работать с текстами, которые написаны крупными белыми буквами на черном фоне, или на доске в увеличенном масштабе.

Цель урока – создание совместного цифрового продукта – интерактивного плаката, который объясняет эксперимент Торричелли.

Учитель формулирует перед учащимися задачу: «Создать интерактивный плакат, который поможет объяснить современному школьнику, как и почему работает эксперимент Торричелли», а также предоставляет учащимся необходимые материалы в цифровом виде.

У каждого учащегося своя роль в проектной работе. Артем отвечает за переработку информации в цитаты и схемы для будущего плаката, Света продумывает краткий рассказ об опыте. Артем помогает Свете изучать информацию, читает ей тексты. Марии необходимо подготовить иллюстрации и оформить основу для плаката.

После того, как все элементы плаката готовы, педагог совместно с ребятами соединяет все в специальной программе. В конце занятия проводится обсуждение полученных в ходе урока знаний.

Обеспечение индивидуального подхода в рамках смешанного и гибридного обучения позволяет учесть индивидуальные особенности каждого ученика, которые прописываются в КИОПах. Практика проведения уроков физики с использованием мини-проектов и исследований показала свою высокую результативность. Данный метод превращает обычные занятия в увлекательную для каждого ученика деятельность, что позволяет им найти свой путь к успеху, проявить самостоятельность, а также почувствовать свою значимость. Взаимозависимая и взаимоподдерживающая групповая работа способствует не только глубокому пониманию физических явлений, но и развитию навыков общения, преодолению изоляции и созданию благоприятной психологической атмосферы в коллективе.

Литература

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (Дата обращения 07.12.2025).
2. Шариков, С.В. Создание образовательной среды для детей, находящихся на длительном лечении в стационарах медицинских учреждений / С.В. Шариков // Российский журнал детской гематологии и онкологии. – 2015. – Т.2, № 4. – С. 65-73.
3. Киреева И.П. Различия в оценке тяжести депрессии врачами и пациентами в процессе комбинированной терапии агомелатином

(мультицентровое исследование «ЭМОЦИЯ») / В.Э. Медведев, К.Ю. Ретнский, А.А. Овчинников, Ю.Б. Барыльник, А.А. Шмилович, Е.Ю. Антохин, Г.М. Усов, Р.А. Черемин, В.М. Полецкий, А.В. Онегин, И.П. Киреева, В.И. Фролова, Н.В. Филиппова, А.А. Антонова, М.А. Деева, Д.А. Онегина // Журнал Неврологии и Психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2016. – № 11. – С. 26-34.

4. Аноприенко, Е.В. Психологическая поддержка детей с онкогематологической патологией методом сенсорной интеграции «сенсорная комната» / Е.В. Аноприенко, Т.Л. Ковальская, А.И. Меркотан // Сборник тезисов VI Всероссийского съезда онкопсихологов. – М.: Издательский центр АНО «Проект СО-действие». – 2014. – С. 7-9.

5. Лоскутов, А.Ф. Обеспечение непрерывности обучения физике школьников, находящихся на длительном лечении в стационарах медицинских учреждений / А.Ф. Лоскутов, Н.С. Пурышева // Наука и школа. – 2022. – № 1. – С. 134-148.

2. Медведева, А.С. Смешанное обучение в практике госпитальных школ / А.С. Медведева, А.Ф. Лоскутов // Школа будущего. – 2024. – №3. – С. 72-84.

3. Медведева, А.С. Гибридное обучение в практике госпитальных школ / А.С. Медведева, А.Ф. Лоскутов // Школа будущего. – 2025. – №1. – С. 84-99.

References

1. Federal'ny'j zakon «Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii» ot 29.12.2012 № 273-FZ. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (Accessed 07.12.2025).

2. Sharikov, S.V. Sozдание obrazovatel'noj sredy` dlya detej, naxodyashhixsya na dlitel'nom lechenii v stacionarax medicinskix uchrezhdenij / S.V. Sharikov // Rossijskij zhurnal detskoj gematologii i onkologii. – 2015. – T.2, № 4. – S. 65-73.

3. Kireeva I.P. Razlichiya v ocenke tyazhesti depressii vrachami i pacientami v processe kombinirovannoj terapii agomelatinom (mul'ticentrovoe issledovanie «E`MOCIYa») / V.E`. Medvedev, K.Yu. Retnskij, A.A. Ovchinnikov, Yu.B. Baryl'nik, A.A. Shmilovich, E.Yu. Antoxin, G.M. Usov, R.A. Cheremin, V.M. Poleczkij, A.V. Onegin, I.P. Kireeva, V.I. Frolova, N.V. Filippova, A.A. Antonova, M.A. Deeva, D.A. Onegina // Zhurnal Nevrologii i Psixiatrii imeni S.S. Korsakova. – 2016. – № 11. – S. 26-34.

4. Anoprienko, E.V. Psixologicheskaya podderzhka detej s onkogematologicheskoy patologiej metodom sensornoj integracii «sensornaya komnata» / E.V. Anoprienko, T.L. Koval'skaya, A.I. Merkotan // Sbornik tezisev VI Vserossijskogo s`ezda onkopsixologov. – M.: Izdatel'skij centr ANO «Proekt SO-dejstvie». – 2014. – S. 7-9.

5. Loskutov, A.F. Obespechenie neprery`vnosti obucheniya fizike shkol'nikov, naxodyashhixsya na dlitel'nom lechenii v stacionarax medicinskix uchrezhdenij / A.F. Loskutov, N.S. Pury'sheva // Nauka i shkola. – 2022. – № 1. – S. 134-148.

6. Medvedeva, A.S. Smeshannoe obuchenie v praktike gospital'ny`x shkol / A.S. Medvedeva, A.F. Loskutov // Shkola budushhego. – 2024. – № 3. – S. 72-84.

7. Medvedeva, A.S. Gibridnoe obuchenie v praktike gospital'ny`x shkol / A.S. Medvedeva, A.F. Loskutov // Shkola budushhego. – 2025. – № 1. – S. 84-99.

УДК 372.854

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО УРОКА ХИМИИ С НОВЫМ УЧЕНИКОМ В ГОСПИТАЛЬНОЙ ШКОЛЕ (на примере 10 класса)

Дзенис Анна Валерьевна

кандидат педагогических наук

специализированное структурное подразделение

ГБОУ Школа № 109 «Госпитальная школа «УчимЗнаем»

тьютор

dzenis.av@uchimznaem.ru

FEATURES OF THE FIRST CHEMISTRY LESSON WITH A NEW STUDENT AT A HOSPITAL SCHOOL (using the example of 10th grade)

Dzenis Anna Valeryevna

Candidate of Pedagogical Sciences

specialized structural unit GBOU School № 109

“Hospital school “We Teach/They Learn”

tutor

dzenis.av@uchimznaem.ru

Аннотация. Рассматриваются особенности проведения первого урока химии с десятиклассниками, нуждающимися в длительном лечении, в госпитальной школе.

Ключевые слова: госпитальная школа, длительно болеющие учащиеся, изучение химии.

Abstract. This article examines the specific challenges of conducting an introductory chemistry lesson for tenth-grade students undergoing long-term medical treatment in a hospital school setting.

Keywords: hospital school, children undergoing long-term medical treatment, studying chemistry.

Первое занятие с новым учеником в госпитальной школе имеет особое значение, так как от него во многом зависит готовность школьника к продолжению учебы во время длительного лечения [1].

Курс органической химии (на базовом уровне) в 10 классе предполагает изучение большого объема новой учебной информации и формирование разнообразных новых умений в сжатые сроки – при 1 уроке химии в неделю.

Высокая интенсивность изучения курса химии в 10 классе в сочетании с пропусками занятий по медицинским показаниям длительно болеющим учеником в школе по месту жительства часто приводят к его слабой ориентации в программном материале. Помимо этого, необходимо учитывать, что на базовом уровне химию изучают старшеклассники, у которых могли уже возникать

сложности с пониманием предмета в 8 или 9 классах. Поэтому для таких школьников-пациентов особенно важно поверить в себя на первом занятии.

В соответствии с общим подходом к проведению первого урока химии в госпитальной школе [2] после предварительного знакомства с десятиклассником предлагаем ему отметить на «карте предмета» одним цветом последнюю изученную тему, а другим цветом - те темы, которые он понял лучше. Помимо этого, в устной беседе просим ученика назвать тот учебный материал, который ранее вызвал у него наибольшие затруднения при изучении в школе по месту жительства. После этого предоставляем ему возможность выбрать тему нашего первого занятия.

Достаточно часто темой первого урока десятиклассники выбирают ту, которую они не поняли ранее. В таком варианте осознанный выбор учеником восполнения имеющихся у него учебных дефицитов является фактором, побуждающим его к активной познавательной деятельности на этом занятии. А последующее переживание им ситуации успеха как результата понимания того, что раньше казалось сложным, и приобретения новых учебных умений, мотивирует школьника к продолжению изучения химии в условиях медицинского стационара.

Реже встречаются случаи, когда старшеклассник на первом занятии хотел бы повторить последнюю изученную в своей школе тему или начать знакомство с новой темой.

При любом выборе ученика далее необходима актуализация тех знаний и умений, которые являются основой для восприятия избранного учебного материала. В ходе проведения данного этапа урока педагогу целесообразно использовать опорный иллюстративный материал для организации беседы (ответов на вопросы, составления устного рассказа), интерактивные задания вида «вставить пропущенные слова в предложения» (с использованием выпадающих списков слов), «выбрать верные утверждения», «дополнить таблицу» («перетаскивание объектов»). В процессе такой познавательной деятельности старшеклассник сможет вспомнить (или восполнить) необходимую теоретическую информацию, восстановив краткий текст или дополнив обобщающую таблицу, создав для себя дополнительный опорный материал. Важно, чтобы учащийся сам мог в процессе работы проверять свои ответы и при необходимости вносить в них изменения. Кроме этого, в случае затруднений следует предложить десятикласснику разнообразные «подсказки», наводящие вопросы, которые помогут ему прийти к верным ответам и уменьшат опасения допустить ошибку. Характер затруднений, который испытывал школьник, подскажет педагогу, какие вопросы нужно будет дополнительно рассмотреть вместе с ним на последующих уроках. Таким образом стадия актуализации необходимых знаний и умений позволит осуществить одновременно и бережную диагностическую и обучающую задачи.

В практике учителя химии, работающего с десятиклассниками в госпитальной школе, не редко встречается ситуация, когда вновь поступивший ученик очень слабо ориентируется в учебном материале и не может даже с помощью «карты предмета» назвать последнюю знакомую тему. Если

десятиклассник затрудняется выполнить такое задание, целесообразно организовать его работу с таблицей локальной диагностики, в которой представлен учебный материал нескольких тем (рис. 1).

Предельные и непредельные углеводороды			
1) $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$	2) $\text{H}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$	3) $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$	4) $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_3$
5) $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$	6) $\begin{array}{c} \text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}-\text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	7) $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$	8) $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{HC}\equiv\text{C}-\text{C}-\text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$
9) $\text{CH}_2=\text{CH}_2$ 	10) $\begin{array}{c} \text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}-\text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	11) $\begin{array}{c} \text{HC}\equiv\text{C}-\text{CH}-\text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	12) $\begin{array}{c} \text{H}_3\text{C}-\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$
Подсказка 1 (номенклатура): 		Подсказка 2 (изомеры и гомологи): 	

Рис.1 Задания для актуализации знаний и умений десятиклассников по темам «Предельные углеводороды» и «Непредельные углеводороды»

Используя один комплект структурных формул в таблице, предлагаем школьнику выполнить несколько различных заданий: указать, к какому классу относится каждое вещество, дать названия веществам, определить изомеры, гомологи, устно охарактеризовать химические свойства любого из веществ, формулы которых приведены. Чтобы поддержать ученика и уменьшить его опасения проявить неуспешность, непосредственно в таблицу локальной диагностики включены ссылки на опорный материал («подсказки») – схемы, таблицы, инфографику – которые могут помочь ученику вспомнить основные понятия и алгоритмы выполнения ключевых заданий. В процессе работы десятиклассник, как правило, сам отмечает, какие из предложенных заданий являются для него новыми, вещества каких классов ему совсем неизвестны, что позволяет педагогу приблизительно определить, где ученик остановился в процессе изучения органической химии. Таким образом на данном этапе урока можно сочетать одновременно бережную локальную диагностику с актуализацией исходных знаний и умений ученика.

Следующий этап урока – изучение выбранной темы. В целях предупреждения утомления ученика необходима минимизация его письменной работы, для этого рационально применять бланки конспектов с неполной

информацией [3], а также опорные материалы, средства наглядности и разноуровневые задания для устного закрепления.

Особое значение в обучении органической химии имеет применение шаростержневых моделей, работа с которыми неизменно вызывает интерес у школьников. «Модели молекул в органической химии являются посредниками между природными явлениями и химической символикой» [4, с. 194]. Их использование на данном уроке помогает десятикласснику составлять структурные формулы органических соединений, прогнозировать свойства веществ и продукты возможных реакций, а педагог может быстро и наглядно напомнить ученику забытую им учебную информацию.

В условиях госпитальной школы большое значение для ученика имеет возможность многосенсорного восприятия учебной информации как в процессе восприятия, так при закреплении внутренних образов. Работа с такими моделями на первом занятии позволяет десятикласснику проявить свое творчество, способность к визуализации, пространственное мышление, что помогает снижению его эмоционального напряжения. Смена видов деятельности способствует предупреждению утомления длительно болеющего школьника.

Таким образом, предложенный подход к проведению первого урока химии в госпитальной школе позволяет с позиции здоровьесбережения решать следующие задачи:

- мотивировать десятиклассника к осмыслению того, что он знает и умеет по предмету (начало формирование его индивидуального образовательного маршрута изучения химии в госпитальной школе),
- провести бережную локальную диагностику знаний и умений ученика и, при необходимости, начать восполнение выявленных учебных дефицитов.

Литература

1. Шариков, С.В. Педагогическая поддержка образовательных возможностей детей, находящихся на длительном лечении в медицинских стационарах / С.В. Шариков // Альманах Института коррекционной педагогики. – 2020. – № 40. – С. 22-42.
2. Дзенис, А.В. Госпитальная школа: первый урок химии / А.В. Дзенис // Химия в школе. – 2025. – № 4. – С. 34-38.
3. Дзенис, А.В. Конспекты с неполной информацией в практике обучения химии длительно болеющих детей в условиях медицинского стационара / А.В. Дзенис // Сборник научных статей «Актуальные проблемы химического образования в средней и высшей школе». – Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова. – 2018. – С. 51-52.
4. Ахметов, М.А. Индивидуально ориентированное обучение химии в общеобразовательной школе: монография / М.А. Ахметов. – Ульяновск: УИПКПРО. – 2009. – 260 с.

References

1. Sharikov, S.V. Pedagogicheskaya podderzhka obrazovatel'ny'x vozmozhnostej detej, naxodyashhixsya na dlitel'nom lechenii v medicinskix stacionarax / S.V. Sharikov // Al'manax Instituta korrekcionnoj pedagogiki. – 2020. – № 40. – S. 22-42.
2. Dzenis, A.V. Gospital'naya shkola: pervy'j urok ximii / A.V. Dzenis // Ximiya v shkole. – 2025. – № 4. – S. 34-38.
3. Dzenis, A.V. Konspekty` s nepolnoj informaciej v praktike obucheniya ximii dlitel'no boleyushhix detej v usloviyax medicinskogo stacionara / A.V. Dzenis // Sbornik nauchny'x statej «Aktual'ny'e problemy` ximicheskogo obrazovaniya v srednej i vy'sshej shkole». – Vitebsk: VGU imeni P.M. Masherova. – 2018. – S. 51-52.
4. Axmetov, M.A. Individual'no orientirovannoe obuchenie ximii v obshheobrazovatel'noj shkole: monografiya / M.A. Axmetov. – Ul'yanovsk: UIPKPRO. – 2009. – 260 s.

УДК 372.4

ОЦЕНИВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕМОВ В ГОСПИТАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Кубрак Алёна Романовна

специализированное структурное подразделение
ГБОУ Школа № 109 «Госпитальная школа «УчимЗнаем»

тьютор

kubrak.ar@uchimznaem.ru

ASSESSMENT USING MEMES IN HOSPITAL SCHOOL

Kubrak Alena Romanovna

specialized structural unit GBOU School № 109
“Hospital school “We Teach/They Learn”

tutor

kubrak.ar@uchimznaem.ru

Аннотация. Рассматриваются особенности оценивания образовательных достижений обучающихся начальных классов госпитальных школ. Приводятся примеры использования мемов для работы с притязанием ребенка на оценку.

Ключевые слова: госпитальная школа, длительно болеющий ребенок, оценивание, мотивация, обратная связь.

Abstract. The article examines the specifics of assessing the educational achievements of primary school students in hospital schools. It also provides examples of using memes to address a child's level of aspiration regarding grades.

Keywords: hospital school, child with long-term illnesses, assessment, motivation, feedback.

Длительное лечение и связанная с ним изоляция от привычного мира влияет на психоэмоциональное состояние ребенка [1]. Младшие школьники, которые только попали в больницу и пришли в госпитальную школу могут относиться к педагогу как с интересом, так и с недоверием в силу своего прошлого опыта. Более того, дети сталкиваются с депривацией. Сенсорная, социальная, эмоциональная и двигательная депривация длительно болеющего ребенка вынуждает педагогов ставить перед собой особые цели при обучении [2].

Одной из сложных методических задач, стоящих перед педагогом госпитальной школы, является обеспечения процесса оценивания образовательных достижений обучающихся. Так, при выставлении отметки возникает неосознанный конфликт. Если отметка не совпадает с ожиданиями обучающегося, то все сказанное педагогом - и похвала, и ориентировочные указания, будут поглощены его разочарованием учителем или собой, как не справившегося с заданием. Отметим, что невозможно ставить только отметки,

которые будут соответствовать уровню притязания ребенка. Нужно работать над самооценкой ребенка, формировать его уровень притязаний [3].

Особенно актуальна эта проблема в госпитальной школе, когда учащийся сталкивается с ухудшением когнитивных функций во время длительного лечения, тогда как его уровень притязаний на оценку часто остается прежним. В таких случаях ребенку необходима поддержка педагога и фокус на его успехах.

Одним из вариантов решения данной проблемы в начальных классах стало использование мемов при выставлении отметок. Во-первых, это позволило снизить негативную реакцию на отметки и вселить надежду на успех. Во-вторых, закрепить позитивное отношение к работе ребенка картинкой, ярким образом и сопроводить это устным оцениванием, которое запомнится.

В основной и средней школе мемы успешно применяются не только при выставлении отметки, но и при объяснении нового материала, для разбора ошибок обучающихся в самостоятельных и контрольных работах, для проверки знаний в составе задания и даже в проектных работах.

Таким образом, мем не равно оценивание. Мем это дорожка к объективизации самооценки, к пониманию своего уровня знаний для обучающихся, а также помощь педагогу при выставлении отметки.

Литература

1. Шариков, С.В. Педагогическая поддержка образовательных возможностей детей, находящихся на длительном лечении в медицинских стационарах / С.В. Шариков // Альманах Института коррекционной педагогики. – 2020. – № 40. – С. 22-42.
2. Амонашвили, Ш.А. Сущность оценки и отметки / Ш.А. Амонашвили // Мир науки, культуры, образования. – 2007. – № 2. – С. 77-79.
3. Куртанова, Ю.Е. (2020). Психологическое сопровождение детей, находящихся на длительном лечении в условиях изоляции / Ю.Е. Куртанова, А.М. Щербакова, А.Ю. Хохлова, О.В. Белозерская, А.П. Щербаков, Е.А. ВасильеваК.Л. Мамина // Психолого-педагогические исследования. – 2020. – № 12(3). – С. 45–60.

References

1. Sharikov, S.V. Pedagogicheskaya podderzhka obrazovatel'ny`x vozmozhnostej detej, naxodyashhixsya na dlitel'nom lechenii v medicinskix stacionarax / S.V. Sharikov // Al'manax Instituta korrekcionnoj pedagogiki. – 2020. – № 40. – S. 22-42.
2. Amonashvili, Sh.A. Sushhnost` ocenki i otmetki / Sh.A. Amonashvili // Mir nauki, kul'tury`, obrazovaniya. – 2007. – № 2. – S. 77-79.
3. Kurtanova, Yu.E. (2020). Psixologicheskoe soprovozhdenie detej, naxodyashhixsya na dlitel'nom lechenii v usloviyax izolyacii / Yu.E. Kurtanova, A.M. Shherbakova, A.Yu. Hoxlova, O.V. Belozerskaya, A.P. Shherbakov, E.A. Vasil'evaK.L. Mamina // Psixologo-pedagogicheskie issledovaniya. – 2020. – № 12(3). – S. 45–60.

УДК 376.1

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

Старцева Светлана Александровна
ГБОУ СО «Екатеринбургская школа-интернат № 12»
учитель-логопед
starceva_sveta@inbox.ru

FEATURES OF HOME-BASED EDUCATION FOR STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

Starceva Svetlana Aleksandrovna
GBOU SO "Yekaterinburg Boarding School No. 12"
speech therapist
starceva_sveta@inbox.ru

Аннотация. В статье рассматривается опыт работы образовательной организации, реализующей адаптированную основную образовательную программу (АООП), а также опыт автора в вопросах обучения на дому обучающихся с интеллектуальными нарушениями, в том числе реализуемые формы, методы и приемы работы с обучающимися и их родителями (законными представителями).

Ключевые слова: обучение на дому, специальная индивидуальная программа развития, АООП, интеллектуальные нарушения, альтернативная коммуникация, психолого-педагогическая диагностика, мониторинг, индивидуальный учебный план.

Abstract. This article examines the experience of an educational organization implementing an Adapted Core Educational Program (ACEP), as well as the author's personal experience in home-based instruction for students with intellectual disabilities. The discussion includes the forms, methods, and techniques employed in working with both the students and their parents (or legal representatives).

Keywords: home-based education, special individual educational program, adapted core educational program, intellectual disabilities, alternative communication, psychological and pedagogical diagnostics, monitoring, and individual educational plan.

В настоящее время проблема организации обучения на дому является актуальной для нашей школы. Число обратившихся школьников увеличивается каждый год, а также в течение учебного года некоторые обучающиеся переходят на обучение на дому по ряду причин. В Екатеринбургской школе-интернат №12 получают образование дети, имеющие интеллектуальные нарушения, в том числе дети-инвалиды, имеющие тяжелые множественные нарушения развития,

расстройство аутистического спектра РАС, генетические заболевания. Некоторые обучающиеся по состоянию здоровья не могут посещать образовательную организацию, поэтому для них предусмотрено обучение на дому. Статистика школы показывает ежегодное увеличение количества обучающихся, нуждающихся в обучении на дому. Так, в 2022-2023 учебном году в начале учебного года на домашнее обучение было зачислено (некоторые переведены) 75 обучающихся, к концу учебного года их было 82. В 2023-2024 учебном году в начале учебного года было 82 ученика, к концу 85. В 2024-2025 учебном году в начале учебного года было 85 учеников, к концу учебного года 95. Обучение на дому осуществляется для обучающихся всех возрастных категорий и классов (1-9 классы). Основанием обучения на дому являются медицинские показания, определенные перечнем заболеваний Приказа Министерства здравоохранения РФ от 30.06.2016 № 436н, заявление родителей (законных представителей) [1]. Обучение осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (№273-ФЗ), приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 №1599, Приказом Минпросвещения России от 24.11.2022 № 1026, Письмом Минпросвещения России «О направлении методических рекомендаций» от 24.11.2021 №ДГ-2121/07, Постановлением Правительства Свердловской области от 11.06.2025 №318 ПП, положением об обучении на дому и приказом школы [2, 3, 4, 5, 6].

Обучение на дому детей с интеллектуальными нарушениями осуществляется в соответствии с индивидуальной программой обучения, рекомендованной психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК): адаптированной основной общеобразовательной программой (АООП, вариант 1) или специальной индивидуальной программой развития (СИПР, вариант 2), основной целью которых является создание условий для максимального развития всех сторон ребёнка с учётом его возможностей. Эти программы включают в себя предметы образовательных областей и коррекционно-развивающие занятия, направленные на развитие жизненных компетенций.

Учебный план составляется индивидуально для каждого обучающегося на один учебный год с обязательным включением общеобразовательных предметов и коррекционных занятий в соответствии с федеральной адаптированной основной общеобразовательной программой (ФАООП): альтернативная коммуникация, предметно-практическая деятельность, двигательное развитие, сенсорное развитие, игрокоррекция, логопедическая коррекция, социально-бытовая ориентировка (окружающий социальный мир). Проводится ежегодная психолого-педагогическая диагностика и мониторинг усвоения программы, корректируется учебный план. По итогам обследования отбираются приоритетные образовательные области, учебные предметы, коррекционные занятия для обучения в условиях обучения на дому. Составленная индивидуальная программа развития обязательно согласуется с родителями (законными представителями), которые могут внести свои корректировки в выборе предметов обучения, количестве часов, коррекционных курсов. Для обучающихся 1 и 2 этапов обучения предусмотрено разное количество учебных часов в неделю, варьируются обязательные и коррекционные предметы.

Например, при необходимости, двигательную коррекцию возможно заменить на сенсорную или логопедическую коррекцию. Для обучающихся по АООП вариант 2 предусмотрено больше коррекционных часов, особенно в начальных классах. Некоторые уроки по темам окружающего мира, например, времена года, птицы, магазин, целесообразно проводить с выходом из дома на объект. Так мы решаем несколько учебных целей: ознакомление с темой урока, расширение социальных контактов, развитие практических навыков. Изготовленные самостоятельно учеником буквы, цифры (из пластилина, картона, подручных материалов) способствуют их лучшему усвоению. Также, как и в стенах школы, дома можно устроить выставку рисунков и поделок, это мотивирует обучающихся на усвоение новых практических навыков, развивает самостоятельность, формирует понятия «красиво», «нравится», поднимает самооценку. Навыки работы с разными материалами помогут в дальнейшей социализации в обществе. Обучающийся в свободное время может раскрашивать, рисовать, лепить, создавать аппликации, минивитражи и дарить их близким людям, показывая свою значимость и признательность. Обучающиеся по АООП вариант 1 успешны по общеобразовательным предметам: русскому языку, чтению, окружающему миру, географии, биологии, истории, труду, математике. Ученики могут освоить не только навыки практической деятельности с предметами и материалами, но и стать хорошими помощниками в семье, играть с младшими членами семьи, читать книги, энциклопедии, смотреть научные учебные фильмы, ходить в магазин, самостоятельно готовить, делать простые выводы.

Одним из важных факторов организации обучения на дому является работа с семьей. Часто родители ошибочно на первое место ставят традиционные общеобразовательные уроки, занижая реабилитационный потенциал коррекционных курсов: русский язык и чтение вместо альтернативной коммуникации, математику вместо сенсорного развития и математических представлений, так как считают, что ребенок научится говорить, если овладеет чтением, считает в уме, но не хочет посторонним демонстрировать свои знания, уроки домоводства не воспринимают как учебную деятельность, не обучают навыкам самообслуживания, поэтому ребенок в жизни не самостоятелен и нуждается в постоянной помощи и уходе. Школа занимается психолого-педагогическим просвещением родителей. Работает «Родительский клуб» в очном и дистанционном формате, куда приглашают специалистов школы: психологов, в том числе семейных психологов, дефектологов, логопедов, а также врачей психиатра и невролога. Родители могут получить ответы на вопросы по воспитанию и обучению умственно отсталого ребенка. Не все родители обладают знаниями о способностях и возможностях своих детей, часто они остаются один на один с проблемами, избегают контактов с друзьями, замыкаются в семье и поэтому нуждаются в психологической и педагогической поддержке. Школа организует массовые общественно-значимые мероприятия и совместный досуг родителей и обучающихся, открытые уроки. Поэтому тесное взаимодействие семьи и учителей школы помогает преодолеть психологические проблемы, что дает положительный успех в данном виде обучения.

Педагоги школы проводят индивидуальные, групповые консультации на темы сенсорного развития, развития мелкой и крупной моторики, раскрывают возможности альтернативной коммуникации. Например, на ежедневной прогулке можно развивать тактильные ощущения при срывании листьев растений, пересыпании песка, перебирании камушков, удерживании веток и природных материалов. Также можно развивать слуховое восприятие, узнавая и сравнивая звуки природы из реальных источников: шум моря и аудиозапись, пение настоящих птиц и в записи, шум города и шум леса. При помощи карточек предметов и символов вместе с ребенком можно составить расписание уроков и желаемого досуга, планировать выходные дни всей семьей. Учитывая возможности и способности ребёнка, можно привлекать его к выполнению посильных домашних дел, мыть посуду, накрывать на стол, готовить еду (например, бутерброд, салат, чай), сворачивать вещи, сортировать овощи и фрукты, поднимать с пола и ставить игрушки на полку и многое другое. Необходимо прививать ребенку навыки социального поведения. Часто ребёнок, обучающийся на дому, лишен социальных контактов по ряду причин: тяжелое заболевание, проблемное поведение, невозможность самостоятельно передвигаться. Родители и учитель могут оказаться единственными собеседниками и друзьями такого ребёнка. Многие родители осуществляют уход за ребенком, тщательно оберегают его, но совершенно не умеют с ним играть. Конечно, в семьях с детьми есть игрушки, но их дидактическое значение не учитывается. Ребёнок не собирает пирамидки или действует наугад, пазлы не имеют полного комплекта, машины, куклы, кубики, лего, книги разбросаны по всему дому, так как ребенок не научен простейшим манипуляциям: собрать, сложить, катить, кормить, перебирать, перелистывать. С учебными принадлежностями (ручками, карандашами, красками, альбомами, тетрадями) ребенок не знаком. Задача педагога научить родителей различным способам взаимодействия с детьми: играть, рисовать, писать, праздновать, петь, танцевать. Ребенок должен знать и понимать семейные традиции, принимать участие в праздниках: новый год, день рождения, дарить и принимать подарки, бывать на развлекательных мероприятиях, спектаклях, зоопарке, а также узнавать родственников и членов семьи, использовать ритуалы приветствия и прощания. Обучающиеся на дому могут посещать мероприятия в школе, участвовать в них вместе с одноклассниками, например, День знаний 1 сентября, День Победы, новый год, конкурс чтецов, весёлые старты, экскурсии, если нет медицинских противопоказаний.

Учителю при обучении на дому необходимо выбирать разные формы работы. На уроках можно применять информационно-коммуникационные технологии, используя адаптированные интерактивные презентации при изучении букв, цифр, фигур, животных. Различные коммуникационные устройства способствуют развитию речи, помогают освоить звуки, звукоподражания, слова и фразы. Видеоконтент расширяет знания и представления об окружающем социальном мире, мотивирует на взаимодействие с окружающими. Наряду с рассматриванием и чтением книг хорошо

использовать аудиозаписи профессиональных актёров, практиковать чтение по ролям, надевать маски, показывать пальчиковый театр.

Используя разнообразные приемы работы, можно сделать обучение на дому интересным, полезным, доступным, что положительно скажется на дальнейшей социализации ребенка с интеллектуальными нарушениями и осмыслении социального окружения, своего места в обществе [7].

Литература

1. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным общеобразовательным программам на дому» от 30.06.2016 № 436н. – URL: <https://base.garant.ru/71449638/> (Дата обращения 29.08.2025).
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (Дата обращения 29.08.2025).
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» от 19.12.2014 № 1599. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/> (Дата обращения 29.08.2025).
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1026 «Об утверждении федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (Зарегистрирован 30.12.2022 № 71930). – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212300059> (Дата обращения 09.11.2025).
5. Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации «О направлении методических рекомендаций» от 24.11.2021 г. № ДГ-2121/07. – URL: https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-24.11.2021-N-DG-2121_07/ (Дата обращения 29.08.2025).
6. Постановление Правительства Свердловской области от 11.06.2025 № 318-ПП «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной образовательной организации Свердловской области и муниципальной образовательной организации с обучающимися, нуждающимися в длительном лечении, детьми-инвалидами и (или) их родителями (законными представителями) в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях». – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/6600202506170012> (Дата обращения 09.11.2025).
7. Шариков, С.В. Педагогическая поддержка образовательных возможностей детей, находящихся на длительном лечении в медицинских стационарах / С.В. Шариков // Альманах Института коррекционной педагогики. – 2020. – № 40. – С. 22-42.

References

1. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основному общеобразовательному программному на дому» от 30.06.2016 №436н. – URL: <https://base.garant.ru/71449638/> (Accessed 29.08.2025).
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-FZ. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (Accessed 29.08.2025).
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» от 19.12.2014 №1599. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/> (Accessed 29.08.2025).
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1026 Об утверждении федерального адаптированного основного общеобразовательного программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Зарегистрирован 30.12.2022 № 71930). – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212300059> (Accessed 09.11.2025).
5. Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации «О направлении методических рекомендаций» от 24.11.2021 г. №DG-2121/07. – URL: https://rulings.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-24.11.2021-N-DG-2121_07/ (Accessed 29.08.2025).
6. Постановление Правительством Свердловской области от 11.06.2025 № 318-PP Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной образовательной организации Свердловской области и муниципальной образовательной организации с обучающимися, нуждающимися в длительном лечении, детьми-инвалидами и (или) их родителями (законными представителями) в части организации обучения по основному общеобразовательному программному на дому или в медицинских организациях. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/6600202506170012> (Accessed 09.11.2025).
7. Шариков, С.В. Педагогическая поддержка образовательных возможностей детей, находящихся на длительном лечении в медицинских стационарах / С.В. Шариков // Алмаз Института коррекционной педагогики. – 2020. – № 40. – С. 22-42.

УДК 372.881.111.1

**ИГРОВЫЕ ПРИЕМЫ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В ГОСПИТАЛЬНОЙ ШКОЛЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ФОНА**

Кузминич Наталья Анатольевна
специализированное структурное подразделение
ГБОУ Школа № 109 «Госпитальная школа «УчимЗнаем»
тьютор
kuzminich.na@uchimznaem.ru

Солдатенкова Анна Николаевна
специализированное структурное подразделение
ГБОУ Школа № 109 «Госпитальная школа «УчимЗнаем»
тьютор
soldatenkova.an@uchimznaem.ru

**GAME-BASED TECHNIQUES IN ENGLISH LESSONS IN HOSPITAL
SCHOOLS AS A MEANS OF FORMING POSITIVE
EMOTIONAL ENVIRONMENT**

Kuzminich Natalia Anatolievna
specialized structural unit GBOU School № 109
“Hospital school “We Teach/They Learn”
tutor
kuzminich.na@uchimznaem.ru

Soldatenkova Anna Nikolaevna
specialized structural unit GBOU School № 109
“Hospital school “We Teach/They Learn”
tutor
soldatenkova.an@uchimznaem.ru

Аннотация. В материале представлены варианты игровых приемов, используемых на уроках английского языка в госпитальной школе для создания положительного эмоционального фона, повышения мотивации, снижения тревожности и освоения предметного содержания. Также рассмотрены практические инструменты для адаптации игровых техник к условиям госпитальной школы.

Ключевые слова: госпитальная педагогика, игровые приемы, эмоциональный фон, английский язык.

Abstract. The article presents a range of game-based techniques used in English lessons at a hospital school, aimed at creating a positive emotional environment, enhancing motivation, reducing anxiety, and facilitating better comprehension of the material. The report also focuses on practical tools for adapting these techniques to suit students' needs in hospital schools.

Keywords: hospital pedagogy, game-based techniques, emotional environment, English language.

Изучение английского языка в условиях госпитальной школы требует особого подхода, учитывающего не только образовательные, но и психологические потребности учащихся [1]. Учитывая социальные дефициты, высокий уровень тревожности и необходимость поддержания мотивации у детей, находящихся на длительном лечении, использование игровых приемов становится ключевым инструментом для создания положительной эмоциональной атмосферы на уроке [2]. В материале рассмотрены некоторые игровые методики, позволяющие сделать процесс обучения интересным, увлекательным и способствующим лучшему освоению предметного материала. Важным аспектом является создание атмосферы, способствующей самовыражению и коммуникации. В докладе будут приведены конкретные примеры, направленные на улучшение не только языковой компетенции, но и общего эмоционального фона учащихся.

Рассмотрим следующие приемы, которые можно использовать на разных этапах урока:

1. Настольные игры: такие как BrainBox, для развития памяти, внимания и лексики, интерактивные игры, созданные с помощью платформы Genial.ly. Существует возможность адаптации этих игр для различных возрастных групп и уровней владения иностранным языком.

2. Работа с аутентичным материалом – сериалом "Уэнсдей": отмети наличие отрывков из современных сериалов для изучения грамматики (в частности, косвенной речи), развития навыка аудирования и говорения в интересном для подростков контексте.

3. Работа с музыкальным материалом: возможность работы с музыкальным материалом, направленной на развитие лексического запаса, улучшение произношения и стимулирование творческого самовыражения.

4. Рефлексия и использование мемов: отметим преимущества данного инструмента для обучения живому английскому языку – визуализация материала, стимулирование разговорной речи, использование для самовыражения и эмоциональной разгрузки [3].

Таким образом, описанные приемы позволяют решать комплекс задач:

1. Снизить уровень тревожности ученика во время урока.

Ученики часто боятся ошибиться. Слушая песню или просматривая отрывок из фильма, они как будто забывают, что они на уроке – охотнее говорят и меньше думают об ошибках. В целом, снижается фактор нервозности (affective filter), и они быстрее начинают говорить.

2. Повысить уровень мотивации.

Когда обучающиеся видят, что у них получается, мотивация растет, и сами начинают что-то слушать, смотреть вне урока, сами предлагают песни, находят в интернете текст и зачастую спрашивают, как можно перевести ту или иную строчку из их любимого хита. Отметим необходимость формирования самостоятельной деятельности обучающихся.

3. Расширить кругозор обучающихся в госпитальной школе.

Многие песни, фильмы и сериалы отражают события и явления, о которых интересно поговорить на уроке. Они пробуждают любопытство и служат стимулом идти дальше – смотреть и изучать.

4. Дополнить учебно-методический комплект (УМК).

Аутентичные материалы подходят как дополнительные закрепляющие и вовлекающие материалы, Песни, фильмы и сериалы на уроках иностранного языка обычно используются в качестве усиления какого-то материала и демонстрации связи правил и слов с реальным миром.

Таким образом игровые приемы при использовании на уроках английского языка в госпитальной школе создают положительный эмоциональный фон, повышают мотивацию, снижают тревожность и обеспечивают освоение предметного содержания.

Литература

1. Солдатенкова, А.Н. Использование аутентичных материалов в обучении английскому языку детей, находящихся на длительном лечении в стационаре / А.Н. Солдатенкова // Материалы 6-й Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – 2024. – С. 45-48
2. Шариков, С.В. Инновации в обучении детей-инвалидов с прогрессирующими заболеваниями и неопределенным прогнозом жизни / С.В. Шариков // Альманах. – 2021. – № 44. – URL: <https://alldef.ru/ru/articles/almanac-44/innovations-in-teaching-disabled-children-with-progressive-diseases-and-uncertain-life-prognosis> (Дата обращения 07.12.2025)
3. Попова, А.В. От YESли бы к YESтественно. Как выучить английские времена с помощью мемов / А.В. Попова. – Ridero. – 2022. – С. 40-55.

References

1. Soldatenkova, A.N. Ispol'zovanie autentichny`x materialov v obuchenii anglijskomu yazy`ku detej, naxodyashhixsya na dlitel`nom lechenii v stacionare / A.N. Soldatenkova // Materialy` 6-j Vserossijskoj nauchno-prakticheskoy konferencii s mezhdunarodny`m uchastiem. – 2024. – S. 45-48
2. Sharikov, S.V. Innovacii v obuchenii detej-invalidov s progressiruyushhimi zabolevaniyami i neopredelenny`m prognozom zhizni / S.V. Sharikov // Al`manax. – 2021. – № 44. – URL: <https://alldef.ru/ru/articles/almanac-44/innovations-in-teaching-disabled-children-with-progressive-diseases-and-uncertain-life-prognosis> (Accessed 07.12.2025).
4. Popova, A.V. Ot YESli by` k YEStestvenno. Kak vy`uchit` anglijskie vremena s pomoshh`yu memov / A.V. Popova. – Ridero. – 2022. – S. 40-55.

УДК 372.881.161.1

**ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ:
РЕАЛИЗАЦИЯ АКСИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА**

Левченкова Алина Сергеевна
специализированное структурное подразделение
ГБОУ Школа № 109 «Госпитальная школа «УчимЗнаем»
тьютор
levchenkova.as@uchimznaem.ru

**FEATURES OF THE RUSSIAN LANGUAGE TEACHING
METHODOLOGY FOR CHILDREN UNDERGOING LONG-TERM
TREATMENT: IMPLEMENTATION OF THE AXIOLOGICAL APPROACH**

Levchenkova Alina Sergeevna
specialized structural unit GBOU School № 109
“Hospital school “We Teach/They Learn”
tutor
levchenkova.as@uchimznaem.ru

Аннотация. рассматривается роль аксиологического подхода на уроках русского языка для детей, проходящих тяжелое и длительное лечение, в аспекте реализации многокомпонентного лингво-культурологического упражнения, направленного на личностное развитие обучающихся.

Ключевые слова: госпитальная школа, дети, находящиеся на длительном лечении, уроки русского языка, аксиологический подход, русская культура, личностное развитие, речевое воспитание, патриотическое воспитание, социализация.

Abstract. This article examines the role of the axiological approach in Russian language lessons for children undergoing severe and long-term treatment in the aspect of implementing a multicomponent linguistic and cultural exercise aimed at students' personal development.

Keywords: hospital school, children undergoing long-term medical treatment, Russian language lessons, axiological approach, Russian culture, personal development, speech education, patriotic education, socialization.

Деятельность госпитальной педагогики направлена на полноценное развитие обучающихся, проходящих тяжелое и длительное лечение, которое, в свою очередь, призвано положительно влиять на их соматическое и психологическое состояние, формировать их дальнейшие жизненные перспективы [1, 2].

Уроки русского языка обладают мощным аксиологическим потенциалом, способствуют формированию гармонично развитой личности учащихся, их языковых, речеведческих, культурологических компетенций [3]. В рамках госпитальной педагогики актуальным становится реализация ценностно-ориентированного подхода, направленного на постижение ключевых в русской языковой картине мира понятий (*добро, любовь, милосердие, героизм, мужество*). Уроки, включающие текстовый материал, предполагающий анализ данных лексем, позволяют детям, длительно находящимся в условиях стационара, полноценно развиваться, социализироваться, определять новые цели, бороться с тяжелой болезнью.

Предлагается рассмотреть многокомпонентное упражнение, включающее четыре уровня заданий:

- 1) лингво-семантическое: предполагает анализ отрывка художественного произведения или документа как источника реализации проблемного обучения и словарной работы с рассматриваемым понятием;
- 2) коммуникативно-прагматическое: включает работу с художественной картиной и текстом, способствующим формированию знаний об анализируемом понятии;
- 3) лингвокультурологическое: способствует восприятию рассматриваемой лексической единицы как культуре;
- 4) продуктивно-творческое: определяет переход рассматриваемого понятия из пассивного словарного запаса в активный; на данном этапе происходит осмысление лексемы посредством личностного восприятия.

Данная система заданий, которая может быть адаптирована с учетом индивидуальных особенностей и образовательных потребностей ребенка, позволяет учащимся, находящимся на длительном лечении, познавать историю своего народа, говорить о сложных исторических периодах с точки зрения проявления рассматриваемых понятий. Наряду с патриотическим воспитанием и аксиологическим развитием происходит личностное становление обучающихся, находящихся на длительном лечении, что, в свою очередь, придает силы в процессе лечения, возвышает духовно.

Литература

1. Разъяснения по вопросам организации обучения по основным общеобразовательным и дополнительным общеразвивающим программам для детей, нуждающихся в длительном лечении в медицинских организациях / письмо Минпросвещения России № ТВ-1693/03, Минздрава России № 1/и/2-15398 от 24.08.2023. – URL: <https://caringschool.ru/dokumenty-gospitalnoj-pedagogiki/> (дата обращения 07.09.2025)
2. Шариков, С.В. Инновации в обучении детей-инвалидов с прогрессирующими заболеваниями и неопределенным прогнозом жизни / С.В. Шариков / Альманах Института коррекционной педагогики. – Альманах № 44. – 2021. – URL: <https://alldef.ru/ru/articles/almanac-44/innovations-in-teaching-disabled-children-with-progressive-diseases-and-uncertain-life-prognosis> (Дата обращения 10.07.2025).

3. Дейкина, А.Д. Аксиологическое значение методики преподавания великого и могучего русского языка // Аксиологическая лингвометодика: мировоззренческие ценностные аспекты в школьном и вузовском преподавании русского языка (к юбилею профессора А.Д. Дейкиной и ее научной школы): материалы международной научно-практической конференции, г. Москва, 22–23 марта 2019 г. В двух частях. Часть 1 / науч. ред.: А.Д. Дейкина; сост.: А.Д. Дейкина, В.Д. Янченко, О.Н. Левушкина, О.Е. Дроздова. – М.: МПГУ. – 2019. – С. 11-19.

References

1. Raz`yasneniya po voprosam organizacii obucheniya po osnovny`m obshheobrazovatel`ny`m i dopolnitel`ny`m obshherazvivayushhim programmam dlya detej, nuzhdayushhixsya v dlitel`nom lechenii v medicinskix organizaciyax / pis`mo Minprosveshheniya Rossii №TV-1693/03, Minzdrava Rossii № 1/i/2-15398 ot 24.08.2023. – URL: <https://caringschool.ru/dokumenty-gospitalnoj-pedagogiki/> (Accessed 07.09.2025)

2. Sharikov, S.V. Innovacii v obuchenii detej-invalidov s progressiruyushhimi zabolevaniyami i neopredelenny`m prognozom zhizni / S.V. Sharikov / Al`manax Instituta korrekcionnoj pedagogiki. – Al`manax № 44. – 2021. – URL: <https://alldef.ru/ru/articles/almanac-44/innovations-in-teaching-disabled-children-with-progressive-diseases-and-uncertain-life-prognosis> (Accessed 10.07.2025).

3. Dejkina, A.D. Aksiologicheskoe znachenie metodiki prepodavaniya velikogo i moguchego russkogo yazy`ka // Aksiologicheskaya lingvometodika: mirovozzrencheskie cennostny`e aspekty` v shkol`nom i vuzovskom prepodavanii russkogo yazy`ka (k yubileyu professora A.D. Dejkinoy i ee nauchnoj shkoly`): materialy` mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii, g. Moskva, 22–23 marta 2019 g. V dvux chastyax. Chast` 1 / nauch. red.: A.D. Dejkina; sost.: A.D. Dejkina, V.D. Yanchenko, O.N. Levushkina, O.E. Drozdova. – М.: MPGU. – 2019. – S. 11-19.

УДК 372.881.111.1

ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСТВО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ, ПОПАВШИХ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ

Морозова Евгения Витальевна

специализированное структурное подразделение
ГБОУ Школа № 109 «Госпитальная школа «УчимЗнаем»
тьютор
morozova.ev@uchimznaem.ru

Саломехина Наталья Владимировна

специализированное структурное подразделение
ГБОУ Школа № 109 «Госпитальная школа «УчимЗнаем»
тьютор
salomahina.nv@uchimznaem.ru

TEACHING A FOREIGN LANGUAGE TO CHILDREN IN DIFFICULT LIFE SITUATIONS THROUGH CREATIVE APPROACH

Morozova Evgeniya Vitalievna

specialized structural unit GBOU School № 109
“Hospital school “We Teach/They Learn”
tutor
morozova.ev@uchimznaem.ru

Salomakhina Natalia Vladimirovna

specialized structural unit GBOU School № 109
“Hospital school “We Teach/They Learn”
tutor
salomahina.nv@uchimznaem.ru

Аннотация. В работе рассматривается творческий подход в обучении иностранному языку учащихся, попавших в трудную жизненную ситуацию (минно-взрывные травмы, чрезвычайные ситуации, бытовые и спортивные травмы). Представлены приемы и методы развития креативного мышления для повышения мотивации у учащихся, и вовлечение их в образовательный процесс госпитальной школы.

Ключевые слова: креативное мышление, госпитальная школа, творчество, дети, попавшие в тяжелые жизненные ситуации, обучение иностранному языку.

Abstract. This report is dedicated to the problem of teaching a foreign language through creative approach to students experiencing difficult life situations (mine and blast injuries, emergency situations, domestic and sports accidents). It examines techniques, methods and strategies aimed at developing creative thinking to enhance students' motivation and facilitate their engagement in the educational process of a hospital school.

Keywords: creative thinking, hospital school, creativity, children in difficult life situations, teaching foreign languages.

При обучении школьников, находящихся на длительном лечении в стационаре лечебного учреждения, тьютор должен учитывать особенности протекания заболевания у ребенка и возможные последствия болезни как для когнитивной сферы, так и общего физического и эмоционального состояния болеющего ребенка [1].

В условиях работы в госпитальной школе нами накоплен опыт работы с учениками, попавшими в трудные жизненные ситуации. Это дети, получившие минно-взрывные травмы, попавшие в чрезвычайные ситуации из пограничных и новых регионов, а также получившие бытовые или спортивные травмы.

В тесном взаимодействии с врачами и специалистами службы психолого-педагогического и социального сопровождения Проекта госпитальных школ «УчимЗнаем» тьюторы обеспечивают необходимые условия для успешной социализации и интеграции детей в образовательную среду. Пострадавшим детям свойственно проявление функциональных нарушений физического здоровья и развитие группы стрессовых расстройств. В поведенческой сфере специалисты отмечают снижение мотивации к обучению и к деятельности, которая ранее вызывала интерес [2]. Обучение иностранному языку через творчество зарекомендовало себя как эффективный инструмент для создания комфортной атмосферы на уроке и повышения познавательной мотивации при работе с детьми в госпитальной школе.

Общеизвестно, что творчество является неотъемлемым компонентом любой сферы деятельности человека, и психологи советуют делать акцент при обучении на активизацию личностных ресурсов посредством организации творческих мероприятий, которые помогают развить когнитивные способности (мышление, память, внимание) и креативное мышление [2]. Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) подразумевают развитие креативного мышления как важный компонент функциональной грамотности обучающихся. Это способность находить новые, нестандартные решения проблем и создавать что-то оригинальное, что является неотъемлемой частью современного образования для формирования разносторонне развитой личности, способной к инновациям и быстрой адаптации.

Развитие креативного мышления осуществляется с помощью разных методов и приемов. Задания должны быть интересными, стимулировать познавательную деятельность, создавать возможность размышлять, сочинять и фантазировать, проявлять свою индивидуальность [3]. При этом ребенок самостоятельно выбирает вид деятельности.

В своей работе мы используем следующие приемы: игры, песни и стихи и создание иллюстраций к ним, головоломки, ребусы, визуальные загадки друиды (doodles), работа с текстом, рисование, аппликации, оригами, поделки, постановку сказок, создание историй по картинкам и комиксам.

Вышеперечисленные приемы способствуют развитию мелкой моторики, воображения, внимания, активизируют мыслительную деятельность и креативное мышление. Задания подбираются по уровню сложности и могут быть интегрированы на любом этапе урока.

В условиях госпитальной школы для детей, попавших в трудные жизненные ситуации, творческий подход в обучении иностранному языку помогает лучше усвоить материал, развить речевые навыки учащихся.

Литература

1. Шариков, С.В. Педагогическая поддержка образовательных возможностей детей, находящихся на длительном лечении в медицинских стационарах / С.В. Шариков // Альманах Института коррекционной педагогики. – 2020. – № 40. – С. 22-42.
2. Ульянина, О.А. Сопровождение и реабилитация детей, находящихся на территориях, вовлеченных в последствия боевых действий: методические рекомендации / [коллектив авторов; под общей редакцией О.А. Ульяниной] // Московский государственный психологопедагогический университет. – Москва: МГППУ. – 2023. – 211 с.
3. Моисеева, Л.В. Методы и технологии развития креативного мышления младших школьников / Л.В. Моисеева, Л.Д. Филиогло // Поволжский вестник науки. – 2022. – № 4 (26). – С. 78-81.

References

1. Sharikov, S.V. Pedagogicheskaya podderzhka obrazovatel'ny`x vozmozhnostej detej, naxodyashhixsya na dlitel'nom lechenii v medicinskix stacionarax / S.V. Sharikov // Al'manax Instituta korrekcionnoj pedagogiki. – 2020. – № 40. – S. 22-42.
2. Ul'yanina, O.A. Soprovozhdenie i reabilitaciya detej, naxodyashhixsya na territoriyax, vovlecheny`x v posledstviya boevy`x dejstvij: metodicheskie rekomendacii / [kollektiv avtorov; pod obshhej redakciej O.A. Ul'yaninoj] // Moskovskij gosudarstvenny`j psixologopedagogicheskij universitet. – Moskva: MGPPU. – 2023. – 211 s.
3. Moiseeva, L.V. Metody` i tehnologii razvitiya kreativnogo my`shleniya mladshix shkol`nikov / L.V. Moiseeva, L.D. Filioglo // Povolzhskij vestnik nauki. – 2022. – № 4 (26). – S. 78-81.

УДК 372.4

**ПРИМЕНЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСКУССИИ КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ
КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ГОСПИТАЛЬНОЙ ШКОЛЫ**

Засорина Ольга Петровна

специализированное структурное подразделение

ГБОУ Школа № 109

«Госпитальная школа «УчимЗнаем»

тьютор

zasorina.op@uchimznaem.ru

Щепина Наталия Владимировна

специализированное структурное подразделение

ГБОУ Школа № 109

«Госпитальная школа «УчимЗнаем»

тьютор

shchepina.nv@uchimznaem.ru

**THE USE OF EDUCATIONAL DISCUSSION AS A MEANS OF
DEVELOPING COMMUNICATIVE UNIVERSAL LEARNING ACTIVITIES
IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS ATTENDING HOSPITAL SCHOOL**

Zasorina Olga Petrovna

specialized structural unit GBOU School № 109

“Hospital school “We Teach/They Learn”

tutor

zasorina.op@uchimznaem.ru

Shchepina Natalia Vladimirovna

specialized structural unit GBOU School № 109

“Hospital school “We Teach/They Learn”

tutor

shchepina.nv@uchimznaem.ru

Аннотация. Представлен опыт формирования универсальных учебных действий путем проведения учебных дискуссий, которые наиболее целесообразно использовать на занятиях в начальных классах в госпитальной школе.

Ключевые слова: госпитальная школа, дискуссия, обсуждение, умение договариваться, коммуникативные универсальные учебные действия.

Abstract. The report is devoted to develop communicative universal learning activities by conducting educational discussions that are appropriate for primary school classes in a hospital school.

Keywords: hospital school, discussion, negotiation skills, communicative universal learning activities.

В условиях госпитальной школы учащиеся младших классов сталкиваются с ограничениями в социальном взаимодействии по медицинским показаниям. Вследствие этого у них ограничены условия для развития умения слушать собеседника, уважительно аргументировать свою точку зрения, договариваться друг другом.

Учебная дискуссия как эффективный метод обучения в госпитальной школе служит не только образовательным, терапевтическим, но и реабилитационным инструментом. Участие в дискуссии позволяет детям, находящимся на длительном лечении, сохранять и совершенствовать социальные и коммуникативные навыки, несмотря на изоляцию от обычной школьной среды. «Быть естественным в общении – одна из востребованных задач. Ее постоянно пытаются решить все, кто общается и работает в социуме» [1, с. 40].

При организации дискуссии учитываются физическое и эмоциональное состояние учащихся, их познавательные интересы, а также рекомендации врачей. «Особые задачи стоят перед руководителем дискуссии: не столько направлять, сколько стимулировать, побуждать учеников к обмену точками зрения» [2, с. 140]. Дискуссии могут проводиться в малых группах или индивидуально, на очных или онлайн-занятиях для включения детей, соблюдающих социальную дистанцию.

Учебная дискуссия способствует развитию ключевых коммуникативных универсальных учебных действий (УУД):

- умению формулировать и аргументировать свою точку зрения: учащиеся учатся строить логичные высказывания, использовать доказательства и учитывать контекст обсуждаемой темы;
- развитию диалогической речи: дискуссия поощряет ведение диалога, вопросы и уточнение позиций собеседников, что особенно важно для детей, испытывающих трудности в общении из-за болезни или лечения;
- сотрудничеству и учету позиции собеседника: учатся слушать, слышать и уважать мнения других, что формирует толерантность и эмпатию.

Для развития вышеперечисленных коммуникативных универсальных учебных действий педагогу важно в процессе дискуссии обеспечить атмосферу доверия, где каждый ребенок чувствует себя принятым и может свободно выражать свои мысли без страха ошибки или критики.

Для детей, находящихся на длительном лечении, особенно важно подбирать темы для обсуждения, основанные на их интересах и личностных смыслах, что по нашему наблюдению, помогает учащимся преодолеть апатию и способствуют эмоциональной включенности в процесс обучения [3].

Дискуссию целесообразно организовывать не только на уроках, но и на внеурочных мероприятиях: например, обсуждение тем, связанных с искусством,

природой, наукой или технологиями позволяет расширять кругозор учеников и поддерживать их познавательный интерес.

Учебная дискуссия в госпитальной школе является средством формирования коммуникативных УУД, способствуя не только развитию, но и социальной реабилитации и психологической поддержке учащихся. «Образовательная среда в условиях медицинского стационара призвана обеспечить развитие ребенка и его способностей, формирование положительной самооценки, мотивации, быть средой исследований, открытий и познания, давать возможность ребёнку проявить себя» [4, с. 31, 4].

Литература

1. Кларин, М.В. Технологии дискуссии в образовательном процессе / М.В. Кларин // Народное образование. – 2015. – № 5. – С. 139-151.
2. Хаустова, В.Н. Учебная дискуссия как эффективная модель формирования ценностных ориентиров школьников / В.Н. Хаустова, И.В. Бондаренко, М.Н. Савоненко // Инновационные педагогические технологии: материалы VIII Междунар.науч.конф. (г. Казань, май 2018 г.). – Казань: Молодой ученый. – 2018. – С. 40-42.
3. Шариков, С.В. Педагогическая поддержка образовательных возможностей детей, находящихся на длительном лечении в медицинских стационарах / С.В. Шариков // Альманах Института коррекционной педагогики. – 2020. – № 40. – С. 22-42.
4. Разъяснения по вопросам организации обучения по основным общеобразовательным программам и дополнительным общеразвивающим программам для детей, нуждающихся в длительном лечении в медицинских организациях // Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.08.2023 № ТВ-1693/03

References

1. Klarin, M.V. Tekhnologii diskussii v obrazovatel'nom processe / M.V. Klarin // Narodnoe obrazovanie. – 2015. – № 5. – S. 139-151.
2. Haustova, V.N. Uchebnaya diskussiya kak effektivnaya model' formirovaniya cennostnyh orientirov shkol'nikov / V.N. Haustova, I.V. Bondarenko, M.N. Savonenko // Innovacionnye pedagogicheskie tekhnologii: materialy VIII Mezhdunar.nauch.konf. (g. Kazan', maj 2018 g.). – Kazan': Molodoj uchenyj. – 2018. – S. 40-42.
3. Sharikov, S.V. Pedagogicheskaya podderzhka obrazovatel'ny`x vozmozhnostej detej, naxodyashhixsya na dlitel'nom lechenii v medicinskix stacionarax / S.V. Sharikov // Al'manax Instituta korrekcionnoj pedagogiki. – 2020. – № 40. – S. 22-42.
4. Raz'yasneniya po voprosam organizacii obucheniya po osnovnym obshcheobrazovatel'nym programmam i dopolnitel'nym obshcherazvivayushchim programmam dlya detej, nuzhdayushchihsya v dlitel'nom lechenii v medicinskih organizacijah // Prikaz Ministerstva prosveshcheniya Rossijskoj Federacii ot 24.08.2023 № TV-1693/03.

ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПРИ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ

УДК 372.881.111.1

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ ГОСПИТАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Крымкова Марина Михайловна

специализированное структурное подразделение
ГБОУ Школа № 109 «Госпитальная школа «УчимЗнаем»

тьютор

krymkova.mm@uchimznaem.ru

USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A DIGITAL TOOL IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING IN HOSPITAL SCHOOL

Krymkova Marina Mikhailovna

specialized structural unit GBOU School № 109
“Hospital school “We Teach/They Learn”

tutor

krymkova.mm@uchimznaem.ru

Аннотация. рассматриваются преимущества использования искусственного интеллекта (ИИ), включая создание адаптивной образовательной среды, обеспечивающей непрерывность учебного процесса независимо от психофизического состояния обучающегося. Приводятся примеры использования ИИ на уроках английского языка в условиях госпитальной школы из практики.

Ключевые слова: искусственный интеллект, иностранный язык, госпитальная школа, персонализация, длительно болеющий ребенок.

Abstract. The article examines the advantages of using Artificial Intelligence (AI), including the creation of an adaptive educational environment that ensures the continuity of the learning process, regardless of the student's psychophysical condition. Examples of AI implementation in English language lessons in a hospital school are provided.

Keywords: AI, foreign language, hospital school, personalization, child with long-term illnesses.

Искусственный интеллект играет все более важную роль в современном образовании, в том числе и в области преподавания английского языка. Использование искусственного интеллекта в обучении английскому языку позволяет персонифицировать материал под конкретного учащегося с учетом его интересов и уровня знаний [1]. Платформы, основанные на ИИ, могут анализировать уровень владения языком и цели обучения учащихся, чтобы

создавать материалы, соответствующие их индивидуальным особенностям. Для длительно болеющих детей, находящихся в состоянии повышенной тревожности, важна минимизация стрессогенных факторов в учебной деятельности [2]. ИИ может адаптировать содержание учебных материалов в соответствии с текущим когнитивным и физическим состоянием ученика, находящегося на длительном лечении, таким образом снижается уровень стресса и повышается интерес к обучению. ИИ способствует оптимизации временных ресурсов тьютора, а также обеспечивает возможность творческого подхода и организации учебного процесса с учетом потребностей детей, находящихся на длительном лечении. ИИ делает процесс изучения английского языка более продуктивным благодаря использованию инновационных технологий [3]. Несмотря на то, что у учащихся не всегда бывает возможность практиковать иностранный язык с носителем, ИИ имеет возможность имитировать разговоры с ребенком на интересующие его темы, что позволяет повышать уровень владения языком и вовлекать в обучающий процесс.

При изучении языка выделяются четыре основных навыка: восприятие и понимание речи на слух (аудирование), восприятие и понимание речи в письменном виде (чтение), умение выразить свои мысли в письменном виде (письмо) и умение выразить их устно (говорение). С помощью ИИ нами разработаны материалы для использования на уроках английского языка на формирования каждого навыка. Нами были созданы аудиовизуальные материалы для повышения вовлеченности учащихся (изображения, аудиофайлы, видеозаписи), сгенерированы собственные тексты на темы урока.

Таким образом, интеграция искусственного интеллекта в процесс обучения английскому языку длительно болеющих детей обладает значительным дидактическим потенциалом. Ключевые преимущества заключаются в создании адаптивной, персонализированной и психологически комфортной образовательной среды, которая не только обеспечивает усвоение учебного материала, но и способствует сохранению познавательной активности обучающихся.

Литература

1. Абишева, К.С. Использование нейросетей на уроке английского языка / К.С. Абишева // Проблемы педагогики. – 2023. – № 3 (64). – С. 23-25.
2. Шариков, С.В. Педагогическая поддержка образовательных возможностей детей, находящихся на длительном лечении в медицинских стационарах / С.В. Шариков // Альманах Института коррекционной педагогики. – 2020. – № 40. – С. 22-42.
3. Еремкина, Н.И. Нейросети как инструмент обучения иностранному языку / Н.И. Еремкина, А.М. Яковлев, С.А. Юдов [и др.] // Моя профессиональная карьера. – 2023. – Т. 1. № 49. – С. 111-120.

References

1. Abisheva, K.S. Ispol'zovanie nejrosetej na uroke anglijskogo yazy'ka / K.S. Abisheva // Problemy` pedagogiki. – 2023. – № 3 (64). – S. 23-25.
2. Sharikov, S.V. Pedagogicheskaya podderzhka obrazovatel'ny`x vozmozhnostej detej, naxodyashhixsya na dlitel'nom lechenii v medicinskix stacionarax / S.V. Sharikov // Al'manax Instituta korrekcionnoj pedagogiki. – 2020. – № 40. – S. 22-42.
3. Eremkina, N.I. Nejroseti kak instrument obucheniya inostrannomu yazy'ku / N.I. Eremkina, A.M. Yakovlev, S.A. Yudov [i dr.] // Moya professional'naya kar'era. – 2023. – T. 1. № 49. – S. 111-120.

УДК 372.854

**ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПРИ ОБУЧЕНИИ ХИМИИ ДЕТЕЙ
С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ НОЗОЛОГИЯМИ**

Ширяев Сергей Дмитриевич

специализированное структурное подразделение
ГБОУ Школа № 109 «Госпитальная школа «УчимЗнаем»

тьютор

ФГБУ «Российская академия образования»

аспирант кафедры педагогики и психологии

shiryaev_ser@mail.ru

Лобанов Антон Валерьевич

доктор химических наук, профессор РАО

ФГБУ «Российская академия образования»

руководитель Центра совершенствования

методик преподавания дисциплин

ФГБОУ ВО МПГУ

заведующий кафедрой общей химии

av.lobanov@mpgu.su

**THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN TEACHING
CHEMISTRY TO CHILDREN WITH ONCOLOGICAL CONDITIONS**

Shiryaev Sergey Dmitrievich

specialized structural unit GBOU School № 109

“Hospital school “We Teach/They Learn”

tutor

Russian Academy of Education

postgraduate student of the Department of Pedagogy and Psychology

shiryaev_ser@mail.ru

Lobanov Anton Valerievich

ScD in Chemistry, Professor of RAE

Russian Academy of Education

Head of the Center for Teaching Methodology Excellence

Moscow Pedagogical State University

Head of the Department of General Chemistry

av.lobanov@mpgu.su

Аннотация. Описываются дидактические возможности использования технологий искусственного интеллекта при обучении химии детей, находящихся на длительном лечении, в условиях медицинских стационаров онкологического профиля. Приводятся конкретные примеры адаптации классических технологий обучения.

Ключевые слова: госпитальная школа, искусственный интеллект, обучение химии, дети, находящиеся на длительном лечении.

Abstract. This article examines the didactic potential of artificial intelligence technologies for teaching chemistry to children undergoing long-term treatment in oncology hospitals. It provides specific examples of how classic teaching methodologies can be adapted within this context.

Keywords: hospital school, artificial intelligence, chemistry education, children undergoing long-term medical treatment.

Повышение эффективности обучения дисциплинам естественно-научного цикла в рамках образовательных программ общего образования является важнейшей задачей, стоящей перед исследователями-методистами, что детерминировано прежде всего государственными нуждами, связанными с подготовкой в перспективе соответствующих профессиональных кадров [1, 2]. Более того, невозможно умалять и значение изучения биологии, физики и химии в интересах развития личности, формирования научной картины мира. Сегодня такая работа активно ведется специалистами Центра совершенствования методик преподавания дисциплин ФГБУ «Российская академия образования». При этом особое значение имеет разработка новых специфических методик и адаптация существующих для повышения эффективности и доступности изучения данных предметов детьми, не имеющими возможность посещать массовую школу.

К ним относятся и те дети и подростки, которые столкнулись с тяжелыми, зачастую жизнеугрожающими, заболеваниями, к которым относится онкология. Специфика данной группы патологий обуславливает большую длительность лечения: ребенок зачастую проводит в стенах медицинского стационара долгие месяцы, а иногда и годы. В этой связи важно формирование особой образовательной среды в стенах медицинских стационаров и особых подходов к педагогической работе с такими обучающимися, что активно реализуется специалистами Проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем» [3].

Ранее мы показали особенности преподавания химической дисциплины в условиях медицинского стационара. Это и невозможность проведения «реального эксперимента», зачастую препятствия, связанные с затрудненностью выполнения письменных работ, когнитивные нарушения, например, снижение интеллекта и объема памяти и др. [4, 5].

Сегодня ИИ-технологии приобрели особое значение в процессе образования: они используются как педагогами, так и обучающимися. К.Р. Кабжалеловым и Е.А. Акказиным констатируется, что учителя химии, не

владеющие профессиональными навыками программирования, могут активно применять его, например, для создания обучающих симуляций [6].

В этой связи среди перспективных направлений использования ИИ авторам представляется симуляция виртуальной лаборатории, в том числе в рамках внеурочных занятий с целью развития познавательного интереса к химической науке (к примеру, изучение метода фотоколориметрии [7]), что особо эффективно, на наш взгляд, при использовании технологий виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR). ИИ же в этом случае будет применяться с целью анализа поведения обучающегося в виртуальной среде, адекватного ответа на принимаемые решения, коррекции его действий и т.д.

Также в контексте обсуждения процесса индивидуализации обучения на уроках химии возможно предложить проведение анализа психофизического состояния для подготовки рекомендаций, используемых педагогом с целью оперативного составления индивидуализированного содержания учебного занятия. Например, учитель задает команду «Я – учитель химии. Я готовлю для ученика [класс, возраст, пол], проходящему лечение в онкологическом центре, урок на тему «[тема]». Проведи опрос обучающегося с целью узнать психологическое и физическое состояние на данный момент. Дай рекомендации для построения плана урока».

Также возможно симулировать нахождение ребенка в классе среди сверстников в случае его изоляции, что обуславливает возможность организовать подобие групповой работы. При этом обучающийся находится в одной «команде» с ИИ – виртуальным сверстником с заранее заданными параметрами. Эта технология может быть использована при проведении урока, предполагающего групповую работу. К примеру, командные задания с разделением полномочий и др.

Однако авторы глубоко убеждены в том, что искусственный интеллект не может и не должен заменять живого человека, тем не менее он может рассматриваться в первую очередь в качестве вспомогательного инструмента для педагога и обучающегося, призванного с большой скоростью обрабатывать поступающую информацию. Считаем, что изучение дидактических возможностей ИИ на сегодняшний день является актуальным, так как они могут сделать процесс обучения детей (особенно длительно болеющих) более доступным и эффективным.

Литература

1. Ширяев, С.Д. К вопросу о необходимости изучения высшей математики при подготовке учителей химии в высших учебных заведениях / С.Д. Ширяев, А.В. Лобанов // Наука и школа. – 2025. – № 3. – С. 143-147.
2. Лобанов, А.В. Профессиональная подготовка кадров в интересах научно-технологического развития Российской Федерации / А.В. Лобанов, М.А. Родионов, С.Д. Ширяев // Проблемы современного образования. – 2024. – № 5. – С. 59-72.
3. Шариков, С.В. Создание образовательной среды для детей, находящихся на длительном лечении в стационарах медицинских учреждений /

С.В. Шариков // Российский журнал детской гематологии и онкологии. – 2015. – Т. 2. № 4. – С. 65-73.

4. Ширяев, С.Д. Об особенностях практического обучения химии детей, находящихся на длительном лечении / С.Д. Ширяев, А.В. Лобанов // Госпитальная педагогика. Лучшие практики обучения детей, находящихся на длительном лечении в медицинских организациях и на дому: Материалы 6-й Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Москва, 31 окт. – 01 нояб. 2024 г. – М.: ГБОУ города Москвы «Школа № 109», ФГБНУ «Институт развития, здоровья и адаптации ребенка». – 2024. – С. 58-62.

5. Аракелянц, Т.А. Влияние протонной и лучевой терапии на когнитивные функции ребенка / Т.А. Аракелянц, Ж.Р. Гарданова, А.В. Чернов // Молодой ученый. – 2016. – № 15(119). – С. 399-400.

6. Кабжалелов, К.Р. Использование искусственного интеллекта в создании учебных программных кодов при обучении химии / К.Р. Кабжалелов, Е.А. Акказин // Вестник науки. – 2025. – Т. 2. – № 4(85). – С. 412-419.

7. Ширяев, С.Д. Фотоколориметрия на внеурочных занятиях / С.Д. Ширяев // Химия в школе. – 2021. – № 9. – С. 68-71.

References

1. Shiryayev, S.D. K voprosu o neobxodimosti izucheniya vy'sshej matematiki pri podgotovke uchitelej ximii v vy'sshix uchebny'x zavedeniyax / S.D. Shiryayev, A.V. Lobanov // Nauka i shkola. – 2025. – № 3. – S. 143-147.

2. Lobanov, A.V. Professional'naya podgotovka kadrov v interesax nauchno-texnologicheskogo razvitiya Rossijskoj Federacii / A.V. Lobanov, M.A. Rodionov, S.D. Shiryayev // Problemy` sovremennogo obrazovaniya. – 2024. – № 5. – S. 59-72.

3. Sharikov, S.V. Sozдание obrazovatel'noj sredy` dlya detej, naxodyashhixsya na dlitel'nom lechenii v stacionarax medicinskix uchrezhdenij / S.V. Sharikov // Rossijskij zhurnal detskoj gematologii i onkologii. – 2015. – Т. 2. № 4. – S. 65-73.

4. Shiryayev, S.D. Ob osobennostyax prakticheskogo obucheniya ximii detej, naxodyashhixsya na dlitel'nom lechenii / S.D. Shiryayev, A.V. Lobanov // Gospital'naya pedagogika. Luchshie praktiki obucheniya detej, naxodyashhixsya na dlitel'nom lechenii v medicinskix organizaciyax i na domu: Materialy` 6-j Vserossijskoj nauchno-prakticheskoy konferencii s mezhdunarodny'm uchastiem, Moskva, 31 okt. – 01 noyab. 2024 g. – М.: ГБОУ города Москвы «Школа № 109», ФГБНУ «Институт развития, здорov`ya i adaptacii rebenka». – 2024. – S. 58-62.

5. Arakelyancz, T.A. Vliyanie protonnoj i lucevoj terapii na kognitivny'e funkcii rebenka / T.A. Arakelyancz, Zh.R. Gardanova, A.V. Chernov // Molodoj ucheny`j. – 2016. – № 15(119). – S. 399-400.

6. Kabzhalelov, K.R. Ispol'zovanie iskusstvennogo intellekta v sozdanii uchebny'x programmny'x kodov pri obuchenii ximii / K.R. Kabzhalelov, E.A. Akkazin // Vestnik nauki. – 2025. – Т. 2. – № 4(85). – S. 412-419.

7. Shiryayev, S.D. Fotokolorimetriya na vneurochny'x zanyatiyax / S.D. Shiryayev // Ximiya v shcole. – 2021. – № 9. – S. 68-71.

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ВОСПИТАНИЯ В ГОСПИТАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

УДК 376.24

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ

Константинов Василий Васильевич

структурное (учебное) подразделение ГБОУ школа № 409
при ФГБУ НМИЦ детской травматологии
и ортопедии им. Г.И. Турнера
учитель
v-v-konstantinov12@yandex.ru

Щурова Александра Николаевна

структурное (учебное) подразделение ГБОУ школа № 409
при ФГБУ НМИЦ детской травматологии
и ортопедии им. Г.И. Турнера
учитель
nevinka_forever@mail.ru

SOCIOCULTURAL PROJECT AS A MEANS OF FORMING CIVIC IDENTITY AMONG STUDENTS WITH DISABILITIES

Konstantinov Vasily Vasilyevich

Structural (educational) division of GBOU school No. 409
at the G.I. Turner National Research
Medical Center for Pediatric Traumatology and Orthopedics
teacher
v-v-konstantinov12@yandex.ru

Shchurova Alexandra Nikolaevna

Structural (educational) division of GBOU school No. 409
at the G.I. Turner National Research
Medical Center for Pediatric Traumatology and Orthopedics
teacher
nevinka_forever@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования гражданской идентичности у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях длительной госпитализации. В качестве средства решения данной проблемы рассматривается технология социокультурного проектирования. Отмечаются исторические предпосылки такого подхода на примере работы специалистов госпитальной школы в ФГБУ НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера. Уделяется внимание описанию

социокультурного патриотического проекта «Морской Атлас Петербурга от А до Я», реализуемого структурным (учебным) подразделением ГБОУ школа № 409 Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее – госпитальная школа) и школы-партнера.

Ключевые слова: гражданская идентичность, социокультурный проект, обучающиеся с ОВЗ, виртуальная экскурсия, госпитальная педагогика.

Abstract. The article is devoted to the relevant problem of forming civic identity among students with disabilities undergoing long-term treatment. The technology of sociocultural design is considered as an effective means of addressing this issue. The author highlights the historical prerequisites for this approach, using the example of the work of specialists in a hospital school withing the H. Turner Federal State Budgetary Institution of National Medical Research Center for Childrens Orthopaedics and Trauma Surgery. The article describes in detail the sociocultural patriotic project "Marine Atlas of St. Petersburg from A to Z", implemented by the hospital school (a structural unit of School No. 409 in Pushkin district, St. Petersburg) together with a partner school.

Keywords: civic identity, sociocultural project, students with disabilities, virtual tour, hospital pedagogy.

Современное образование стремится к созданию инклюзивной среды, обеспечивающей равный доступ к качественному образованию для всех детей, включая обучающихся с ОВЗ. Одной из ключевых задач в работе с такой категорией детей является преодоление социальной изоляции. Для детей, находящихся на лечении, изоляция носит двойной характер: вызвана ограничением двигательных возможностей, формирующих у ребенка неполную картину мира, и пространственный – изоляция больничными стенами [1]. Все это, по нашим наблюдениям, деструктивно сказывается на формировании личности, погружает ученика в состояние дистресса. Отметим, что обучающийся не может выразить свои переживания вербально и остается в состоянии подавленности.

Гражданская идентичность является одним из ключевых факторов развития личности. Идентичность человека не является статичной характеристикой – она непрерывно развивается и трансформируется на всех этапах жизненного пути. При этом ранний период – детство и юность – играют ключевую роль в становлении личности, поскольку именно в это время процессы формирования идентичности протекают наиболее интенсивно. Любые отклонения или нарушения в этот период могут существенно повлиять на дальнейшее развитие человека и его самоопределение [2]. В связи с этим особую значимость приобретает организация процесса становления гражданской идентичности, которая должна проходить под руководством опытного педагога и быть максимально сбалансированной. Только при таком подходе можно обеспечить полноценное формирование личности с устойчивой системой ценностей и гражданской позицией.

Особенно актуальным становится вопрос формирования гражданской идентичности у обучающихся с ОВЗ, поскольку данная категория требует особого подхода в процессе социализации. Ребенок должен чувствовать принадлежность к сообществу граждан своего государства, готовность участвовать в его жизни и разделять ответственность за его будущее. Для учащихся с ОВЗ этот процесс сопряжен с дополнительными трудностями: часто сужение социальных контактов, опыт «навешивания ярлыков» и ограниченный доступ к культурным и общественным событиям затрудняют формирование связи с «большим» обществом. Преодолеть эти барьеры и стать мощным катализатором процесса способна технология социокультурного проектирования.

Социокультурный проект представляет собой комплексную систему мероприятий, направленную на развитие личности через включение в культурную и социальную среду. В контексте работы с обучающимися с ОВЗ такие проекты становятся эффективным инструментом социализации, способствующим:

- формированию позитивного самовосприятия;
- развитию социальных компетенций;
- повышению уровня социальной адаптации [3].

В ФГБУ НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера (далее – медицинский центр) опыт организации образовательной деятельности уходит в 20-е гг. XX века. Тогда деятельность лечебно-воспитательного детского дома (прежнее название медицинского центра) не ограничивалось рамками медицины. Уже тогда понимали, что здоровье – это комплексное понятие, включающее в себя физическое состояние и эмоциональное благополучие детей.

В указанный период медицинский центр осуществлял сотрудничество с Академией наук, Ленинградским государственным театром марионеток им. Е.С. Деммени, а также с ведущими музеями города. Как отмечал руководитель центра Г.И. Турнер, данное взаимодействие основывалось на концепции параллельного воздействия на пациента: так называемой «ортопедии души» (театральное искусство) и «ортопедии тела». Музейные организации предоставляли для проведения культурно-просветительских мероприятий в стационаре диапозитивы, которые использовались в ходе лекций и тематических бесед. Проводимая культурно-реабилитационная работа способствовала позитивной динамике эмоционального состояния юных пациентов, что, в свою очередь, оказывало положительное влияние на процесс их клинического выздоровления [4]. Тогда впервые был реализован принцип, который сегодня является золотым стандартом: лечить нужно не болезнь, а личность ребенка, обеспечивая его медицинские, образовательные, социальные и психологические потребности.

Вышеописанная деятельность медицинского центра в рамках социальной реабилитации детей, находящихся на длительном лечении, продолжается по сей день. В настоящее время в госпитальной школе реализуется социокультурный патриотический проект «Морской Атлас Петербурга от А до Я».

В Санкт-Петербург ежегодно приезжает огромное количество детей на длительное сложное лечение в медицинские организации. Для многих ребят

время лечения и обучения в медицинском центре – единственная возможность посетить Северную столицу, прикоснуться к истории и культуре, раскрыть свой творческий потенциал. Однако, находясь на длительном лечении, они не могут отправиться гулять по городу, они изолированы от окружающего мира. Особую актуальность приобретает проблема доступности культурного наследия в контексте организации экскурсионной деятельности для детей с ОВЗ. Проведение реальных экскурсий для данной категории лиц сопряжено с рядом объективных трудностей, к которым относятся: наличие физических барьеров в архитектурной среде, потребность в специализированном транспорте, повышенная психоэмоциональная и сенсорная нагрузка, а также возможные медицинские противопоказания.

Виртуальная экскурсия уже доказала свою эффективность как инструмент, расширяющий границы образовательного пространства. Однако создание по-настоящему качественного, методически грамотного и адаптированного под особые образовательные потребности контента – задача, которая непосильна для одного образовательного учреждения.

Социальное партнерство становится ключевым механизмом, позволяющим объединить ресурсы, компетенции и усилия различных организаций для достижения общей цели – создания доступного и развивающего виртуального контента для детей с ОВЗ [5].

Идея реализуемого проекта «Морской Атлас Петербурга от А до Я» появилась на свет в школе № 708 «Открытие» Василеостровского района Санкт-Петербурга. Через призму становления и укрепления военно-морского флота, побед и исторических событий, разворачивающихся в Санкт-Петербурге, обучающиеся знакомятся с историей страны, развивают мотивацию для дальнейшего изучения истории Отечества.

Цель проекта – осуществление комплексного подхода к воспитанию детей в духе патриотизма, приобщение школьников из разных регионов страны в условиях стационара к истории и культуре Санкт-Петербурга; развитие мотивации к изучению истории, географии, искусства и др.; расширение кругозора обучающихся; раскрытие личного творческого потенциала обучающихся.

Творческая группа обучающихся школы «Открытие» разрабатывает и создает виртуальные экскурсии к памятным объектам морской тематики на определенную букву алфавита от А до Я (памятники, монументы, гидронимы, топонимы). Затем эти видеоролики просматривают пациенты в госпитальной школе. Свои впечатления от знакомства с достопримечательностями ребята выражают в рисунках и кратких эссе, которые войдут в детский морской атлас на печатной основе - в нем будут не только творческие материалы обучающихся, но и qr- коды на записанные видеоэкскурсии [4].

Таким образом, складывается ситуация, когда дети становятся положительным ресурсом друг для друга, обогащая свой личный потенциал. Через знакомство с историей, культурой и традициями Санкт-Петербурга обучающиеся могут расширить кругозор и повысить социокультурные и творческие компетенции.

В ходе проведения анкетирования о качестве работы госпитальной школы за 2024-2025 учебный год, 87% ребят отмечают развивающие занятия «Морской атлас Петербурга от А до Я» как самые запоминающиеся. Это объясняется в первую очередь тем, что гидами на виртуальной экскурсии являются сверстники-обучающиеся петербургской школы. Такой формат значительно больше привлекает ребят с ОВЗ, мотивирует на дальнейшее обучение, актуализирует уже имеющиеся знания, активизирует исследовательскую деятельность и творческий поиск. При выборе лечебного заведения решающим фактором для ребят и родителей является наличие школы, где проводится масштабная работа по социальной адаптации детей, находящихся на длительном лечении.

Социокультурное проектирование – это не просто педагогическая технология, это мост, соединяющий внутренний мир ребенка с ОВЗ с жизнью большого общества. Через реальное, значимое дело он не только усваивает абстрактные гражданские ценности, но и проживает их, чувствуя себя не пассивным потребителем, а активным, сознательным и полноправным гражданином своей страны. Задача образовательной системы – создать как можно больше таких «мостов», обеспечив каждому ребенку возможность внести свой уникальный вклад в общее культурное и социальное пространство.

Радость и положительные эмоции от участия в проекте, несомненно, мотивируют ребят на дальнейшую учебу и скорейшее выздоровление.

Литература

1. Шариков, С.В. Педагогическая поддержка образовательных возможностей детей, находящихся на длительном лечении в медицинских стационарах / С.В. Шариков // Альманах Института коррекционной педагогики. – 2020. – № 40. – С. 22-42.
2. Карпова, Г.А. Инклюзивное образование: педагогическая практика и социокультурные проекты / Г.А. Карпова, Т.В. Артемьева // Педагогическое образование в России. – 2017. – № 12. – С. 56-61.
3. Борисова, Н.В. Социокультурное проектирование как технология формирования гражданской идентичности подростков / Н.В. Борисова, М.М. Савенкова // Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2019. – № 4 (201). – С. 64-70.
4. «Морской Атлас Петербурга от А до Я» знакомит учащихся Школы Турнера с Северной столицей. – URL: <https://centercoop.ru/press-tsentr/novosti/morskoy-atlas-peterburga-ot-a-do-ya-znakomit-uchashchikhsya-shkoly-turnera-s-severnoy-stolitsey> (Дата обращения 17.09.2025).
5. Константинов, В.В. Социальное партнерство школы как условие формирования положительной мотивации учения подростков / В.В. Константинов // Материалы 22 Межвузовской студенческой научной конференции «Студент – Исследователь – Учитель» [Электронный ресурс] / ред. кол.: Бочарова Н.А., Верба Н.И., Вологова Т.С. и др. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена. – 2021. – С. 1070-1076.

References

1. Sharikov, S.V. Pedagogicheskaya podderzhka obrazovatel'ny'x vozmozhnostej detej, naxodyashhixsya na dlitel'nom lechenii v medicinskix stacionarax / S.V. Sharikov // Al'manax Instituta korrekcionnoj pedagogiki. – 2020. – № 40. – S. 22-42.
2. Karpova, G.A. Inklyuzivnoe obrazovanie: pedagogicheskaya praktika i sociokul'turny'e proekty' / G.A. Karpova, T.V. Artem'eva // Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii. – 2017. – № 12. – S. 56-61.
3. Borisova, N.V. Sociokul'turnoe proektirovanie kak texnologiya formirovaniya grazhdanskoj identichnosti podrostkov / N.V. Borisova, M.M. Savenkova // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. – 2019. – №4 (201). – S. 64-70.
4. «Morskoy Atlas Peterburga ot A do Ya» znakomit uchashhixsya Shkoly` Turnera s Severnoj stolicej. – URL: <https://centercoop.ru/press-tsentr/novosti/morskoy-atlas-peterburga-ot-a-do-ya-znakomit-uchashchikhsya-shkoly-turnera-s-severnoy-stolitsey> (Accessed 17.09.2025).
5. Konstantinov, V.V. Social'noe partnerstvo shkoly` kak uslovie formirovaniya polozhitel'noj motivacii ucheniya podrostkov / V.V. Konstantinov // Materialy` 22 Mezhvuzovskoj studencheskoj nauchnoj konferencii «Student – Issledovatel' – Uchitel'» [E`lektronny`j resurs] / red. kol.: Bocharova N.A., Verba N.I., Vologova T.S. i dr. – SPb.: Izd-vo RGPU im. A.I. Gercena. – 2021. – S. 1070-1076.

УДК 372.879.6

**ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ПАТРИОТИЗМА
ЧЕРЕЗ ПРОГРАММУ «СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП»
В ГОСПИТАЛЬНОЙ ШКОЛЕ**

Бабенков Николай Дмитриевич

специализированное структурное подразделение

ГБОУ Школа № 109 «Госпитальная школа «УчимЗнаем»

руководитель службы психолого-педагогического и социального сопровождения

тьютор, учитель-дефектолог

babenkov.nd@uchimznaem.ru

Гавриленко Алексей Дмитриевич

специализированное структурное подразделение

ГБОУ Школа № 109 «Госпитальная школа «УчимЗнаем»

тьютор

gavrilenko.ad@uchimznaem.ru

**THE DEVELOPMENT OF A HEALTHY LIFESTYLE AND PATRIOTISM
THROUGH THE “SPORTS KALEIDOSCOPE” PROGRAM
IN HOSPITAL SCHOOL**

Babenkov Nikolay Dmitrievich

specialized structural unit GBOU School № 109

“Hospital school “We Teach/They Learn”

Head of the psychological and pedagogical support service tutor

teacher-defectologist

babenkov.nd@uchimznaem.ru

Gavrilenko Alexey Dmitrievich

specialized structural unit GBOU School № 109

“Hospital school “We Teach/They Learn”

tutor

gavrilenko.ad@uchimznaem.ru

Аннотация. В статье рассматривается значение доступного спорта в госпитальной образовательной среде для детей, находящихся на длительном лечении. Представлена разработанная авторами программа «Спортивный калейдоскоп», включающая три тематических блока: зимние виды спорта, летние виды спорта и современный спорт.

Ключевые слова: ребёнок, находящийся на длительном лечении, физическое развитие, госпитальная педагогика, доступный спорт.

Abstract. The article examines the importance of accessible sports in the hospital learning setting for children undergoing long-term treatment. It also describes "The Sports Kaleidoscope" program that is tailored by the authors and includes three thematic units: winter sports, summer sports and modern sports.

Keywords: a child undergoing long-term medical treatment, physical development, hospital pedagogy, accessible sports.

Физическая активность является важным компонентом в лечении и реабилитации больных раком и улучшает функциональное здоровье онкологических пациентов. Однако, отмечается, что комплексная реабилитация еще не реализована во всех онкологических медицинских центрах [1]. Для решения данной проблемы в госпитальной школе были организованы занятия по доступному спорту. Проведение таких занятий преследует следующие задачи: формирование здорового образа жизни, развитие дисциплины, целеустремленности, воли к победе и коммуникативных навыков, а также обучение командной работе. Занятия учитывают индивидуальные возможности каждого ребенка, что особенно важно в условиях стационара [2, 3].

Доступный спорт является важной частью образовательной среды госпитальной школы, в которой обучаются дети, находящиеся на длительном лечении. По нашим наблюдениям спорт в таких условиях не только поддерживает физическую активность, но и играет ключевую роль в сохранении психоэмоционального здоровья ребенка, снижая стресс и помогая социализации, что положительно сказывается на комплексном процессе реабилитации.

Отметим, что одной из задач госпитального спорта является формирование понимания роли и значения мирового и российского олимпийского движения, воспитание патриотизма и уважения к отечеству через знания истории и современного состояния развития спорта. Занятия органично вписываются в образовательный процесс, способствуя развитию любознательности и учебной мотивации. Для реализации вышеупомянутой задачи авторами была разработана программа «Спортивный калейдоскоп», представляющая собой три блока: зимние виды спорта, летние виды спорта и современный спорт.

В первом блоке дети знакомятся со следующими спортивными дисциплинами: «биатлон», «лыжный спорт», «хоккей с шайбой», «фигурное катание». Во втором блоке: «баскетбол», «волейбол», «футбол», «большой теннис». В третьем блоке рассматриваются виды спорта, которые пока не входят в Олимпийское движение: «флаинг диск», «киберспорт», «бильярд».

Во всех блоках обучающиеся обязательно познакомятся с различными видами спорта, узнают о важных турнирах, известных спортсменах, и в тоже время узнают о советских и российских спортсменах.

Занятия строятся по следующему маршруту:

1. Введение, где изучается история спорта, правила игры.
2. Основная часть, в которой описываются важные даты из истории спорта, турниры, а также предлагаются разные видеофрагменты со спортивных мероприятий, где участвуют известные советские и отечественные спортсмены.

3. В активной паузе учащимся предлагается викторина «интересные факты о спорте» или попробовать элементы обсуждаемого вида спорта.

4. В заключительной части педагоги и дети делятся впечатлениями от темы занятия, подводят итоги о спорте (заполняют чек-лист) по теме занятия.

Таким образом, программа «Спортивный калейдоскоп» способствует комплексному развитию детей, находящихся на длительном лечении, объединяя в себе не только физическую активность, но и важные воспитательные и образовательные задачи. Кроме того, тесная связь педагогов госпитальной школы с реабилитологами и родителями позволяет создать междисциплинарную команду для комплексной поддержки ребенка.

Литература

1. Щербак, С.Г. Реабилитация онкологических пациентов / С.Г. Щербак, Д.А. Вологжанин, Т.А. Камилова, А.С. Голота, С.В. Макаренко, Е.В. Усикова // Университетский терапевтический вестник. – 2024. – Т. 6. – № 3. – С. 19-35.

2. Бабенков, Н.Д. Формирование физической культуры у детей, находящихся на длительном лечении: доступный спорт в госпитальной школе / Н.Д. Бабенков, А.Д. Гавриленко // Госпитальная педагогика. Лучшие практики обучения детей, находящихся на длительном лечении в медицинских организациях и на дому: Материалы 4-й Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Москва, 01–03 ноября 2022 года. – Москва: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт развития, здоровья и адаптации ребенка». – 2022. – С. 96-97.

3. Шариков, С.В. Педагогическая поддержка образовательных возможностей детей, находящихся на длительном лечении в медицинских стационарах / С.В. Шариков // Альманах Института коррекционной педагогики. – 2020. – № 40. – С. 22-42.

References

1. Shherbak, S.G. Reabilitaciya onkologicheskix pacientov / S.G. Shherbak, D.A. Vologzhanin, T.A. Kamilova, A.S. Golota, S.V. Makarenko, E.V. Usikova // Universitetskij terapevticheskij vestnik. – 2024. – T. 6. № 3. – S. 19–35.

2. Babenkov, N.D. Formirovanie fizicheskoy kul'tury` u detej, naxodyashhixsya na dlitel`nom lechenii: dostupny`j sport v gospital`noj shkole / N.D. Babenkov, A.D. Gavrilenko // Gospital`naya pedagogika. Luchshie praktiki obucheniya detej, naxodyashhixsya na dlitel`nom lechenii v medicinskix organizacijax i na domu: Materialy` 4-j Vserossijskoj nauchno-prakticheskoy konferencii s mezhdunarodny`m uchastiem, Moskva, 01–03 noyabrya 2022 goda. – Moskva: Federal`noe gosudarstvennoe byudzhethoe nauchnoe uchrezhdenie Institut razvitiya, zdorov`ya i adaptacii rebenka. – 2022. – S. 96-97.

3. Sharikov, S.V. Pedagogicheskaya podderzhka obrazovatel`ny`x vozmozhnostej detej, naxodyashhixsya na dlitel`nom lechenii v medicinskix stacionarax / S.V. Sharikov // Al`manax Instituta korrekcionnoj pedagogiki. – 2020. – № 40. – S. 22-42.

УДК 376.24

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕНДОВОГО МОДЕЛИЗМА ДЛЯ МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ И ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО СТАНОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ГОСПИТАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Ляховецкий Александр Петрович

специализированное структурное подразделение
ГБОУ Школа № 109 «Госпитальная школа «УчимЗнаем»

тьютор

lyahoveckiy.ap@uchimznaem.ru

Шакиров Рустэм Равилевич

специализированное структурное подразделение
ГБОУ Школа № 109 «Госпитальная школа «УчимЗнаем»

тьютор

shakirov.rr@uchimznaem.ru

USING SCALE MODELING TO MOTIVATE LEARNING AND FOSTER CIVIC-PATRIOTIC DEVELOPMENT IN CHILDREN IN HOSPITAL SCHOOL

Lyakhovetsky Alexander Petrovich

specialized structural unit GBOU School № 109
“Hospital school “We Teach/They Learn”

tutor

lyahoveckiy.ap@uchimznaem.ru

Shakirov Rustem Ravilevich

specialized structural unit GBOU School № 109
“Hospital school “We Teach/They Learn”

tutor

shakirov.rr@uchimznaem.ru

Аннотация. Рассматриваются практические инструменты гражданско-патриотического воспитания детей, находящихся на длительном лечении. Описано как использование элементов музейной педагогики и стендового моделизма в рамках проекта «УчимЗнатьИсторию» помогает преодолеть изоляцию и превратить изучение истории в увлекательный личный опыт. Продемонстрированы методы трансформации роли ученика из пассивного слушателя в активного исследователя, а также практические аспекты организации проектной деятельности, направленной на формирование осознанной гражданской позиции и поддержку познавательной активности обучающегося в госпитальной школе.

Ключевые слова: гражданско-патриотическое воспитание, госпитальная школа, музейная педагогика, стендовый моделизм, проект «УчимЗнатьИсторию», длительно болеющие дети, проектная деятельность, социальная адаптация, реабилитационно-образовательная среда.

Abstract. The article focuses on practical tools for the civic and patriotic education of children undergoing long-term treatment. It explains how the use of museum pedagogy and scale modeling techniques within the "LearnToKnowHistory" project helps overcome isolation and transform the study of history into an engaging, personal experience. The methods demonstrated include shifting the student's role from a passive listener to an active researcher, as well as practical aspects of organizing project-based activities aimed at developing a conscious civic stance and supporting cognitive engagement in a hospital school setting.

Keywords: civic-patriotic education, hospital school, museum pedagogy, scale modeling, the "LearnKnowHistory" project, children with long-term illnesses, project-based activities, social adaptation, rehabilitation and educational environment.

Формирование гражданско-патриотического воспитания – одна из основных задач образовательного учреждения. Организация воспитательного процесса должна быть направлена на выполнение социального заказа государства по личностному формированию будущих членов общества [1].

В связи с этим госпитальная школа создает специальные условия обучения для детей, нуждающихся в длительном лечении в медицинских организациях, и осуществляет поиск эффективных инструментов, направленных не только на обучение, но и на гражданско-патриотическое воспитание детей. Одним из таких инструментов выступают элементы музейной педагогики: экскурсия, лекция, консультация, научные чтения, клуб (кружок, студия), конкурс (олимпиада, викторина), встреча с интересным человеком, концерт (литературный вечер, театрализованное представление, киносенс), праздник, историческая игра [2]. Их интеграция в практику работы госпитальной школы обусловлена тем, что эти элементы ориентированы на передачу культурного опыта через педагогический процесс [3]. Использование элементов музейной педагогики позволяет создать особую образовательно-развивающую среду, способствующую преодолению изоляции, эмоциональной разгрузке и поддержанию познавательной активности детей, что напрямую работает на улучшение качества жизни ребенка в стационаре. Творческая, практическая деятельность становится тем «якорем», которая отвечает на запрос превращения истории и патриотического воспитания из абстрактных дисциплин в осязаемый и увлекательный опыт.

Образовательно-просветительский проект «УчимЗнатьИсторию», главная цель которого – заложить прочные основы гражданской идентичности и патриотического сознания у подрастающего поколения. Особенностью проекта является принципиальное изменение роли ученика: превращая его из пассивного слушателя в активного и увлеченного исследователя, хранителя исторической памяти. Этот подход реализуется путем глубокого погружения в практическую и исследовательскую работу, где школьники самостоятельно изучают архивные

документы, семейные реликвии и судьбы людей, что позволяет им ощутить живую, неразрывную связь с прошлым и сформировать осознанную гражданскую позицию, основанную не на лозунгах, а на личном переживании и опыте. Особую роль в образовательном процессе тут играет стендовый моделизм, выступающий инструментом комплексного развития ребенка. Его уникальность заключается в сочетании средств формирования практических навыков и межпредметного содержания. С предметной точки зрения, он интегрирует в себе историю, географию, физику и технологию, позволяя ребенку увидеть не разрозненные факты, а сформировать целостную картину мира. Отметим, что процесс сборки модели развивает у ребенка интеллект (логику, пространственное мышление), мелкую моторику, помогает поддерживать целеустремленность, творческие способности и эмоциональную устойчивость.

При этом процесс создания моделей наиболее эффективно работает тогда, когда мы действуем в зоне интереса ребенка и зоне ближайшего развития. На этой основе можно готовить обучающегося к решению более сложных задач – от простой сборки к созданию крупных экспозиций, от индивидуальной работы к совместным проектам с другими учащимися. Именно коммуникативный аспект, реализуемый в таких проектах, как создание диорам и их защита, позволяет создать прочную эмоциональную связь с историей. Совместное творчество, где дети объединяют свои модели в единый исторический сюжет, а затем учатся аргументировать свой замысел, превращает абстрактные знания в личный опыт. Отметим, что насыщенность индивидуальной программы обучения и развитие интересов ребенка основывается исключительно на рекомендациях врачей об объеме такого рода деятельности относительно каждого их пациента в период лечения [4].

Таким образом, стендовый моделизм реализует главную цель проекта «УчимЗнатьИсторию» – не просто дать знания ученикам о важных датах и событиях, а позволить прочувствовать историю как живую и многогранную реальность, достигая образовательных, социальных и психологических результатов в ходе проектной и исследовательской деятельности.

Будущая стратегическая цель проекта – трансформация из образовательной практики в неотъемлемую часть целостной реабилитационно-образовательной экосистемы для детей, находящихся на длительном лечении. Основу будущего роста составит масштабирование отработанной методики на другие регионы и образовательные учреждения, параллельно расширяя тематику, добавляя направления по культурному наследию, истории науки и технологий, чтобы вовлечь детей с самыми разными интересами. Ведь каждый ребенок, независимо от обстоятельств, должен иметь возможность через творчество и изучение истории преодолеть изоляцию, обрести уверенность в себе и устойчивый интерес к познанию.

Литература

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022). – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (Дата обращения 20.04.2023).
2. Юхневич, М.Ю. Я поведу тебя в музей: Учеб. пособие по музейной педагогике / М-во культуры РФ. Рос. ин-т культурологии. – М. – 2001. – 154 с.
3. Мышева, Т.П. Музейная педагогика как формируется научная дисциплина [Текст] / Т.П. Мышева // Вестник Таганрогского института имени А.П. Чехова. – 2011. – № 2. – С. 44-49.
4. Шариков, С.В. Создание образовательной среды для детей, находящихся на длительном лечении в стационарах медицинских учреждений / С.В. Шариков // Российский журнал детской гематологии и онкологии. – 2015. – № 4. – Т. 2. – С. 65-73.

References

1. Federal'ny'j zakon ot 29.12.2012 № 273- FZ (red. ot 14.07.2022) «Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii» (s izm. i dop., vstup. v silu s 01.09.2022). – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (Accessed 20.04.2023).
2. Yuxnevich, M.Yu. Ya povedu tebya v muzej: Ucheb. posobie po muzejnoj pedagogike / M-vo kul'tury` RF. Ros. in-t kul'turologii. – M. – 2001. – 154 s.
3. My`sheva, T.P. Muzejnaya pedagogika kak formiruetsya nauchnaya disciplina [Tekst] / T.P. My`sheva // Vestnik Taganrogskego instituta imeni A.P. Chexova. – 2011. – № 2. – S. 44-49.
4. Sharikov, S.V. Sozdanie obrazovatel'noj sredy` dlya detej, naxodyashhixsya na dlitel`nom lechenii v stacionarax medicinskix uchrezhdenij / S.V. Sharikov // Rossijskij zhurnal detskoj gematologii i onkologii. – 2015. – № 4. – T. 2. – S. 65-73.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ГОСПИТАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

УДК 376.24

НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ПЕДАГОГА ГОСПИТАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ

Ветрова Галина Анатольевна
ГБОУ «Многопрофильный центр
развития детей г. Нижний Новгород»
педагог-психолог
vetrova1979@yandex.ru

BOARD GAMES AS A TOOL FOR HOSPITAL SCHOOL TEACHERS TO DIAGNOSE AND CORRECT THE BEHAVIOR OF CHILDREN UNDERGOING LONG-TERM TREATMENT

Vetrova Galina Anatolyevna
State Budgetary Educational Institution “Multiprofile Center
for Child Development, Nizhny Novgorod”
educational Psychologist
vetrova1979@yandex.ru

Аннотация. В работе рассматриваются настольные игры как средство диагностики и коррекции поведения детей, находящихся на длительном лечении. Через игру ребёнок проявляет эмоции, поведение, уровень тревожности, развивает общение и самоконтроль. Практика показывает высокую эффективность применения простых игровых форм.

Ключевые слова: госпитальная педагогика, настольные игры, диагностика, коррекция поведения, дети, находящиеся на длительном лечении.

Abstract. This article examines board games as a tool for diagnosing and correcting behavior in children undergoing long-term treatment. Games allow children to express emotions, behavior, and anxiety, while developing their skills of communication and self-regulation. Experience shows high effectiveness of simple game formats.

Keywords: hospital pedagogy, board games, diagnosis, behavior correction, children undergoing long-term treatment.

Современные исследования подтверждают, что игровые технологии значительно повышают познавательную мотивацию и вовлечённость учащихся в образовательный процесс [1].

Необходимо отметить, что дети, находящиеся на длительном лечении, часто испытывают тревожность, усталость и социальную изоляцию [2, 3]. Настольные

игры становятся доступным инструментом, который помогает педагогу установить контакт, снизить сопротивление и мягко включить ребёнка в взаимодействие.

Следует подчеркнуть, если игра используется в качестве диагностического инструмента, ребёнок проявляет себя естественно, без стремления дать «правильный» ответ. В то же время поведение ребёнка в игре позволяет педагогу оценить реакции на проигрыш, способы выхода из трудной ситуации, умение взаимодействовать с другими. Это делает настольные игры эффективным способом диагностики эмоционального состояния и особенностей поведения.

Коррекционный потенциал настольных игр переоценить сложно. Подбор кооперативных и ролевых игр помогает снижать уровень тревожности, развивать навыки сотрудничества. Важно, что в игровом процессе создаётся эмоционально поддерживающая среда, где ребёнок может пробовать новые модели поведения. Также необходимо отметить формирование доверительных отношений между педагогом и ребёнком, что невозможно достичь через формальные методики.

Исследования по геймификации показывают, что игра активирует нейропластичность мозга, формирует мотивацию и вовлекает в деятельность [4]. Для госпитальной школы это означает снижение сопротивления к обучению, повышение мотивации и интереса к учебной деятельности, сохранение позитивного эмоционального фона.

Настольные игры в госпитальной педагогике – это не развлекательный элемент, а важный диагностико-коррекционный инструмент. Их использование позволяет педагогу понять ребёнка, скорректировать поведение, снизить уровень тревожности и поддержать процесс адаптации. Использование настольных игр в госпитальной школе обосновано как практическим опытом, так и рядом эмпирических исследований.

Например, работа с настольными играми при госпитализации детей показали снижение тревожности и страха [5]; систематический обзор подчёркивает, что настольные игры и программы на их основе способствуют развитию познавательных, коммуникативных и когнитивных функций у детей и подростков [6]; а терапевтические игры в детской психотерапии рассматриваются как перспективный инструмент коррекции эмоционального состояния и поведения [7].

Настольные игры становятся доступным инструментом, который помогает педагогу установить контакт, снизить сопротивление и мягко включить ребёнка в взаимодействие.

На практике используются простые и хорошо знакомые детям игры: «Дженга» (позволяет увидеть уровень самоконтроля и реакцию на ошибки), «Уно» или «Свинтус» (дают представление о соблюдении правил, умении ждать, переживании проигрыша), «Мемори» и игры на определение эмоций (помогают оценить внимание, эмоциональную устойчивость, способность распознавать чувства).

При коррекционной работе эффективны кооперативные игры, где дети не соревнуются, а действуют вместе: это снижает уровень тревожности, формирует доверие и поддерживающую атмосферу. Короткие кооперативные сюжеты, в

которых дети действуют совместно, а не соревнуются, создают поддерживающую атмосферу, снижают тревожность и позволяют безопасно пробовать новые модели поведения, развивая воображение, коммуникативные и когнитивные навыки.

Например «Имаджинариум» способствует пониманию эмоций и креативности, «Лига Детективов: Новые миры» – совместному принятию решений и эмпатии, а «Хронология» – вниманию, памяти и планированию.

Использование таких игр создаёт доверительные отношения и развивает навыки совместного взаимодействия, планирования и решения задач, поддерживая гармоничное социальное и эмоциональное развитие ребёнка.

Литература

4. Насипов, А.Ж. Настольные образовательные игры как средство повышения познавательной мотивации обучающихся на уроках физики / А.Ж. Насипов // Поиск научных решений. – 2023. – № 2. – С. 65-77.

5. Лоскутов, А.Ф. Госпитальная педагогика как современное направление в педагогической науке / А.Ф. Лоскутов, С.В. Шариков, Е.А. Ямбург, А.Г. Румянцев // Народное образование. – 2023. – № 1. – С. 166–173.

6. Шариков, С.В. Педагогическая поддержка образовательных возможностей детей, находящихся на длительном лечении в медицинских стационарах / С.В. Шариков // Альманах Института коррекционной педагогики. – 2020. – № 40. – С. 22-42.

5. Богданова, Е.В. Геймификация современного образования: анализ педагогической практики / Е.В. Богданова, Е.А. Яровая, Ю.Н. Ковшова и др. // Современное педагогическое образование. – 2022. – № 12. – С. 15-19.

6. Benazeera, P. Игровое вмешательство под руководством медицинской сестры и его влияние на тревожность и страх у госпитализированных детей / P. Benazeera, P.R. Aranha // Journal of Education and Health Promotion. – 2025. – eCollection 2025. – URL: <https://journals.lww.com/jehp/pages/default.aspx> (Дата обращения 07.12.2025).

7. Otsuka S., Jayawardena R. Эффективность программ с использованием настольных игр: систематический обзор / S. Otsuka, R. Jayawardena // Cogent Education. – 2019. – Vol. 6. – URL: https://www.researchgate.net/publication/336701401_The_effectiveness_of_intervention_with_board_games_a_systematic_review (Дата обращения 07.12.2025).

8. Chaffin M., Adams J. Использование настольных игр в терапии с детьми / M. Chaffin, J. Adams // International Journal of Play Therapy. – 2013. – Vol. 22(1). – P. 13–31.

References

1. Nasipov, A.Zh. Nastol'ny'e obrazovatel'ny'e igry` kak sredstvo povy`sheniya poznavatel'noj motivacii obuchayushhixsya na urokax fiziki / A.Zh. Nasipov // Poisk nauchny`x reshenij. – 2023. – № 2. – S. 65-77.

2. Loskutov, A.F. Gospiṭal'naya pedagogika kak sovremennoe napravlenie v pedagogičeskoj nauke / A.F. Loskutov, S.V. Sharikov, E.A. Yamburg, A.G. Rumyancev // Narodnoe obrazovanie. – 2023. – № 1. – S. 166–173.
3. Sharikov, S.V. Pedagogičeskaya podderzhka obrazovatel'ny'x vozmožnostej detej, naxodyashhixsya na dlitel'nom lechenii v medicinskix stacionarax / S.V. Sharikov // Al'manax Instituta korrekcionnoj pedagogiki. – 2020. – № 40. – S. 22-42.
4. Bogdanova, E.V. Gejmifikaciya sovremennogo obrazovaniya: analiz pedagogičeskoj praktiki / E.V. Bogdanova, E.A. Yarovaya, Yu.N. Kovshova i dr. // Sovremennoe pedagogičeskoe obrazovanie. – 2022. – № 12. – S. 15-19.
5. Benazeera, P. Igrovoe vmeshatel'stvo pod rukovodstvom medicinskoj sestry i ego vliyanie na trevožnost' i strax u gospiṭalizirovanny'x detej / P. Benazeera, P.R. Aranha // Journal of Education and Health Promotion. – 2025. – eCollection 2025. – URL: <https://journals.lww.com/jehp/pages/default.aspx> (Accessed 07.12.2025).
6. Otsuka S., Jayawardena R. E'ffektivnost' programm s ispol'zovaniem nastol'ny'x igr: sistematičeskij obzor / S. Otsuka, R. Jayawardena // Cogent Education. – 2019. – Vol. 6. – URL: https://www.researchgate.net/publication/336701401_The_effectiveness_of_intervention_with_board_games_a_systematic_review (Accessed 07.12.2025).
7. Chaffin M., Adams J. Ispol'zovanie nastol'ny'x igr v terapii s det'mi / M. Chaffin, J. Adams // International Journal of Play Therapy. – 2013. – Vol. 22(1). – P. 13–31.

УДК 376.24

ИНТЕГРАЦИЯ ШАХМАТ В УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ГОСПИТАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Чурилова Валерия Левановна

МБОУ «Гимназия № 2 г. Владивостока»

Проект госпитальных школ «УчимЗнаем»

тьютор

dolgikh-1996@list.ru

INTEGRATION OF CHESS INTO THE GENERAL EDUCATIONAL SUBJECTS OF THE HOSPITAL SCHOOL

Churilova Valeria Levanovna

MBEI «Gymnasium № 2 in Vladivostok»

Project of Hospital school “We Teach/They Learn”

tutor

dolgikh-1996@list.ru

Аннотация. Рассматривается опыт интеграции шахматных элементов в учебные предметы (математика, русский язык, литературное чтение) в госпитальной школе. Показана эффективность шахмат как инструмента для развития когнитивных навыков, включая критическое, пространственное и стратегическое мышление. Представлены методики, которые способствуют повышению мотивации учащихся и улучшению образовательных результатов.

Ключевые слова: шахматы, госпитальная школа, учебная мотивация, мотивации, учащиеся на длительном лечении, интеграция шахматных элементов.

Abstract. The article examines the experience of integrating chess elements into academic subjects (mathematics, Russian language, and literature) in a hospital school. It demonstrates the effectiveness of chess as a tool for developing cognitive skills, including critical, spatial, and strategic thinking. The presented methods contribute to increasing students' motivation and improving academic outcomes.

Keywords: chess, hospital school, educational motivation, students on long-term treatment, integration of chess elements.

Исследования подтверждают положительное влияние шахмат на развитие когнитивных навыков [1]. Опыт внедрения шахмат в учебный процесс госпитальной школы, где обучение проходит в условиях медицинского учреждения [2], подтверждает эффективность шахмат как инструмента для повышения мотивации и поддержки общего образовательного процесса.

Рассмотрим методики интеграции шахмат в различные общеобразовательные предметы – математику, русский язык, литературное чтение. Особое внимание уделяется развитию у учащихся критического,

пространственного и стратегического мышления, концентрации и навыков решения проблемных ситуаций, что способствует улучшению учебных показателей у детей.

С целью реализации рассматриваемых приемов были адаптированы методики, предложенные Уманской Э.Э. [3]. К примеру, сокращён или расширен объём материала конкретных занятий, изменена форма подачи материала от групповой к индивидуальной. Используются цифровые инструменты (онлайн-платформы, интерактивные задания) вместо предложенного в пособии бумажного формата. Введены игровые и проектные элементы.

В реализации программы применяются следующие педагогические приемы:

1. Иммерсивное чтение - работа с текстами на тему истории шахмат, биографий известных шахматистов (подразумевает использование аудио- и видео- ресурсов, иллюстраций, рабочих листов).

2. Дидактические игры, логические задачи, упражнения на сравнение и обобщение авторского составления на тему шахмат (в том числе работа с шахматными диаграммами).

3. Интерактивные игры с элементами импровизации на уроках ИЗО и Технологии.

Результаты внедрения вышеперечисленных приемов подтверждают эффективность шахмат как инструмента для повышения мотивации и поддержки образовательного процесса в госпитальной школе.

Литература

1. Цубекс, Н.С. Роль и значение шахмат для развития человека / Н.С. Цубекс // Молодой ученый. – 2024. – № 14 (513). – С. 205-207.
2. Шариков, С.В. Создание образовательной среды для детей, находящихся на длительном лечении в стационарах медицинских учреждений / С.В. Шариков // Российский журнал детской гематологии и онкологии. – 2021. – № 4. – С. 65-73.
3. Уманская, Т.А. Шахматы в школе / Т.А. Уманская, Е.В. Волкова, Е.А. Прудникова. – М.: Просвещение. – 2014. – 192 с.

References

1. Czubeks, N.S. Rol' i znachenie shaxmat dlya razvitiya cheloveka / N.S. Czubeks // Molodoj ucheny`j. – 2024. – № 14 (513). – S. 205-207.
2. Sharikov, S.V. Sozdanie obrazovatel'noj sredy` dlya detej, naxodyashhixsya na dlitel'nom lechenii v stacionarax medicinskix uchrezhdenij / S.V. Sharikov // Rossijskij zhurnal detskoj gematologii i onkologii. – 2021. – № 4. – S. 65-73.
3. Umanskaya, T.A. Shaxmaty` v shkole / T.A. Umanskaya, E.V. Volkova, E.A. Prudnikova. – M.: Prosveshhenie. – 2014. – 192 s.

УДК 376.24

**УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ,
КАК ПУТЬ ПРЕОДОЛЕНИЯ НЕУСПЕШНОСТИ ДЕТЕЙ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ГОСПИТАЛЬНОЙ ШКОЛЫ**

Мазанова Ольга Юрьевна
ГОУ Республики Коми
«Республиканский центр образования»
учитель
omaza@mail.ru

**PARTICIPATION IN FINANCIAL LITERACY COMPETITIONS AS A WAY
TO OVERCOME UNDERACHIEVEMENT IN CHILDREN LEARNING
AT A HOSPITAL SCHOOL**

Mazanova Olga Yurievna
SEI of the Komi Republic
"Republican Education Center"
teacher
omaza@mail.ru

Аннотация. Рассматриваются теоретико-методологические подходы к созданию ситуации успеха обучающихся, находящихся на длительном лечении в медицинских учреждениях. Отмечается рост мотивации обучающихся к изучению финансовой грамотности, что вызвано как использованием игровых технологий, которые обеспечивают единство эмоционального и рационального в обучении, направлены на развитие творчества, инициативности детей, так и возможностью принять участие в конкурсах по финансовой грамотности.

Ключевые слова: ситуация успеха, внеурочная деятельность, финансовая грамотность, игровая технология, конкурс, госпитальная школа.

Abstract. The article examines theoretical and methodological approaches to creating a success situation for students undergoing long-term treatment in medical institutions. It highlights an increase in students' motivation to study financial literacy, which is caused by both the use of gaming technologies that ensure the unity of emotional and rational aspects in learning, foster creativity and children's initiative, and the opportunity to take part in financial literacy competitions.

Keywords: success situation, extracurricular activities, financial literacy, game-based technology, competition, hospital school.

Для детей, находящихся на длительном лечении в медицинских учреждениях, главная задача — забота о своем здоровье и выздоровление. Если ребенок надолго оказался в больнице, то очень важно сохранить его увлечения, именно они помогают не потерять связь с нормальной жизнью, дают стимулы к

выздоровлению [1]. Отметим, что для таких детей участие в олимпиадах, конкурсах, дает ощущение, что обычная жизнь продолжается и ребенок в нее включен. Конечно, не во все периоды лечения участие в олимпиадах возможно, но конкурсное движение позволяет выбрать период участия. Главное – детям это важно для выздоровления, им очень нужен стимул жить, а для этого необходимы какой-то интерес, перспектива успеха.

Необходимость создания ситуации успеха каждому ребенку давно осознана педагогической общественностью. К.Д. Ушинский в педагогическом сочинении «Труд в его психическом и воспитательном значении» пришел к выводу, что только успех поддерживает интерес ребенка к обучению. А интерес появляется только тогда, продолжает он, когда есть вдохновение, рождающееся от успеха в овладении знаниями [2].

В работах отечественного ученого В.А. Сластенина определяется главный смысл деятельности педагога – создание каждому воспитаннику ситуации успеха [3].

Задача госпитального педагога – не только учить ребенка своему предмету, а учить его жить в современном мире, чтобы дети не потеряли уверенность в своем будущем и ощущали ритм повседневности, быть готовым жить вне больницы, после больницы. А задача финансовой грамотности как раз заключается в том, чтобы обеспечить детей совокупностью знаний, навыков и установок в сфере финансового поведения, ведущих к улучшению благосостояния и качества жизни.

Внеурочная деятельность создает условия для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей для развития и социализации каждого учащегося. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности, проводимый на основе методики Л.В. Байбородовой психологом Республиканского центра образования показывает высокую степень мотивации обучающихся к изучению финансовой грамотности, что вызвано как использованием игровых технологий, которые обеспечивают единство эмоционального и рационального в обучении, направлены на развитие творчества, инициативности детей, формирование радости, так и возможностью принять участие в конкурсах по финансовой грамотности.

В нашем регионе проводится достаточно много конкурсов по финансовой грамотности, в которых мы успешно принимаем участие. Результативное участие в конкурсах по финансовой грамотности создает ситуацию успеха, вселяет в ребенка веру в себя, способствует преодолению неуспешности в учении.

Литература

1. Шариков, С.В. Педагогическая поддержка образовательных возможностей детей, находящихся на длительном лечении в медицинских стационарах / С.В. Шариков // Альманах Института коррекционной педагогики. – 2020. – № 40. – С. 22-42.
2. Ушинский, К.Д. Труд в его психическом и воспитательном значении. Избранные сочинения / К.Д. Ушинский. — Москва : Издательство Юрайт. —

2025. – 354 с. – URL: <https://urait.ru/book/trud-v-ego-psihicheskom-i-vospitatelnom-znachenii-izbrannye-sochineniya-563186> (Дата обращения 04.09.2025).

3. Слостенин, В.А. Общая педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. В.А. Слостенина: В 2 ч. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС. — 2003. — Ч. 1. — 288 с.

References

1. Sharikov, S.V. Pedagogicheskaya podderzhka obrazovatel'ny'x vozmozhnostej detej, naxodyashhixsya na dlitel'nom lechenii v medicinskix stacionarax / S.V. Sharikov // Al'manax Instituta korrekcionnoj pedagogiki. — 2020. — № 40. — S. 22-42.

2. Ushinskij, K.D. Trud v ego psixicheskom i vospitatel'nom znachenii. Izbranny'e sochineniya / K.D. Ushinskij. — Moskva : Izdatel'stvo Yurajt. — 2025. — 354 s. — URL: <https://urait.ru/book/trud-v-ego-psihicheskom-i-vospitatelnom-znachenii-izbrannye-sochineniya-563186> (Accessed 04.09.2025).

3. Slastenin, V.A. Obshhaya pedagogika: Ucheb. posobie dlya stud. vy'ssh. ucheb. zavedenij / Pod red. V.A. Slastenina: V 2 ch. — M.: Gumanit. izd. centr VLADOS. — 2003. — Ch. 1. — 288 s.

УДК 372.3/.4

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ И ОЛИМПИАДАХ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ГОСПИТАЛЬНОЙ ШКОЛЕ КАК СПОСОБ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

Фролова Светлана Александровна
специализированное структурное подразделение
ГБОУ Школа № 109 «Госпитальная школа «УчимЗнаем»
тьютор
frolova.sa@uchimznaem.ru

PARTICIPATION IN COMPETITIONS AND OLYMPIADS FOR PRESCHOOL CHILDREN IN HOSPITAL SCHOOLS AS A WAY TO SUPPORT CHILDREN'S INITIATIVES

Frolova Svetlana Alexandrovna
specialized structural unit GBOU School № 109
“Hospital school “We Teach/They Learn”
tutor
frolova.sa@uchimznaem.ru

Аннотация: рассматриваются вопросы поддержки инициативы у детей дошкольного возраста, находящихся на длительном лечении в медицинских учреждениях с помощью участия в конкурсах и олимпиадах.

Ключевые слова: госпитальная школа, дошкольный возраст, детская инициатива, преодоление неуспешности.

Abstract. The article examines issues of supporting initiative in preschool children undergoing long-term treatment in medical institutions, and provides ways to overcome failure.

Keywords: hospital school, preschool age, children's initiative, overcoming failure.

Вопросу поддержки инициативы детей сегодня уделяется большое внимание [1]. Прежде всего, это требование Федеральной образовательной программы дошкольного образования. С другой стороны, это требования самих детей, которые все чаще хотят действовать в соответствии со своими интересами. Мы считаем, что участие детей дошкольного возраста в конкурсах и олимпиадах в условиях госпитальной школы является важным инструментом для поддержки их инициативы, а также эмоциональной реабилитации.

Дошкольники, проходящие длительное лечение, зачастую очень долго вынуждены находиться в медицинских стационарах – в таких условиях не только образовательная программа, но и дополнительные мероприятия, такие как конкурсы и олимпиады, играют важную роль. Они помогают детям чувствовать

себя частью привычной жизни, дают возможность взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и представляет собой уникальную возможность не только продемонстрировать свои творческие, интеллектуальные способности, но и поддержать их инициативу, развивать творческий потенциал и комфортно чувствовать себя в условиях, далеких от привычной среды [2, 3].

Участие детей дошкольного возраста в конкурсах и олимпиадах предполагает очень тесную работу непосредственно с педагогом и родителем – на начальном этапе необходимо заинтересовать ребенка, помочь сделать первый шаг, объяснить, что это возможность проявить свои таланты. Далее выстраивается непосредственная работа над проектом (рисунком, подготовкой заданий для конкурса и т.д.).

Для детей, находящихся на длительном лечении важным критерием для выбора конкурса или олимпиады является возможность дистанционного участия, т.к. зачастую у детей нет возможности покидать палату. В данном случае от педагога и ребенка требуется своевременная подготовка и техническое оснащение. В своей практике мы делали выбор в пользу таких конкурсов как: «Я-исследователь», который проводит Московский Педагогический Государственный университет, «Ёлка Победы» от Музея Победы, конкурс детского рисунка Нади Рушевой, Олимпиад от «Учи.ру» и «Образовариум».

Важно отметить, что успехи и достижения детей в конкурсах и олимпиадах не всегда измеряются медалями и дипломами. Часто гораздо важнее сами усилия, старания и проявленная инициатива. Учитывая опыт нашей работы, мы убедились, что ограничения, связанные с нахождением ребенка дошкольного возраста в медицинском стационаре, не является препятствием для участия в олимпиадах и конкурсах, наоборот, это является важным элементом не только образовательного процесса, но и комплексной поддержки детей, позволяя им чувствовать себя успешными и уверенными, несмотря на обстоятельства.

Литература

1. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования», стр. 5. – Режим доступа: – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044> (Дата обращения 28.11.2025).
2. Разъяснения по вопросам организации обучения по основным общеобразовательным и дополнительным общеразвивающим программам для детей, нуждающихся в длительном лечении в медицинских организациях. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации № ТВ-1693/03 и Министерства здравоохранения Российской Федерации № 1/и/2-15398 от 24 августа 2023 г. – URL: https://obrnadzor.gov.ru/ron_doc/razyasneniya-po-voprosam-organizaczii-obucheniya-po-osnovnym-obshheobrazovatelnyim-i-dopolnitelnym-obshherazvivayushhim-programmam-dlya-detej-nuzhdayushhihsya-v-dlitelnom-lechenii-v-mediczinskih-organ/ (Дата обращения 04.09.2025).
3. Шариков, С.В. Педагогическая поддержка образовательных возможностей детей, находящихся на длительном лечении в медицинских

стационарах / С.В. Шариков // Альманах Института коррекционной педагогики. – 2020. – № 40. – С. 22-42.

References

1. Prikaz Ministerstva prosveshheniya Rossijskoj Federacii ot 25.11.2022 № 1028 «Ob utverzhdenii federal'noj obrazovatel'noj programmy` doshkol'nogo obrazovaniya», str. 5. – Rezhim dostupa: – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044> (Accessed 28.11.2025).
2. Raz`yasneniya po voprosam organizacii obucheniya po osnovny`m obshheobrazovatel'ny`m i dopolnitel'ny`m obshherazvivayushhim programmam dlya detej, nuzhdayushhixsya v dlitel'nom lechenii v medicinskix organizacijax. Pis'mo Ministerstva prosveshheniya Rossijskoj Federacii № TV-1693/03 i Ministerstva zdravooxraneniya Rossijskoj Federacii № 1/i/2-15398 ot 24 avgusta 2023 g. – URL: https://obrnadzor.gov.ru/ron_doc/razyasneniya-po-voprosam-organizaczii-obucheniya-po-osnovnym-obshheobrazovatelnyim-i-dopolnitelnym-obshherazvivayushhim-programmam-dlya-detej-nuzhdayushhihsya-v-dlitelnom-lechenii-v-mediczinskih-organ/ (Accessed 04.09.2025).
3. Sharikov, S.V. Pedagogicheskaya podderzhka obrazovatel'ny`x vozmozhnostej detej, naxodyashhixsya na dlitel'nom lechenii v medicinskix stacionarax / S.V. Sharikov // Al'manax Instituta korrekcionnoj pedagogiki. – 2020. – № 40. – С. 22-42.

УДК 372.853

**ОБУЧЕНИЕ ФИЗИКЕ В УСЛОВИЯХ ГОСПИТАЛЬНЫХ ШКОЛ
ЧЕРЕЗ СОВРЕМЕННЫЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ**

Теплякова Ксения Олеговна

ФГБОУ ВО МПГУ

заведующая лабораторией кафедры общей и
экспериментальной физики

ko.teplyakova@mpgu.su

Солдатенкова Мария Дмитриевна

лаборатория квантовых детекторов ФГБОУ ВО МПГУ

ведущий специалист

md.soldatenkova@mpgu.su

Чулкова Галина Меркурьевна

доктор физико-математических наук, профессор

ФГБОУ ВО МПГУ

ФГБОУ ВПО МИЭМ НИУ ВШЭ

профессор

gm.chulkova@mpgu.su

**TEACHING PHYSICS IN HOSPITAL SCHOOLS THROUGH MODERN
HIGH-TECH EXPERIMENTAL TASKS**

Teplyakova Ksenia Olegovna

FGBOU VO MPGU

head of the Laboratory of the Department of General and
Experimental Physics

ko.teplyakova@mpgu.su

Soldatenkova Maria Dmitrievna

FGBOU VO MPGU

leading Specialist

laboratory of Quantum Detectors

md.soldatenkova@mpgu.su

Chulkova Galina Merkurievna

Dr Sci. in Physics and Mathematics

FGBOU VO MPGU

professor

gm.chulkova@mpgu.su

Аннотация. авторами предлагается методическая система обучения физике в госпитальной школе. Методика адаптирована к возможностям и образовательным потребностям детей, проходящих лечение в стационаре, заключается в изучении физики через систему экспериментальных заданий. Такой подход позволяет получать доступ к знаниям о современных достижениях науки и технологий, включаться в исследовательскую и познавательную деятельности даже на длительном лечении.

Ключевые слова: физика, экспериментальные задачи, госпитальная школа.

Abstract. The authors propose a methodological system for teaching physics in a hospital school. The method is adapted to the capabilities and educational needs of children undergoing hospital treatment, and consists of studying physics exclusively through a system of experimental tasks. This approach allows to access knowledge about modern achievements of science and technology, to be involved in research and cognitive activities, even during long-term treatment.

Keywords: physics, experimental problems, hospital school.

Коллектив из педагогов, научных сотрудников и студентов кафедры общей и экспериментальной физики Московского педагогического государственного университета, объединенный в работе просветительского проекта Физическая гостиная, в течение шести лет сотрудничает с проектом «УчимЗнаем» [1]. За эти годы были опробованы разные форматы работы с детьми, проведены десятки фестивалей науки, научных праздников, исследовательских мероприятий.

Есть немало специфики при «переносе» занятий из школьных классов в больничные палаты и в аудитории госпитальной школы УчимЗнаем, важно учитывать самочувствие ребенка, его мотивацию, часто общую слабость, особенности общения ребенка с педагогом. При этом физика, как учебный предмет, обладает огромным потенциалом для развития ребенка и его способностей, является платформой для исследований, открытий и познания, предоставляет возможности проявить себя и, конечно же, получать положительные эмоции. Предлагаемая авторами методическая система обучения физике за прошедший период сотрудничества была адаптирована к возможностям и образовательным потребностям детей, проходящих лечение в стационаре, находящимся в реабилитационных центрах или хосписах.

Изучение физики начинается с системы экспериментальных заданий, имеющих непосредственное отношение к высоким технологиям. Эти задания используют простое оборудование, которое не представляет опасности, его можно дезинфицировать, а иногда даже сами дети могут его изготовить из предоставленных материалов. Процесс выполнения такого задания вызывает интерес и формирует начальные предметные образовательные результаты. Экспериментальные задания построены таким образом, что отражают основные принципы работы современных устройств без потери сути физических процессов, например, передачу информации по линии связи – «интернет своими руками», «изготовление жесткого диска», «экраны телефонов», «характеристики видеокамер».

Дети активно включаются в процесс занятия, проводят своё исследование. Это способствует преодолению трудностей в восприятии материала, активизации познавательной деятельности. Сочетание «занятий по расписанию» (по учебному плану) учителей предметников проекта УчимЗнаем и выездных мероприятий по «новой физике» позволяет детям в госпитальной школе через исследования и эксперименты получать доступ к знаниям о современных достижениях науки и технологий, не считать себя оторванными от школьной учебы и внеклассных мероприятий.

Литература

1. Шариков, С.В. Создание образовательной среды для детей, находящихся на длительном лечении в стационарах медицинских учреждений / С.В. Шариков // Российский журнал детской гематологии и онкологии. – 2015. – №. 4. – С. 65-73.

References

1. Sharikov, S.V. Creating an educational environment for children on long-term treatment in hospitals of medical institutions / S.V. Sharikov // Russian Journal of Pediatric Hematology and Oncology. – 2015. – no. 4. - S. 65-73.

УДК 372.881.111.1

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК КАК ОКНО В МИР: КАК ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ПОМОГАЕТ ДЕТЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ НА ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ, РАСКРЫТЬ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ

Пустохайлова Анастасия Алексеевна
ГКОУ Астраханской области «СОШ № 4»
учитель иностранного языка
pustokhaylova.nastya@mail.ru

ENGLISH AS A WINDOW TO THE WORLD: HOW LEARNING A FOREIGN LANGUAGE HELPS CHILDREN IN LONG-TERM TREATMENT TO REACH THEIR POTENTIAL

Pustokhailova Anastasia Alekseevna
"Secondary School No. 4"
teacher of Foreign Language
pustokhaylova.nastya@mail.ru

Аннотация. Раскрывается потенциал детей, находящихся на длительном лечении, через изучение английского языка. Рассматривается возможность использования английского языка для поддержки и развития детей, находящихся на длительном лечении. Подчеркивается, что в условиях изоляции и эмоционального стресса английский язык может стать для длительно болеющих детей «окном в мир», предоставляя возможности для общения, обучения и творчества.

Ключевые слова: английский язык, дети на длительном лечении, школа «УчимЗнаем», социальная адаптация, психологическое здоровье, онлайн-экскурсии, театральные постановки, волонтеры-носители языка, мотивация, творчество.

Abstract. This article explores the potential of English language learning to support the development of children undergoing long-term medical treatment. It argues that in conditions of isolation and emotional stress, English can serve as a "window to the world" providing these children with vital opportunities for communication, intellectual engagement, and creative expression.

Keywords: english language, children undergoing long-term medical treatment, «We Learn/They Learn» school, social adaptation, psychological health, online excursions, theater productions, native speaker volunteers, motivation, creativity.

В современном глобализированном мире знание английского языка открывает перед человеком бесчисленные возможности. Это язык международного общения, науки, технологий, искусства и культуры. Дети, находящиеся на длительном лечении, часто сталкиваются с изоляцией от

привычной социальной среды, ограничением в физической активности и эмоциональным стрессом [1]. В этих условиях английский язык может стать для них «окном в мир», позволяя общаться с ровесниками из других стран, получать доступ к интересующей их информации, заниматься творчеством и развиваться, несмотря на обстоятельства [2].

Образование играет важную роль в поддержании психологического здоровья и социальной адаптации детей, находящихся на длительном лечении. Оно позволяет им сохранять связь с внешним миром, развивать свои способности и интересы, чувствовать себя частью общества и планировать будущее [3]. Длительное лечение оказывает влияние на психологическое состояние ребенка. Изоляция от сверстников, ограничение в физической активности, боль и дискомфорт, связанные с процедурами, а также постоянный страх и тревога могут приводить к развитию депрессии, возникновению тревоги и других психологических проблем.

В госпитальной школе используется английский язык как инструмент для поддержки детей, находящихся на длительном лечении: онлайн-встречи с волонтерами из других стран, онлайн-экскурсии по музеям и городам мира, театральные постановки. Отметим, что онлайн-встречи с волонтерами из других стран позволяют детям общаться с носителями языка, узнавать о культуре и практиковать свой английский. Для организации используем программу «Meetup».

Выделим важные моменты для организации работы с онлайн-волонтерами: необходимость тщательного отбора и проверки волонтеров: перед тем, как допустить волонтера к работе с детьми, необходимо провести проверку его личности и убедиться в его добропорядочности. Для этого мы выбираем в работу волонтеров, которые подтвердили свою личность, загрузили на сайт фото своих документов, а также, которые имеют высокий рейтинг; модерация мероприятий – учитель или другой ответственный сотрудник школы должен модерировать онлайн-мероприятия, чтобы обеспечить безопасность и комфорт для всех участников; необходимость в обучении учеников правилам онлайн-безопасности (распознавание и избегание опасных ситуаций); согласие родителей – необходимо получить согласие родителей обучающегося перед тем, как привлекать ученика к участию в мероприятиях [4].

Приведем некоторые примеры использования онлайн-встречи с волонтерами в госпитальной школе «УчимЗнаем». Необходима регистрация педагога создание закрытой группы специально для учеников школы. В эту группу приглашаются волонтеры – носители языка, которые готовы проводить онлайн-разговоры и помогать детям с практикой английского. Стоит отметить, что отзывается очень много волонтеров, расспрашивают о школе и хотят поучаствовать в мероприятиях, чтобы поддержать детей и рассказать о своей стране. Также можно создать темы для обсуждения, связанные с интересами детей – фильмы, книги, игры, школьная жизнь и т.д. Такие встречи проводятся 1-2 раза в месяц. Ученики заинтересованы в встречах, готовятся к ним, изучая новую лексику к каждой теме. Конечно, большинство детей по началу

стесняются, замыкаются и боятся говорить, тогда учитель предлагает послушать остальных и уже на следующих встречах они тоже подключаются к разговорам.

Преимущества использования платформы для учеников в госпитальной школе «УчимЗнаем»: **разнообразие** – большой выбор групп и мероприятий позволяет найти что-то интересное каждому ученику; **доступность** – онлайн-формат делает общение с носителями языка доступным для детей, находящихся на длительном лечении; **безопасность** – школа может создавать собственные закрытые группы и обеспечивать безопасность общения для своих учеников; **мотивация** – общение с носителями языка мотивирует учеников к дальнейшему изучению английского; **социализация** – Meetup помогает ученикам преодолеть социальную изоляцию и найти новых друзей по интересам.

Следующий способ, который мы используем в нашей работе с детьми, которые находятся на длительном лечении, для повышения заинтересованности в изучении английского языка и раскрытия их потенциала – это проведение онлайн-экскурсий по музеям и городам мира. Мы организовываем такие мероприятия на английском языке раз в месяц. Дети могут виртуально путешествовать по миру, не выходя из больничной палаты. Приведем сайты, которые можно использовать: Within, Brink Traveler, Google Arts & Culture VR. для полного погружения и реалистичности желательно использовать VR очки. Исходя из темы занятия, учителем подбирается подходящая экскурсия. **Потенциал:** дети узнают об истории древних цивилизаций, знакомятся с артефактами, улучшают навыки аудирования и говорения на английском языке.

Дополнительные активности: после экскурсии учитель обсуждает с детьми наиболее интересные моменты, предлагает выполнить творческие задания (например, нарисовать рисунок по мотивам увиденного или написать небольшое эссе на английском языке).

Онлайн-экскурсии на английском языке являются ценным инструментом для раскрытия потенциала длительно болеющих детей, способствуя развитию когнитивных навыков, социальной адаптации, эмоциональному благополучию и вдохновляя на новые свершения. Яркие впечатления от экскурсии, новые знания и позитивные эмоции помогают отвлечься от неприятных ощущений, снизить уровень стресса и тревоги. Виртуальные экскурсии сопровождаются вопросами, заданиями, обсуждениями, которые стимулируют критическое мышление, анализ информации и творческий подход к решению задач.

Также в своей работе мы развиваем артистический потенциал учеников. Театральные постановки на английском языке: Организация небольших, адаптированных для уровня владения языком, театральных постановок, позволяет детям проявить свои творческие способности и повысить уверенность в использовании языка. Учителями адаптируются сценарии известных сказок и пьес, добавляются интерактивные элементы. Раз в три месяца в госпитальной школе проводятся небольшие постановки, в них принимают участие ученики с разным уровнем владения английским языком.

Отметим основные преимущества театральных постановок на английском языке для учеников, находящихся на длительном лечении. Повышение мотивации к обучению: театральная деятельность, в отличие от

традиционных уроков, предлагает увлекательный и интерактивный способ изучения английского языка. Ученики более мотивированы к изучению новых слов и грамматических конструкций, когда видят их практическое применение в постановке. Возможность проявить себя в творческой деятельности может стать мощным стимулом для учеников, испытывающих трудности в учебе из-за болезни. Развитие языковой компетенции: участие в постановке требует от учеников активного использования английского языка: чтения, говорения, аудирования и письма. Ученики учатся произносить слова правильно, выражать свои мысли четко и уверенно, понимать речь на слух. Театральная деятельность способствует расширению словарного запаса и улучшению грамматики.

Участие в постановках дает возможность ученику, находящемуся на длительном лечении, почувствовать себя частью коллектива, укрепить социальные связи и преодолеть чувство изоляции. Положительные отзывы зрителей и учителей повышают самооценку и мотивацию к дальнейшему развитию [5].

Английский язык – это окно в мир для детей, находящихся на длительном лечении. Он открывает им новые возможности для обучения, общения, самовыражения и развития. Наша задача, как учителей, – помочь им распахнуть это окно настежь и воспользоваться всеми его преимуществами. Важно увидеть в каждом ребенке не просто ученика, а талантливую и целеустремленную личность, способную достичь успеха, несмотря на болезнь. Веря в их потенциал, поддерживая их и предоставляя им необходимые инструменты, мы можем помочь им раскрыть их таланты, реализовать их мечты и стать полноправными членами глобального общества.

Литература

1. Шариков, С.В. Педагогическая поддержка образовательных возможностей детей, находящихся на длительном лечении в медицинских стационарах / С.В. Шариков // Альманах Института коррекционной педагогики. – 2020. – № 40. – С. 22-42.
2. Мамедова, Л.В. Проблема мотивации к изучению английского языка у детей с ограниченными возможностями здоровья / Л.В. Мамедова // Современное педагогическое образование. – 2023. – № 78. – С.1-4.
3. Щур, А.А. Технологии, методы и средства дистанционного обучения английскому языку детей с ограниченными возможностями здоровья / А.А. Щур // Молодой исследователь Дона. – 2023. – № 46. – С.2-3.
4. Sylvester, A. Hospital schools: Why education matters to sick children / A. Sylvester, K. Armstrong // British Journal of School Nursing. – 2018. – № 13(10). – P. 503-507.
5. Романцов, М.Г. Психологические особенности детей дошкольного и младшего школьного возраста, имеющих проблемы со здоровьем / М.Г. Романцов, А.А. Силаев, И.Ю. Мельников // Проблемы современной науки и образования. – 2016. – № 173. – С. 2-4.

References

1. Sharikov, S.V. Pedagogicheskaya podderzhka obrazovatel'ny`x vozmozhnostej detej, naxodyashhixsya na dlitel'nom lechenii v medicinskix stacionarax / S.V. Sharikov // Al'manax Instituta korrekcionnoj pedagogiki. – 2020. – № 40. – S. 22-42.
2. Mamedova, L.V. Problema motivacii k izucheniyu anglijskogo yazy`ka u detej s ogranichenny`mi vozmozhnostyami zdorov`ya / L.V. Mamedova // Sovremennoe pedagogicheskoe obrazovanie. – 2023. – № 78. – S.1-4.
3. Shhur, A.A. Texnologii, metody` i sredstva distancionnogo obucheniya anglijskomu yazy`ku detej s ogranichenny`mi vozmozhnostyami zdorov`ya / A.A. Shhur // Molodoj issledovatel` Dona. – 2023. – № 46. – S.2-3.
4. Sylvester, A. Hospital schools: Why education matters to sick children / A. Sylvester, K. Armstrong // British Journal of School Nursing. – 2018. – № 13(10). – R. 503-507.
5. Romanczov, M.G. Psixologicheskie osobennosti detej doskol'nogo i mladshego shkol'nogo vozrasta, imeyushhix problemy` so zdorov'em / M.G. Romanczov, A.A. Silaev, I.Yu. Mel'nikov // Problemy` sovremennoj nauki i obrazovaniya. – 2016. – № 173. – S. 2-4.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ

УДК 159.99

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ. ПЕРВЫЙ ОПЫТ

Савранский Илья Евгеньевич

структурное подразделение ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха»

«Центр госпитальной педагогики»

педагог-психолог

simonmix08082001@gmail.com

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF CHILDREN AFFECTED BY THE SPECIAL MILITARY OPERATION. THE FIRST EXPERIENCE

Savranskiy Ilya Evgenevich

structural subdivision of the OGAOU OK "Algorithm of Success"

"Center for Hospital Pedagogy"

Educational Psychologist

simonmix08082001@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются особенности психолого-педагогического сопровождения детей, пострадавших в результате специальной военной операции, и первый опыт работы по психолого-педагогическому сопровождению таких детей. Определяются основные задачи сопровождения, роль педагога и психолога, а также методы, способствующие адаптации и восстановлению эмоционального равновесия.

Ключевые слова: дети, сопровождение, специальная военная операция, психологическая поддержка, адаптация, педагог, безопасность.

Abstract. This article examines the features of psychological and pedagogical support for children affected by the Special Military Operation (SMO). It defines the primary objectives, delineates the roles of teachers and psychologists, and identifies methods that facilitate adaptation and emotional recovery.

Keywords: children, support, SMO, psychological assistance, adaptation, pedagogy, safety.

Дети, оказавшиеся в условиях вооружённого конфликта, сталкиваются с тревогой, страхом и нарушением привычной социальной среды [1]. Задача психолого-педагогического сопровождения заключается в создании безопасного пространства, где ребёнок получает эмоциональную поддержку и возможность

адаптироваться. Особое внимание уделяется диагностике психоэмоционального состояния, работе с травматическим опытом и восстановлению познавательной активности [2].

Рассматривается пример работы с тремя разными детьми, ставшими жертвами во время проведения СВО на территории Белгородской области, а также методы и приёмы работы по психолого-педагогическому сопровождению детей. Рассматриваемые формы помощи включают индивидуальные консультации, групповые занятия, творческие и игровые методы, а также взаимодействие с семьёй и педагогическим коллективом [3]. Социализации ребенка в новых для него условиях, после получения травмы и по окончании лечения (выходу из медицинского учреждения). Эффективными являются арт-терапия, сказкотерапия, музыкотерапия и элементы когнитивно-поведенческого подхода, позволяющие снизить тревожность и развить навыки саморегуляции [4]. Роль психолога заключается в диагностике и коррекции, а педагога — в создании атмосферы доверия и поддержке учебной мотивации. Совместная работа специалистов обеспечивает снижение уровня стресса и включение ребёнка в образовательный процесс [5, 6].

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение детей, пострадавших в результате СВО, представляет собой комплексную систему, направленную на их восстановление и успешную социализацию.

Литература

1. Выготский, Л.С. Психология развития ребенка / Л.С. Выготский. — М.: Смысл. — 2004. — 349 с.
2. Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. — М.: Смысл. — 2005. — 326 с.
3. Немов, Р.С. Психология: Учебник для студентов. — М.: Владос. — 2010. — 632 с.
4. Прихожан, А.М. Психология сиротства / А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых. — М.: Академия. — 2005. — 288 с.
5. Фурманов, И.А. Психолого-педагогическая поддержка детей в условиях кризиса / И.А. Фурманов. — СПб.: Речь. — 2012. — 214 с.
6. Шариков, С.В. Педагогическая поддержка образовательных возможностей детей, находящихся на длительном лечении в медицинских стационарах / С.В. Шариков // Альманах Института коррекционной педагогики. — 2020. — № 40. — С. 22-42

References

1. Vy`gotskij, L.S. Psixologiya razvitiya rebenka / L.S. Vy`gotskij. — M.: Smy`sl. — 2004. — 349 s.
2. Leont`ev, A.N. Deyatel`nost`. Soznanie. Lichnost` / A.N. Leont`ev. — M.: Smy`sl. — 2005. — 326 s.
3. Nemov, R.S. Psixologiya: Uchebnik dlya studentov. — M.: Vlados. — 2010. — 632 s.
4. Prixozhan, A.M. Psixologiya sirotstva / A.M. Prixozhan, N.N. Tolsty`x. — M.: Akademiya. — 2005. — 288 s.
5. Furmanov, I.A. Psixologo-pedagogicheskaya podderzhka detej v usloviyax krizisa / I.A. Furmanov. — SPb.: Rech`. — 2012. — 214 s.
6. Sharikov, S.V. Pedagogicheskaya podderzhka obrazovatel`ny`x vozmozhnostej detej, naxodyashhixsy na dlitel`nom lechenii v medicinskix stacionarax / S.V. Sharikov // Al`manax Instituta korrekcionnoj pedagogiki. — 2020. — № 40. — S. 22-42.

УДК 37.047

РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ В ГОСПИТАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Бабенков Николай Дмитриевич

специализированное структурное подразделение
ГБОУ Школа № 109 «Госпитальная школа «УчимЗнаем»
руководитель службы психолого-педагогического сопровождения
тьютор, учитель-дефектолог
babenkov.nd@uchimznaem.ru

Макаров Лев Геннадьевич

специализированное структурное подразделение
ГБОУ Школа № 109 «Госпитальная школа «УчимЗнаем»
социальный педагог
makarov.lg@uchimznaem.ru

THE ROLE OF VOCATIONAL GUIDANCE FOR HIGH SCHOOL STUDENTS IN HOSPITAL SCHOOLS

Babenkov Nikolai Dmitrievich

specialized structural unit GBOU School № 109
“Hospital school “We Teach/They Learn”
Head of Psycho-Pedagogical Counselling Service
tutor, teacher-defectologist
babenkov.nd@uchimznaem.ru

Makarov Lev Gennadyevich

specialized structural unit GBOU School № 109
“Hospital school “We Teach/They Learn”
social educator
makarov.lg@uchimznaem.ru

Аннотация. Рассматривается роль профессиональной ориентации для старшеклассников, находящихся на длительном лечении в медицинских организациях. Приведены примеры и основные подходы к профориентационной деятельности специалистов службы психолого-педагогического и социального сопровождения госпитальной школы.

Ключевые слова: госпитальная педагогика, старше школьники, социальный педагог, служба психолого-педагогического и социального сопровождения.

Abstract. This article examines the role of career guidance for high school students undergoing long-term treatment in healthcare organisations. Examples and key approaches to career guidance provided by specialists in the hospital school's Psycho-Pedagogical and Social Support Service are provided.

Keywords: hospital pedagogy, high school students, social pedagogue, Psycho-Pedagogical and Social Support Service.

Социальная адаптация и профессиональное самоопределение учащихся, находящихся на длительном лечении – важный аспект деятельности социального педагога в госпитальной школе [1]. В ходе диагностики службой психолого-педагогического и социального сопровождения (ППСС) были выявлены у учащихся запросы, связанные с неопределённостью будущего: «Куда можно поступить, если я нахожусь в больнице?», «Я не знаю, куда поступить, раньше я хотел быть спортсменом» и другие. Эти вопросы отражают не только потребность в профориентации, но и эмоциональные трудности, связанные с изменением жизненных планов из-за болезни [2].

Для решения этих задач специалисты службы ППСС госпитальной школы выявили актуальные подходы:

1. Персонифицированное консультирование – помощь в выборе профессии с учётом состояния здоровья, возможностей дистанционного обучения и перспектив реабилитации [3].

2. Профориентационные тренинги – индивидуальные и групповые занятия, направленные на самопознание, поиск альтернативных профессиональных путей (например, переход из спорта в смежные области: тренерскую работу, спортивную журналистику или менеджмент).

3. Использование цифровых ресурсов – знакомство с онлайн-курсами, вузами с дистанционными программами и образовательными проектами для людей с ОВЗ.

4. Кейс-метод – разбор реальных ситуаций совместно с учащимися для поиска практических решений [4, 5].

5. Игровые форматы – виртуальные экскурсии на предприятия, онлайн-встречи с представителями профессий и симуляции рабочих задач.

6. Консультирование законных представителей – поскольку их вовлеченность критически важна для устойчивой мотивации ребенка. Проводятся индивидуальные консультации для семей, где разбираются возможности адаптивного образования, льготы при поступлении и программы социальной поддержки.

Таким образом, опираясь на вышеизложенное, специалистами ППСС было выявлено снижение тревожности у старшеклассников, формирование адаптивного профессионального плана и повышение мотивации к обучению, несмотря на ограничения, связанные с лечением.

Литература

1. Шариков, С.В. Создание образовательной среды для детей, находящихся на длительном лечении в стационарах медицинских учреждений / С.В. Шариков // Российский журнал детской гематологии и онкологии. – 2015. – Т. 2. – № 4. – С. 65-73.
2. Коган, Б.М. Системная оценка нейропсихологических подходов коррекционной работы с детьми с особенностями развития / Б.М. Коган, А.М. Ляпина // Системная психология и социология. – 2022. – № 4 (44). – С. 48-58.
3. Цветкова, Л.С. Актуальные проблемы нейропсихологии детского возраста: учебное пособие. – 2-е издание, исправленное / Л.С. Цветкова. – Москва; Воронеж : Московский психолого-социальный институт. – 2006. – 296 с.
4. Визель, Т.Г. Основы нейропсихологии: учебник для студентов вузов / Т.Г. Визель. - М.: В. Секачев. – 2019. – 264 с.
5. Резапкина, Г.В. Специфика профориентационной работы с подростками, имеющими ограничения по здоровью / Г.В. Резапкина // Инклюзивное образование: теория и практика : сборник материалов международной научно-практической конференции, Орехово-Зуево, 09–10 июня 2016 года. – Орехово-Зуево: Государственный гуманитарно-технологический университет. – 2016. – С. 670-676.

References

1. Sharikov, S.V. Sozdanie obrazovatel'noj sredy` dlya detej, naxodyashhixsya na dlitel`nom lechenii v stacionarax medicinskih uchrezhdenij / S.V. Sharikov // Rossijskij zhurnal detskoj gematologii i onkologii. – 2015. – Т. 2, № 4. – S. 65-73.
2. Kogan, B.M. Sistemnaya ocenka nejropsixologicheskix podxodov korrekcionnoj raboty` s det`mi s osobennostyami razvitiya / B.M. Kogan, A.M. Lyapina // Sistemnaya psixologiya i sociologiya. – 2022. – № 4 (44). – S. 48-58.
3. Czvetkova, L.S. Aktual`ny`e problemy` nejropsixologii detskogo vozrasta: uchebnoe posobie. – 2-e izdanie, ispravlennoe / L.S. Czvetkova. – Moskva; Voronezh : Moskovskij psixologo-social`ny`j institut. – 2006. – 296 s.
4. Vizel`, T.G. Osnovy` nejropsixologii: uchebnik dlya studentov vuzov / T.G. Vizel`. - M.: V. Sekachev. – 2019. – 264 s.
5. Rezapkina, G.V. Specifika proforientacionnoj raboty` s podrostkami, imeyushhimi ograniicheniya po zdorov`yu / G.V. Rezapkina // Inklyuzivnoe obrazovanie: teoriya i praktika : sbornik materialov mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii, Orexovo-Zuevo, 09–10 iyunya 2016 goda. – Orexovo-Zuevo: Gosudarstvenny`j gumanitarno-texnologicheskij universitet. – 2016. – S. 670-676.

УДК 37.047

**ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЗРОСЛЯНДИЮ: ИГРОВАЯ РАЗВИВАЮЩАЯ
СРЕДА ДЛЯ РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ
(МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ)**

Киреева Айгуль Альбертовна

АНО «Центр научных исследований в сфере
профориентации и психологии труда»
руководитель экспериментальных площадок
aigul@navigatum.ru

Макаров Лев Геннадьевич

специализированное структурное подразделение ГБОУ Школа № 109
«Госпитальная школа «УчимЗнаем»
социальный педагог
makarov.lg@uchimznaem.ru

Макарова Маргарита Федоровна

специализированное структурное подразделение ГБОУ Школа № 109
«Госпитальная школа «УчимЗнаем»
социальный педагог
makarova.mf@uchimznaem.ru

**JOURNEY TO ADULTHOOD: A GAME-BASED DEVELOPMENTAL
ENVIRONMENT FOR EARLY CAREER GUIDANCE
(METHODOLOGICAL FOUNDATIONS AND TOOLS)**

Kireeva Aigul Albertovna

ANO "Center for scientific
research in the field of career
guidance and labor psychology"
head of experimental sites
aigul@navigatum.ru

Makarov Lev Gennadyevich

specialized structural unit GBOU School № 109
“Hospital school “We Teach/They Learn”
social educator
makarovlev5@gmail.com

Makarova Margarita Fedorovna

specialized structural unit GBOU School № 109
“Hospital school “We Teach/They Learn”
social educator
makarovamargarita2018@gmail.com

Аннотация. Рассматриваются понятия «своевременная профориентация» и «ранняя профориентация». Представлены методологические основы ранней профессиональной ориентации в госпитальной школе, методика и инструментарий создания и использования игровой развивающей среды.

Ключевые слова: своевременная профориентация, ранняя профориентация, игровая развивающая среда, госпитальная школа.

Abstract. The article examines the concepts of "timely career guidance" and "early career guidance". It presents the methodological foundations of early career guidance in hospital schools, along with methods and tools for creating and using a game-based developmental environment.

Keywords: timely career guidance, early career guidance, game-based development environment, hospital school.

С какого возраста начинается самоопределение личности? Когда нужно начинать профессиональную ориентацию ребенка? Как правило, профессиональное самоопределение происходит в подростковом возрасте. Однако, как показала практика, большинство подростков не готовы к самостоятельному и осознанному выбору профессии [1, 2, 3].

Основой самоопределения являются жизненные ценности, которые формируются в дошкольном и младшем школьном возрасте. В этом возрасте закладывается фундамент для построения адекватной, взаимосвязанной картины мира, воспитываются качества, необходимые для личностного и профессионального самоопределения. Осознанному и самостоятельному выбору профессии в подростковом возрасте способствует ранняя профессиональная ориентация. Своевременная профессиональная ориентация формирует готовность к самостоятельному и осознанному выбору профессии [4].

Перед нами стояла непростая задача: подобрать методики и инструментарий, отвечающие возрастным особенностям детей, находящихся на длительном лечении, их особым образовательным потребностям и возможностям, отвечающие целям и задачам системной профориентации [5]. Необходимо отметить, что опыт практической деятельности показывает, что не каждая методика профориентации, тем более ранней, применима в госпитальной школе.

Практическим и методическим инструментом ранней профориентации стала игровая развивающая среда «Навигатум: Взросляндия. В мире профессий», позволяющая представить целостное описание мира труда и профессий, заложить фундамент для построения адекватной, взаимосвязанной, целостной картины мира, сформировать базовые ценности личности, необходимые для личностного самоопределения подростков.

Сценарии игр и занятий, представленные в методических рекомендациях специалистов Навигатума, были адаптированы педагогами проекта госпитальных школ «УчимЗнаем» под особенности учащихся, находящихся на длительном лечении в стационарах медицинских учреждений, и условия образовательной среды госпитальной школы.

В госпитальной школе проекта «УчимЗнаем» на базе реабилитационного центра – ФДРЦ «Кораблик» РДКБ Минздрава России – создана игровая развивающая среда для ранней профориентации с использованием напольной игровой площадки «Карта отраслей и видов деятельности: Взросляндия». Карта состоит из пазлов, которые можно собирать на полу. На собранной карте можно прыгать, скакать, путешествовать по карте игрушками, фигурками персонажей сказок Взросляндии, изготовленными социальным партнером проекта «УчимЗнаем» – студентами колледжа креативных индустрий им. Л.Б. Красина, рассматривать тысячи различных объектов, формирующих целостную картину мира об отраслях и профессиях.

Игровая развивающая среда включает в себя не только игровую напольную площадку с картой отраслей и различных видов деятельности, но и отраслевые профисказки «Приключения Бабахина и его друзей», в которых в формате сказки раскрывается функционал профессий, их взаимосвязь, указываются атрибуты труда, позволяющие отличать и узнавать профессии через интерактивное чтение – живое общение между педагогом и детьми, аудиокнига профисказок, озвученная профессиональными актерами и включающая в себя музыкальное оформление, – самый настоящий аудиоспектакль; иллюстративный материал по каждой отрасли, большой набор сюжетно-ролевых игр, мультфильмов о профессиях (анимационный сериал «Приключения Бабахина и его друзей»).

Сценарии занятий предусматривают активную игровую деятельность, в основе которой – познание окружающего мира. Игровая деятельность направлена на зарождение искреннего интереса к исследовательской деятельности. Профисказка – история об одной конкретной отрасли – разворачивается на страницах книги «Приключения Бабахина и его друзей», в тематических мультфильмах, начинаясь с вопроса «Откуда берется...?», и продолжается на просторах страны Взросляндия, напольной карте, сложенной из пазлов, в сюжетно-ролевой игре о различных отраслях и профессиях. Откуда берется каша, как построить дом, кто такие инженеры, как создаются машины, как работает транспорт, как добывают нефть и газ и многое другое можно узнать, путешествуя по Взросляндии с педагогами госпитальной школы, а также примерить на себя ту или иную профессию, поиграть в нее, узнать секреты профессии и даже сочинить свою собственную сказку.

Так, например, узнав, откуда берется электричество, учащиеся знакомятся с такой важной и нужной отраслью, как энергетика, профессиями, связанными с электричеством, с тем, какие бывают электростанции, разыскивают эти на карте Взросляндии и даже сами вырабатывают электричество. При этом узнают о правилах безопасности при работе с электричеством, приборах, которые измеряют напряжение электрического тока, о мерах пожарной безопасности при использовании электроприборов. И сопровождают их персонажи сказок, с которыми можно играть, харизматичные и невероятно интересные, очень похожие по характерам на самих ребят – учеников госпитальной школы.

Инструментарий и методики игровой развивающей среды «Навигатум: Взросляндия. В мире профессий», учебно-методические комплексы Г.В. Резапкиной, одного из методологов и создателей проекта «Навигатум» [6],

позволяют педагогам госпитальной школы в рамках программ внеурочной деятельности создавать различные сценарии занятий и игр, учитывающие индивидуальные особенности и образовательные потребности учащихся, гибко реагировать на меняющиеся условия, учитывая цели и задачи ранней (своевременной) профориентации, являющейся фундаментом построения системной профориентации в целом и профессионального самоопределения в подростковом возрасте.

Литература

1. Антонова, М.В. Знакомимся с профессиями: рабочая тетрадь для 1 класса общеобразовательных организаций / М.В. Антонова. – М.: ООО «Русское слово – учебник». – 2022. – 64 с.
2. Резапкина, Г.В. Знакомство с миром профессий. Программа курса профессионального самоопределения школьников. 1–4 классы / Г.В. Резапкина, О.А. Роут. – М.: ООО «Русское слово – учебник». – 2023. – 40 с.
3. Резапкина, Г.В. Знакомство с миром профессий: методические рекомендации для проведения занятий во 2 классе общеобразовательных организаций / Г.В. Резапкина. – М.: ООО «Русское слово – учебник». – 2023. – 112 с.
4. Смирнов, А.Ю. Воспитание и самоопределение в проекте Г.В. Резапкиной «Грани личности». – URL: https://vk.com/video-91012841_456239095 (Дата обращения 15.09.2025).
5. Шариков, С.В. Педагогическая поддержка образовательных возможностей детей, находящихся на длительном лечении в медицинских стационарах / С.В. Шариков // Альманах Института коррекционной педагогики. – 2020. – № 40. – С. 22-42.
6. Образовательный и научно-исследовательский проект «Навигатум»: официальный сайт. – URL: <https://navigatum.ru/irs> (Дата обращения 16.09.2025).

References

1. Antonova, M.V. Znakomimsya s professiyami: rabochaya tetrad' dlya 1 klassa obshcheobrazovatel'nyh organizacij / M.V. Antonova. – M.: ООО «Russkoe slovo – учебник». – 2022. – 64 s.
2. Rezapkina, G.V. Znakomstvo s mirom professij. Programma kursa professional'nogo samoopredeleniya shkol'nikov. 1–4 klassy / G.V. Rezapkina, O.A. Rout. – M.: ООО «Russkoe slovo – учебник». – 2023. – 40 s.
3. Rezapkina, G.V. Znakomstvo s mirom professij: metodicheskie rekomendacii dlya provedeniya zanyatij vo 2 klasse obshcheobrazovatel'nyh organizacij / G.V. Rezapkina. – M.: ООО «Russkoe slovo – учебник». – 2023. – 112 s.
4. Smirnov, A.YU. Vospitanie i samoopredelenie v proekte G.V. Rezapkinoy «Grani lichnosti». – URL: https://vk.com/video-91012841_456239095 (Accessed 15.09.2025).
5. Sharikov, S.V. Pedagogicheskaya podderzhka obrazovatel'ny'x vozmozhnostej detej, naxodyashhixsya na dlitel'nom lechenii v medicinskix stacionarax / S.V. Sharikov // Al'manax Instituta korrekcionnoj pedagogiki. – 2020. – № 40. – S. 22-42.
6. Obrazovatel'nyj i nauchno-issledovatel'skij proekt «Navigatum»: oficial'nyj sajт. – URL: <https://navigatum.ru/irs> (Accessed 16.09.2025).

УДК 159.93

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ НА ЗАНЯТИЯХ В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ

Адамян Арег Грайрович

специализированное структурное подразделение
ГБОУ Школа № 109 «Госпитальная школа «УчимЗнаем»
педагог-психолог
ag.adamyan2019@gmail.com

THE ALTERNATIVE AND ADDITIONAL COMMUNICATION IN CLASSES AT A REHABILITATION CENTER

Adamyan Areg Grayrovich

specialized structural unit GBOU School № 109
“Hospital school “We Teach/They Learn”
psychologist
ag.adamyan2019@gmail.com

Аннотация. В работе рассматриваются теоретические аспекты применения технологий альтернативной и дополнительной коммуникации (АДК) в комплексной реабилитации детей с выраженными нарушениями экспрессивной и импрессивной речи. Описываются варианты использования средств АДК в целях компенсации утраченных функций детьми, проходящими длительное лечение в реабилитационном центре.

Ключевые слова: альтернативная и дополнительная коммуникация (АДК), реабилитация, абилитация, дети с коммуникативными нарушениями.

Abstract. This report examines the theoretical aspects of using alternative and additional communication (AAC) methods in the comprehensive rehabilitation of children with severe expressive and receptive speech disorders. The report also describes different ways of using AAC tools that allow children undergoing long-term treatment in a rehabilitation center to compensate for their lost speech functions.

Keywords: alternative and additional communication (AAC), rehabilitation, habilitation, children with communication disorders.

В реабилитационный центр поступают дети с ограниченными возможностями здоровья, проходящие восстановление утраченных функций и абилитацию. Зачастую у таких детей проявляются проблемы с коммуникацией, характеризующиеся нарушением или недостаточной сформированностью экспрессивной и импрессивной речи, что формирует особый запрос для работы педагога с специалистом службы психолого-педагогического сопровождения госпитальной школы.

Альтернативная и дополнительная коммуникация (АДК) — это общий термин для обозначения подходов и стратегий, которые позволяют детям с коммуникативными нарушениями сообщать о своих потребностях, мыслях и эмоциях. Альтернативная коммуникация замещает устную речь у людей с полным отсутствием вербальных средств общения, а дополнительная коммуникация используется совместно с вербальной речью [1].

Пользователями АДК могут быть дети и подростки с нарушениями слуха, двигательными и интеллектуальными нарушениями, аутизмом, синдромом Дауна, нарушениями речевого развития, приобретенными нарушениями (например, при последствиях инсульта или черепно-мозговых травм).

Средства АДК подразделяются на следующие категории [1, 2, 3, 4, 5]:

- Низкотехнологичные (это всё, что не требует использования специальных технических средств);
- Среднетехнологичные (это простые устройства с батареей, которые позволяют записать и воспроизвести сообщения);
- Высокотехнологичные (устройства, разработанные исключительно как средства коммуникации, а также стационарные компьютеры, планшеты и телефоны, в которые устанавливается дополнительное программное обеспечение).

Подбор средств АДК и стратегии ее введения всегда индивидуальны и опираются на характер имеющихся нарушений. Одним из низкотехнологичных средств АДК является коммуникативная система обмена изображениями (карточками) «PECS». Главная задача – научить ребенка начинать общение по собственной инициативе. Используется, в основном, для детей с аутизмом.

Коммуникативные кнопки представляют собой среднетехнологичные средства, позволяющие неговорящим детям выражать свои мысли, озвучивая заранее записанные сообщения (до 30 секунд) простым нажатием. Применяются при работе с детьми разных нозологий, в частности, у которых возникают трудности захвата карточек и отмечается неспособность воспроизвести жесты.

Айтрекинг – высокотехнологичное средство, которое фиксирует движение глаз человека, тем самым позволяя ему управлять компьютером. Применяется при работе с детьми с ТМНР, с параличами (например, после травмы шеи или ДТП). Технология необходима для людей с тяжелыми двигательными нарушениями, когда отсутствует возможность указать жестом, рукой или использовать другие методы АДК (жесты, карточки PECS). Это дети с ДЦП, последствиями травм спинного мозга, аутизмом, интеллектуальными и другими нарушениями.

Таким образом, средства альтернативной и дополнительной коммуникации представляют собой широкий и дифференцированный спектр инструментов для преодоления коммуникативных барьеров у детей с различными формами нарушений развития. АДК позволяет выстраивать индивидуальные траектории реабилитации, обеспечивая каждому ребенку возможность выражения потребностей, мыслей и эмоций, что является фундаментом для его дальнейшей социальной интеграции и личностного развития [6].

Литература

1. Защирина О. В., Белимова П. А. Особенности альтернативной и дополнительной коммуникации в образовательном процессе школьников с нарушением интеллектуального развития // СибСкрипт. – 2025. – Т. 27. – №. 2 (38). – С. 345-361.
2. Рыскина Л. В. Альтернативная коммуникация. Технологии невербальной коммуникации. Информационно-методические материалы //СПб.: СПб ГБУ «Городской информационно-методический центр «Семья». – 2018. – 28 с.
3. Тверская О. Н., Щепелина М. А. Альтернативная и дополнительная коммуникация: сборник методических материалов семинара в рамках образовательного форума «Современные подходы и технологии сопровождения детей с особыми образовательными потребностями» // Пермь: Изд-во ПГГПУ. – 2018. – 160 с.
4. Течнер С., Мартинсен Х. Введение в альтернативную и дополнительную коммуникацию: жесты и графические символы для людей с двигательными и интеллектуальными нарушениями, а также расстройствами аутистического спектра – М.: Теревинф. – 2015. – 432 с.
5. Штягинова Е. А. Альтернативная коммуникация: методический сборник // Городская общественная организация инвалидов «Общество «Даун-синдром». Новосибирск. – 2012. – 31 с.
6. Шариков, С.В. Педагогическая поддержка образовательных возможностей детей, находящихся на длительном лечении в медицинских стационарах / С.В. Шариков // Альманах Института коррекционной педагогики. – 2020. – № 40. – С. 22-42.

References

1. Zashhirinskaya O. V., Belimova P. A. Osobennosti al'ternativnoj i dopolnitel'noj kommunikacii v obrazovatel'nom processe shkol'nikov s narusheniem intellektual'nogo razvitiya // SibSkript. – 2025. – T. 27. – №. 2 (38). – S. 345-361.
2. Ry'skina L. V. Al'ternativnaya kommunikaciya. Teknologii neverbal'noj kommunikacii. Informacionno-metodicheskie materialy' //SPb.: SPb GBU «Gorodskoj informacionno-metodicheskij centr «Sem`ya». – 2018. – 28 s.
3. Tverskaya O. N., Shhepelina M. A. Al'ternativnaya i dopolnitel'naya kommunikaciya: sbornik metodicheskix materialov seminar v ramkax obrazovatel'nogo foruma «Sovremenny'e podxody' i texnologii soprovozhdeniya detej s osoby'mi obrazovatel'ny'mi potrebnostyami» // Perm': Izd-vo PGGPU. – 2018. – 160 s.
4. Techner S., Martinsen X. Vvedenie v al'ternativnuyu i dopolnitel'nuyu kommunikaciju: zhesty' i graficheskie simvoly' dlya lyudej s dvigatel'ny'mi i intellektual'ny'mi narusheniyami, a takzhe rasstrojstvami autisticheskogo spektra – M.: Terevinf. – 2015. – 432 s.
5. Shtyaginova E. A. Al'ternativnaya kommunikaciya: metodicheskij sbornik // Gorodskaya obshhestvennaya organizaciya invalidov «Obshhestvo «Daun-sindrom». Novosibirsk. – 2012. – 31 s.
6. Sharikov, S.V. Pedagogicheskaya podderzhka obrazovatel'ny'x vozmozhnostej detej, naxodyashhixsya na dlitel'nom lechenii v medicinskix stacionarax / S.V. Sharikov // Al'manax Instituta korrekcionnoj pedagogiki. – 2020. – № 40. – S. 22-42.

УДК 159.93

НЕЙРОИГРЫ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА В ГОСПИТАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Бабенкова Екатерина Николаевна

специализированное структурное подразделение
ГБОУ Школа № 109 «Госпитальная школа «УчимЗнаем»
тьютор, учитель-логопед, учитель-дефектолог
babenkova.en@uchimznaem.ru

Ковалева Наталья Николаевна

специализированное структурное подразделение
ГБОУ Школа № 109 «Госпитальная школа «УчимЗнаем»
тьютор, учитель-логопед
kovaleva.nn@uchimznaem.ru

NEUROGAMES IN SPEECH THERAPIST'S WORK IN HOSPITAL SCHOOLS

Babenkova Ekaterina Nikolaevna

specialized structural unit GBOU School № 109
“Hospital school “We Teach/They Learn”
tutor, speech therapist, teacher-defectologist
babenkova.en@uchimznaem.ru

Kovaleva Natalia Nikolaevna

specialized structural unit GBOU School № 109
“Hospital school “We Teach/They Learn”
tutor, speech therapist
kovaleva.nn@uchimznaem.ru

Аннотация. В статье рассматриваются нейропсихологические методы и приемы в работе службы психолого-педагогического и социального сопровождения с детьми, находящимися на длительном лечении. Представлены адаптированные упражнения и задания на коррекцию специфических нарушения высших психических функций, нарушений письменной и устной речи. Приведены примеры дидактических материалов, адаптированных под возрастные особенности детей.

Ключевые слова: нейропластичность, нейропсихологические игры, нейродинамика, госпитальная школа, госпитальная педагогика, усталость, переутомление, адаптированные задания, мотивация к обучению, коррекция устной и письменной речи, коррекция высших психических функций.

Abstract. The article focuses on neuropsychological methods and techniques used by the Psycho-Pedagogical and Social Support Service for children undergoing long-term treatment. The article also presents adapted exercises and tasks aimed at correcting specific impairments of higher mental functions and disorders of written and oral speech. Examples of didactic materials adapted to the age characteristics of children are provided.

Keywords: Neuroplasticity, neuropsychological games, neurodynamics, hospital school, hospital pedagogy, fatigue, burnout, adapted assignments, motivation for learning, correction of spoken and written speech, correction of higher mental functions.

В практике специалистов службы психолого-педагогического и социального сопровождения идет постоянный поиск новых форм и методов работы с детьми, находящимися на длительном лечении. Поэтому для учителя-логопеда накопление и адаптация подходов в коррекционной работе является важным направлением [1].

В ходе диагностики детей с онкологическими заболеваниями, получившими травму головного мозга, с почечной недостаточностью и дети, пострадавшие в результате военных операций, были выявлены трудности фонематического восприятия, усвоения языкового анализа и синтеза, оптико-пространственных представлений, лексико-грамматического строя речи, когнитивных процессов и низкой мотивации к обучению, связано с переутомлением от лечения, как следствие, ослабевает нейродинамика.

Специалисты службы психолого-педагогического и социального сопровождения в госпитальной школе осуществляют свою деятельность в рамках общепризнанных подходов. Визель Т.Г. разработала приемы и методы восстановительного обучения, учитывая пластичность мозга. А также, подчеркивает, что активное применение игр может приводить к нейропластичности – способности мозга адаптироваться и изменяться в ответ на обучение [2]. Специалисты в области нейропсихологии отмечают, что методы нейропсихологического воздействия эффективны в реабилитации: упражнения применяются для восстановления после травм или заболеваний, а использование игровых элементов приносят удовольствие обучающимся и способствуют взаимодействию и развитию социальных навыков, побуждающие к обучению [3].

Обобщая опыт службы психолого-педагогического и социального сопровождения в госпитальной школе, нами были подобраны и адаптированы нейроупражнения и игры для улучшения качества на коррекционных занятиях учителя - логопеда.

Был выбран специальный инструментарий, который необходим для занятий и, в тоже время, разрешен в медицинском стационаре: упражнения с предметами (мячами, карандашами, стаканчиками и т.д.), нейромоторные упражнения, а также накопленный материал в письменной и электронной форме (нейропрописи, словесные головоломки, нейро-ритмические упражнения, двуручное рисование, хитрые тексты), адаптированные под условия нахождения в больнице.

Важно отметить, что задания имеют разный уровень сложности, что позволяет планировать занятия, ориентируясь на индивидуальные особенности и уровень развития каждого ученика.

Нейроупражнения помогают улучшить восприятие информации, повысить концентрацию внимания и памяти. Увеличить пластичность мозга и помочь детям адаптироваться к новым условиям. Ребенок становится увереннее. Элементы нейроупражнений на уроках в виде разминок улучшают координацию мелкой и крупной моторики. А помогает детям на длительном лечении «научиться учиться» и сформировать учебную мотивацию, скорректировать слабые стороны и при необходимости закрепить сильные. Взаимодействие педагога и ребенка помогает социализироваться с учетом сложившейся ситуации [4].

Литература

1. Бабенков, Н.Д. Специфика работы учителя-логопеда в госпитальной школе / Н.Д. Бабенков, И.Ю. Долуев, С.Н. Сорокоумова // Актуализация ресурсного потенциала семьи и ребенка с ограниченными возможностями здоровья в образовательном и социокультурном пространстве: Сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции, Нижний Новгород, 12 ноября 2024 года. – Нижний Новгород: ИП Гладкова О.В. – 2024. – С. 19-23.
2. Визель, Т.Г. Основы нейропсихологии: учебник для студентов вузов / Т.Г. Визель. – М.: В. Секачев. – 2019. – С. 264.
3. Цветкова, Л.С. Актуальные проблемы нейропсихологии детского возраста: учебное пособие / Л.С. Цветкова. – 2-е издание, исправленное. Москва, Воронеж: Московский психолого-социальный институт. – 2006. – С. 296.
4. Шариков, С.В. Педагогическая поддержка образовательных возможностей детей, находящихся на длительном лечении в медицинских стационарах / С.В. Шариков // Альманах Института коррекционной педагогики. – 2020. – № 40. – С. 22-42.

References

1. Babenkov, N.D. Specifika raboty` uchitelya-logopeda v gospital`noj shkole / N.D. Babenkov, I.Yu. Doluev, S.N. Sorokoumova // Aktualizaciya resursnogo potenciala sem'i i rebenka s ogranichenny`mi vozmozhnostyami zdorov`ya v obrazovatel`nom i sociokul`turnom prostranstve: Sbornik statej po materialam Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii, Nizhnij Novgorod, 12 noyabrya 2024 goda. – Nizhnij Novgorod: IP Gladkova O.V. – 2024. – S. 19-23.
2. Vizel`, T.G. Osnovy` nejropsixologii: uchebnyk dlya studentov vuzov / T.G. Vizel`. – M.: V. Sekachev. – 2019. – S. 264.
3. Czvetkova, L.S. Aktual`ny`e problemy` nejropsixologii detskogo vozrasta: uchebnoe posobie / L.S. Czvetkova. – 2-e izdanie, ispravlennoe. Moskva, Voronezh: Moskovskij psixologo-social`ny`j institut. – 2006. – S. 296.
4. Sharikov, S.V. Pedagogicheskaya podderzhka obrazovatel`ny`x vozmozhnostej detej, naxodyashhixsya na dlitel`nom lechenii v medicinskix stacionarax / S.V. Sharikov // Al`manax Instituta korrekcionnoj pedagogiki. – 2020. – № 40. – S. 22-42.

УДК 372.3/.4

АКАДЕМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Фёдоров Андрей Владимирович

специализированное структурное подразделение
ГБОУ Школа № 109 «Госпитальная школа «УчимЗнаем»
заведующий учебной частью
fedorov.av@uchimznaem.ru

Шиблева Ирина Эдуардовна

специализированное структурное подразделение
ГБОУ Школа № 109 «Госпитальная школа «УчимЗнаем»
тьютор
shibleva.ie@uchimznaem.ru

ACADEMIC AND SOCIAL REHABILITATION OF PRESCHOOL CHILDREN

Fedorov Andrei Vladimirovich

specialized structural unit GBOU School № 109
“Hospital school “We Teach/They Learn”
Head of the teaching department at Children Federal
Rehabilitation Centre of Russian Children Clinical Hospital
fedorov.av@uchimznaem.ru

Shibleva Irina Eduardovna

specialized structural unit GBOU School № 109
“Hospital school “We Teach/They Learn”
tutor
shibleva.ie@uchimznaem.ru

Аннотация. В статье представлен опыт проведения групповых занятий с детьми дошкольного возраста в условиях госпитальной школы реабилитационного центра, способствующих формированию социальных умений и навыков взаимодействия со сверстниками и взрослыми.

Ключевые слова: дошкольный возраст, социализация, групповые занятия, образовательная среда.

Abstract. This article presents the experience of conducting group classes with preschool children in a rehabilitation center's hospital school. These classes are shown to contribute to the development of social skills and effective interaction with both peers and adults.

Keywords: preschool age, socialization, group activities, educational environment.

Федеральная образовательная программа дошкольного образования обеспечивает реализацию основной цели — создание условий для гармоничного развития личности ребенка, формирования его коммуникативных умений и навыков взаимодействия со взрослыми и сверстниками [1].

Педагог дошкольного образования, организует особую образовательную среду дошкольного детства в условиях медицинского стационара для реализации общей для всей Российской Федерации цели дошкольного образования [2], и включает детей данной категории в систему непрерывного обучения, общее образовательное поле со сверстниками, обеспечивая реализацию принципа преемственности с начальным школьным образованием. В образовательной среде школ Проекта «УчимЗнаем» созданы оптимальные условия для развития ребёнка, формирующие стимулы к выздоровлению, предоставляющие возможность успешной социализации.

«Групповая деятельность создаёт уникальные условия для формирования социального опыта ребёнка: через игру он учится договариваться, делиться и сопереживать» [3]. Регулярное участие в групповой работе позволяет ребенку, постепенно формировать и укреплять социальные навыки. Задача педагога подготовиться к проведению группового занятия с учётом индивидуальных особенностей детей, посетивших данное занятие. В реабилитационном центре одновременно проходят реабилитацию дети с нейро-, онко-, соматическими и ортопедическими заболеваниями. В одной группе на занятии могут оказаться ребята с самым широким спектром нозологий и особенностей. Поэтому перед занятием необходимо убедиться, что каждому ребёнку будет удобно и комфортно работать, независимо от его особенностей. Для этого образовательная среда легко трансформируется (если ребёнок в коляске – столик регулируется по высоте, ведущая рука левая – ножницы для левшей, ребёнок может работать только на коленях у мамы – портативный регулируемый столик). Только после тщательной подготовки, анализа индивидуальных особых потребностей, консультации с медицинскими работниками и педагогами-психологами педагог начинает занятие с ребенком, находящимся на реабилитации.

Литература

1. Федеральная образовательная программа [Электронный ресурс]: утв. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2023 г. № 1028 – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044> (Дата обращения 07.12.2025).
2. Веракса, Н.Е. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э.М. Дорофеева. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. – 2020. – 368 с.
3. Шариков, С.В. Социальное развитие детей в условиях летнего оздоровительного лагеря / С.В. Шариков // Народная асвета. – 2013. – № 4. – С. 63–65.

References

1. Federal'naya obrazovatel'naya programma [E'lektronny'j resurs]: utv. Prikazom Ministerstva prosveshheniya Rossijskoj Federacii ot 25 noyabrya 2023 g. №1028 – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044> (Accessed 07.12.2025).
2. Veraksa, N.E. Ot rozhdeniya do shkoly'. Innovacionnaya programma doshkol'nogo obrazovaniya / N.E. Veraksa, T.S. Komarova, E'.M. Dorofeeva. – 6-e izd., dop. – M.: MOZAIKA-SINTEZ. – 2020. – 368 s.
3. Sharikov, S.V. Social'noe razvitie detej v usloviyax letnego ozdorovitel'nogo lagerya / S.V. Sharikov // Narodnaya asveta. – 2013. – № 4. – S. 63–65.

ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ГОСПИТАЛЬНЫХ ШКОЛ

УДК 371.14

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ГОСПИТАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ: СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ

Зык Александр Николаевич

аспирант государственного учреждения образования
«Академия образования»
zyk@minsk.edu.by
Республика Беларусь

FORMATION AND DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCIES OF HOSPITAL TEACHERS: MODERN EDUCATIONAL APPROACHES

Zyk Alexander Nikolaevich,

Postgraduate Student
State Educational Institution «Academy of Education»
zyk@minsk.edu.by
Republic of Belarus

Аннотация. В условиях трансформации системы образования и здравоохранения особую актуальность приобретает развитие госпитальной педагогики – направления, ориентированного на обучение и психолого-педагогическое сопровождение детей, находящихся на длительном лечении в организациях здравоохранения и на дому. Современные вызовы требуют переосмысления традиционных подходов к подготовке специалистов образования, способных работать в условиях ограниченных ресурсов, межведомственных и мультипрофессиональных команд и высокой эмоциональной нагрузки. В данной публикации рассматриваются современные подходы подготовки госпитальных педагогов.

Ключевые слова: госпитальная педагогика, госпитальный педагог, образование в условиях организации здравоохранения, психолого-педагогическое сопровождение, дети с особыми образовательными потребностями, инклюзивное обучение.

Abstract. Against the backdrop of transformation of the education and healthcare systems, the development of hospital pedagogy – a field focused on the education and psychological, pedagogical and social support of children undergoing long-term treatment in healthcare facilities and at home – is becoming particularly relevant. Modern challenges require a rethinking of traditional approaches to training educational specialists capable of working in resource-constrained settings, within interdepartmental and multiprofessional teams, and under high emotional stress. This publication examines modern approaches to training hospital teachers.

Keywords: hospital pedagogy, hospital teachers, education in healthcare settings, psychological and pedagogical support, children with special educational needs, inclusive education.

Госпитальная педагогика представляет собой специализированное направление педагогической науки и практики, ориентированное на обеспечение непрерывного образования и психолого-педагогического сопровождения детей, находящихся на длительном лечении в медицинских учреждениях [1]. Госпитальная школа, центральное понятие госпитальной педагогики, – это учреждение образования, которое обеспечивает освоение содержания образовательных программ общего среднего образования детям, которым оказывается медицинская помощь в стационарных условиях в организациях здравоохранения [2]. В соответствии со статьёй 153 Кодекса Республики Беларусь об образовании обучение и воспитание учащихся в организации здравоохранения организуются учреждением образования по месту нахождения организации здравоохранения [3]. Госпитальные педагоги – это педагогические работники, осуществляющие образовательный процесс в условиях организаций здравоохранения (больницы, реабилитационные центры, РНПЦ), что определяет особенности профессиональной деятельности. Их работа направлена на обеспечение непрерывного образования детей, находящихся на длительном лечении, с учетом их физического и психологического состояния. Однако, на практике нередко для учащихся, которые по медицинским показаниям временно или постоянно не могут посещать учреждения образования, создаются условия для освоения содержания образовательных программ общего среднего образования на дому [3, статья 152]. Образовательный процесс для освоения такими учащимся содержания соответствующей образовательной программы на дому организуется педагогическими работниками государственного учреждения образования по месту жительства (месту пребывания) учащегося. Схожесть специфики их профессиональной деятельности дает достаточные основания для отнесения педагогических кадров, обеспечивающих «надомное» обучение, к категории «госпитальных педагогов».

Госпитальный педагог – это уникальный транспрофессиональный специалист, который сочетает педагогические, психологические и медицинские знания [4]. Его работа требует гибкости, чуткости и умения адаптировать образовательный процесс под особые условия. Главная цель его работы – не просто дать знания, но и помочь ребенку сохранить мотивацию к учебе, несмотря на болезнь, и успешно вернуться в обычную школу после лечения или

реабилитации. Анализ современных тенденций в подготовке таких специалистов позволяет выделить ключевые компетенции госпитального педагога XXI века: адаптивность (способность модифицировать образовательный процесс с учётом условий обучения, нозологий, этапов лечения и психофизического состояния обучающихся), медико-педагогическая и психологическая грамотность (базовые знания в области клинической психологии и нозоцентрированной дидактики, понимание фармакологического воздействия на когнитивные функции, навыки оказания экстренной медицинской помощи), эмоциональный интеллект, навыки кризисного сопровождения (работа с тревожностью, страхами), технологическая гибкость (способность к персонификации обучения и индивидуализации образовательной траектории), цифровая грамотность, интердисциплинарная координация (эффективное взаимодействие в мультипрофессиональной команде), ресурсная саморегуляция (эмоциональная устойчивость, навыки профилактики профессионального выгорания) и другие. Таким образом, профессиональные компетенции госпитального педагога представляют собой специфическую интегративную систему знаний, умений и личностных качеств, необходимых для реализации образовательного процесса для учащихся с ослабленным здоровьем в условиях медицинского стационара и на дому.

Единой, законодательно закреплённой или универсально принятой классификации компетенций госпитального педагога не существует. Разные исследователи и профессиональные сообщества (такие как флагманский проект «УчимЗнаем» в Российской Федерации) предлагают свои модели, которые постоянно развиваются и уточняются [5].

Общее во всех классификациях профессиональных компетенций госпитального педагога – это признание комплексного характера, требующего интеграции педагогических, психологических, медицинских, коммуникативных и организационных навыков, адаптированных к специфической среде обучения, и учитывающих особенности инклюзивного образования.

Подготовка специалистов в области госпитальной педагогики требует междисциплинарного подхода, сочетающего формирование педагогических, медицинских, психологических знаний и организационно-управленческих навыков.

Ключевые модели обучения таких педагогов представлены в таблице 1.

Таблица 1. Модели обучения госпитальных педагогов

Модель	Особенности обучения
Классическая университетская модель	• Обучение в вузах на базе педагогических, психологических или дефектологических факультетов. • Введение специализированных курсов по госпитальной педагогике в программы подготовки.

Междисциплинарная (партнерская, сетевая) модель	• Совместные программы педагогических и медицинских вузов. • Участие больниц, реабилитационных центров в подготовке кадров.
Модель непрерывного профессионального образования (НПО)	• Профильная переподготовка. • Короткие курсы, вебинары, тренинги для уже работающих педагогов.
Гибридная (интегрированная) модель	• Смешанное обучение (онлайн-лекции + очные стажировки). • Использование цифровых инструментов, решение реальных кейсов. • Супервизии и менторство, взаимообучение.

Подготовка госпитальных педагогов различается в разных странах в зависимости от нормативно-правовой базы и уровня развития инклюзивного образования [6, 7].

Примером успешной реализации междисциплинарной (партнерской, сетевой) модели подготовки госпитальных педагогов в Российской Федерации является проект «УчимЗнаем» [8, 9]. Проект является наглядным примером того, как в условиях формирования единого законодательного регулирования может быть выстроена эффективная и комплексная система подготовки высококвалифицированных госпитальных педагогов через партнерство между вузами, медицинскими учреждениями и общественными инициативами.

В Республике Беларусь успешно реализуется гибридная (интегрированная) модель подготовки и сопровождения госпитальных педагогов на базе Минского городского института развития образования (МГИРО), как ключевого учреждения дополнительного образования педагогических кадров в городе Минске.

С целью обучения и оказания методической поддержки руководящим работникам, педагогам, специалистам социально-педагогической и психологической службы по вопросам организации и сопровождения образовательного процесса с длительно болеющими учащимися Минским городским институтом развития образования предложены различные форматы методического обеспечения. При этом по всем направлениям ведётся совместная работа со специалистами различных организаций: образования, здравоохранения, управления, социальных служб и других ведомств.

В 2022 году разработана и ежегодно реализуется образовательная программа повышения квалификации педагогических работников «Психолого-педагогическое и организационно-методическое сопровождение образовательного процесса в условиях госпитализации и на дому», продолжительностью 40 часов. Целевая аудитория – учителя-предметники, педагоги-психологи, педагоги социальные, работающие с детьми в условиях медицинских стационаров и на дому. Содержание модулей программы включает следующие компоненты:

- *Нормативно-правовой:* Особенности организации образовательного процесса в условиях медицинского стационара и на дому. Правовые основы деятельности госпитального педагога.

- *Медико-педагогический:* Основы возрастной и клинической психологии. Особенности физического и психоэмоционального состояния детей в условиях болезни. Этика и деонтология в общении с пациентами, их родителями и медицинским персоналом.

- *Психолого-педагогический:* Технологии конструктивного общения в профессиональной деятельности педагогов. Когнитивное управление поведением педагога в ситуациях профессионального стресса, профилактика профессионального выгорания, технологии саморегуляции.

- *Методический:* Специфика адаптации учебного материала и планирования учебных занятий с учетом состояния здоровья и индивидуальных возможностей ребенка. Индивидуализация и персонификация образовательного процесса. Использование дистанционных образовательных технологий и электронных образовательных сервисов и платформ.

- *Организационно-управленческий:* Административно-документальное обеспечение образовательного процесса. Тайм-менеджмент в профессиональной деятельности. Проектирование и адаптация образовательной среды. Управление профессиональным развитием и качеством образования.

Обучение носит выраженный практико-ориентированный характер. Педагоги разрабатывают индивидуальные образовательные маршруты, адаптируют содержание образования, отрабатывают приемы тьюторского сопровождения, приобретают необходимые медицинские знания и навыки оказания неотложной помощи, осваивают техники саморегуляции и работают над профилактикой эмоционального выгорания. Формат проведения курсов – очно-дистанционный. Теоретическая часть представлена онлайн (вебинары, лекции), а практические занятия, тренинги, круглые столы, деловые игры и дискуссии проходят очно на базе действующих госпитальных школ в учреждениях здравоохранения.

В ходе диагностики выясняются затруднения, которые педагоги испытывают в своей профессиональной деятельности. Ежегодно корректируется содержание образовательной программы повышения квалификации и выстраивается новый образовательный маршрут с учетом запросов и потребностей госпитальных педагогов [10].

По результатам диагностики слушатели высоко оценивают актуальность тем и содержание образовательной программы повышения квалификации (87% - очень высоко, 13% - высоко), отмечают уровень профессионализма приглашенных преподавателей (70% - очень высоко; 30% - высоко). Итоговое анкетирование определило, что 100% слушателей очень высоко (80%) или высоко (20%) оценивают уровень организации повышения квалификации. Среди форм организации образовательного процесса слушатели особо выделяют лекции (56%), практические занятия (78%), экскурсии (82%), что подтверждает

приоритет практико-ориентированного подхода в подготовке госпитальных педагогов.

Стажировки выступают ключевой формой организации подготовки и профессионального развития специалистов в области госпитальной педагогики, обеспечивая переход от теоретического освоения знаний к их практической апробации и формированию устойчивых профессиональных компетенций. Они предназначены для нескольких категорий специалистов: госпитальных педагогов (начинающих и практикующих) и руководителей учреждений образования, в чьи функции входит организация обучения детей, находящихся на длительном лечении. В некоторых случаях стажировку можно организовать для других категорий слушателей в зависимости от необходимой образовательной цели: родителей, воспитателей индивидуального сопровождения, дефектологов, логопедов.

Для педагогов данный формат позволяет апробировать и интериоризировать эффективные методики адаптации образовательного контента и построения субъект-субъектного взаимодействия с детьми, находящимися в состоянии соматической и психоэмоциональной депривации. Для управленческого звена стажировки выступают инструментом изучения и последующей имплементации успешных организационно-управленческих моделей и практик, направленных на создание и развитие служб госпитальной педагогики, формирование благоприятной профессиональной среды в госпитальной школе.

Стажировка руководящих работников и специалистов образования может осуществляться как в очной, так и в заочной, дистанционной формах, и продолжаться от двух недель до 5 месяцев. Результаты стажировки оформляются в соответствии с установленным порядком и находят отражение в виде публикаций в научных и научно-методических изданиях, выступлений с докладами на научно-практических конференциях, обобщения и описания опыта профессиональной деятельности, представления результатов стажировки на семинарах, педсоветах, диалоговых площадках и в других формах презентации. Успешное прохождение стажировки подтверждается свидетельством установленного образца.

В ходе итоговой аттестации и проведения опроса стажеров по результатам освоения образовательной программы стажировки специалисты отмечают доступность и гибкость формата обучения, который интегрировал как теоретические блоки, так и практические задания с возможностью выбора реализуемых проектов. Стажеры выделяют важность адаптации контента под индивидуальные запросы и скорость обучения, включая гибкий график и современные методы обучения, что способствовало высокой вовлеченности и эффективному совмещению стажировки с основной деятельностью стажеров. Содержательный аспект программы стажировки специалистов, определяемый совместно с заказчиком, подтверждает свою эффективность, что по итогам аттестации демонстрирует единодушное мнение всех стажеров о значительном росте их профессиональных компетенций.

Таким образом, стажировки выполняют критически важную функцию в системе профессиональной подготовки кадров для госпитальной педагогики,

обеспечивая формирование профессиональных компетенций специалистов и трансфер эффективного педагогического опыта работы в специфических условиях.

Для решения конкретных педагогических задач МГИРО реализует более короткие и сфокусированные форматы обучения: обучающие курсы, семинары и вебинары. Важным преимуществом такого формата является возможность быстро отреагировать на запросы практиков, обменяться актуальным опытом, привлечь узких экспертов (психологов, врачей, методистов).

Немаловажным направлением методического сопровождения деятельности специалистов госпитальных школ является организация работы профессионального объединения госпитальных педагогов столицы «Тьютор», созданного в рамках реализации регионального образовательного проекта. Его многокомпонентная деятельность структурирована по следующим ключевым направлениям:

1. *Методическое сопровождение профессиональной деятельности и унификация педагогических практик.* Данное направление нацелено на разработку, систематизацию и внедрение эффективных методических подходов к организации обучения и воспитания в условиях медицинских учреждений и на дому. Оно включает в себя:

- Разработку адаптированных образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов, учитывающих нозологию и психофизическое состояние обучающихся.
- Создание банка дидактических материалов и специального инструментария, предназначенного для использования в условиях ограниченных ресурсов и с учетом медицинских противопоказаний.
- Анализ и формализацию эффективных педагогических практик для их дальнейшего тиражирования.

2. *Научно-исследовательская и экспертная деятельность.* Объединение инициирует исследовательскую работу, направленную на изучение специфики образовательной среды в стационаре, на дому и разработку доказательных методов госпитальной педагогики. В рамках данного направления осуществляются:

- Проведение мониторинговых исследований и сбор эмпирических данных для выявления эффективности применяемых педагогических технологий.
- Участие в разработке и экспертизе экспериментальных и инновационных образовательных проектов по вопросам госпитальной педагогики.
- Публикация результатов исследований в научных изданиях и выступления на конференциях.

3. *Организация непрерывного профессионального развития.* Важнейшим аспектом деятельности является повышение квалификации и личностный рост членов объединения, что реализуется через:

- Проведение регулярных заседаний, методологических семинаров, вебинаров и супервизий для обмена практическим опытом и решения профессиональных затруднений, освоения современных педагогических технологий и развития необходимых профессиональных компетенций.

- Организацию стажировочных площадок на базе медицинских учреждений столицы.

- Привлечение внешних экспертов, специалистов в области клинической психологии, дефектологии, медицины, социологии для проведения междисциплинарных консультаций и обучающих мероприятий.

4. *Проектная деятельность и развитие межведомственного взаимодействия.* Объединение выступает интеграционной платформой для консолидации усилий различных организаций и ведомств. Это направление включает:

- Разработку и реализацию социально-значимых проектов, направленных на расширение доступности образовательных услуг для детей в больницах.

- Установление и поддержание партнерских отношений с органами управления образованием и здравоохранением, научными институтами и общественными организациями.

- Участие в работе по совершенствованию нормативной базы, регламентирующей межведомственное взаимодействие при организации обучения детей, находящихся на лечении в учреждении здравоохранения и на дому.

5. *Просветительская деятельность.* Направление нацелено на формирование в общественном сознании понимания важности и специфики работы госпитального педагога, а также важности участия государства и общества в обеспечении законных прав учащихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, связанной с заболеванием, на полноценное и качественное образование. Ключевые активности:

- Информирование профессионального и родительского сообщества о целях, задачах и возможностях госпитальной педагогики.

- Проведение публичных мероприятий (конференций, круглых столов, дней открытых дверей), способствующих популяризации деятельности объединения.

- Защита прав и законных интересов детей на получение качественного образования в период болезни.

- Привлечение общественного внимания и спонсорских ресурсов для укрепления материально-технической базы госпитальных школ.

Таким образом, профессиональное объединение «Тьютор» функционирует как комплексная система, интегрирующая методическую, исследовательскую, образовательную и социальную составляющие подготовки и сопровождения профессиональной деятельности госпитальных педагогов.

Крупными событиями для презентации масштабного опыта, научного осмысления практики и привлечения внимания общественности являются научно-практические конференции и форумы. Ежегодно Минским городским институтом развития образования проводятся конференции с международным участием, посвященные актуальным проблемам развития образования: «Педагогическая наука – школе XXI века: новые инструменты и форматы образования» (апрель); «Современные тенденции развития образования:

моделируем школу будущего» (июнь); «Актуальные направления и перспективы педагогического образования» (октябрь). В рамках конференций проводятся секционные заседания и практические мастер-классы, в ходе которых осуществляется обмен лучшими практиками, методиками и исследованиями в области госпитальной педагогики. Целевой аудиторией выступают госпитальные педагоги, школьные учителя, тьюторы, волонтеры, педагоги-психологи, специалисты органов управления образования и здравоохранения, представители учреждений среднего специального и высшего образования, аспиранты, магистранты, родители, представители общественных организаций.

Итогом конференций становится не только обмен мнениями и привлечение общественного внимания, но и обозначение необходимых конкретных системных изменений, направленных на институционализацию госпитальной педагогики в Республике Беларусь, обеспечение ее необходимыми ресурсами, повышение качества образовательной поддержки и социальной реабилитации детей, находящихся на длительном лечении в стационаре или на дому.

Ещё одним направлением методического сопровождения деятельности госпитальных педагогов является организация тематических и индивидуальных консультаций. Это немаловажный элемент непрерывного развития и профилактики профессионального выгорания специалистов. Темы и содержание консультаций можно сгруппировать в несколько блоков:

1. Нормативно-правовой блок:

«Юридические аспекты работы госпитального педагога: права ребенка, документация, отчетность».

«Как разработать образовательную программу и адаптировать содержание образования под условия работы госпитального педагога?».

2. Методический блок:

«Инструменты быстрой диагностики учебных дефицитов».

«Конструирование практико-ориентированных заданий по учебному предмету».

«Геймификация в госпитальной школе: от теории к практике»

«Цифровая грамотность педагога: обзор лучших электронных ресурсов и платформ».

«Обобщение опыта профессиональной деятельности».

«Искусственный интеллект в помощь госпитальному педагогу: новые возможности и инструменты».

3. Психолого-коммуникативный блок:

«Как говорить с детьми о болезни и лечении (основы коммуникации в сложных ситуациях)?».

«Эмоциональное выгорание: инструкция по распознаванию и профилактике».

«Трудные родители: стратегии взаимодействия (ролевые игры и разбор кейсов)».

«Междисциплинарное взаимодействие: как говорить на одном языке со специалистами разных отраслей».

Минский городской институт развития образования предоставляет возможность для педагогов получать индивидуальные консультации по конкретным вопросам у методистов, профессорско-преподавательского состава кафедр института, привлекать узких специалистов для оказания методической и психологической поддержки, разрешения конфликтов.

Следует выделить менторство как одну из важнейших форм подготовки и адаптации госпитального педагога, которая принципиально отличается от стандартных курсов повышения квалификации. Менторство в госпитальной педагогике представляет собой не просто форму профессионального сопровождения, а выполняет важную функцию социально-профессиональной поддержки, обеспечивающей комплексную адаптацию специалиста в специфических условиях медицинского учреждения. Традиционно ментор определяется из числа опытных педагогов и закрепляется за «новичком» с целью ускорения адаптации, передачи практического опыта, эмоциональной поддержки и формирования профессиональной идентичности. В результате создаются условия для становления высококвалифицированного специалиста, способного не только обеспечивать реализацию образовательных стандартов в условиях медицинского стационара или на дому, но и вносить значительный вклад в психосоциальную реабилитацию детей через создание ситуаций учебного успеха, познавательной активности и позитивной самореализации.

В заключении отметим ключевые принципы, которые Минский городской институт развития образования закладывает в гибридную (интегрированную) модель подготовки и сопровождения профессиональной деятельности госпитальных педагогов:

1. **Междисциплинарность:** в обучении и подготовке госпитальных педагогов участвуют не только методисты, специалисты службы психолого-педагогического сопровождения (ППС), но и приглашенные психологи, педагогики-новаторы, врачи, социальные работники.

2. **Практикоориентированность:** максимум живого опыта, разбора реальных случаев и организация стажировок.

3. **Вариативность:** использование разных форматов обучения для удовлетворения запросов педагогов с разным стажем и потребностями.

4. **Сетевое обучение:** использование возможностей сетевого взаимодействия в рамках деятельности профессиональных объединений и супервизий.

Современные подходы в подготовке госпитальных педагогов направлены на формирование и развитие профессиональных компетенций специалистов, готовых к работе в условиях неопределенности и высокой социальной ответственности. Отметим, что в условиях национальной системы образования реализуется гибридная (интегрированная) модель обучения, наиболее эффективная на данном этапе развития и сочетающая сильные стороны разных подходов:

Сочетание теории и практики. Базовая университетская подготовка даёт фундамент (педагогика, психология, инклюзия), а стажировки в больницах обеспечивают реальный опыт.

Междисциплинарность. Обучение с участием медицинских работников (врачей, реабилитологов), психологов, социальных педагогов (как в партнёрской модели).

Гибкость и доступность. Онлайн-модули по цифровым инструментам и психологической поддержке. Очные тренинги по коммуникации с учащимися, родителями и медперсоналом.

Поддержка после обучения. Менторство: молодые педагоги получают наставников из числа опытных коллег. Супервизии – регулярные встречи для разбора сложных случаев, практических кейсов. Деятельность педагогического сообщества госпитальных педагогов. Участие педагогов в реализации экспериментальных и инновационных проектов в области образования.

Успешная реализация этих подходов требует не только обновления и совершенствования образовательных программ подготовки специалистов в области госпитальной педагогики, разработки соответствующих профессиональных стандартов, но и системной поддержки со стороны государства, медицинских учреждений и педагогического сообщества.

Литература

1. Шариков, С.В. Госпитальная педагогика – современное направление в педагогической науке / А.Ф. Лоскутов, С.В. Шариков, Е.А. Ямбург, А.Г. Румянцев // Народное образование. – 2023. – № 1 (1496). – С. 166-172.
2. Вагарина, В.В. Появление системы госпитальных школ как развитие заботы общества о детях, нуждающихся в длительном лечении / В.В. Вагарина, А.С. Обухов, А.А. Филатов, С.В. Шариков // Проблемы современного образования. – 2021. – № 1. – С. 17-32.
3. Кодекс Республики Беларусь об образовании : 13 янв. 2011 г. № 243-З : принят Палатой представителей 2 дек. 2010 г. : одобр. Советом Респ. 22 дек. 2010 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 5 дек. 2024 г. № 46-З. – URL: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk1100243> (Дата обращения 07.12.2025).
4. Уманская, Т.М. Медико-биологический компонент в подготовке учителей для госпитальной педагогики / Т.М. Уманская // Наука и школа. – 2018. – №6. – С.150–154.
5. Вагарина, В.В. Профессионально-личностные позиции педагогов госпитальных школ / В.В. Вагарина, А.С. Обухов, А.А. Филатов, С.В. Шариков // Педагогика. – 2020. – № 10. – Т. 84. – С. 76-87.
6. Hopkins, L. A pedagogy of hospital space: The nature and impact of the learning environment within a children's hospital / L. Hopkins // Journal of Child Health Care. – 2014. – Vol. 18. – № 3. – P. 264–272.
7. HOPE : [publications]. – [Leuven], 2025. – URL: <https://www.hospitalteachers.eu/what/publications> (Дата обращения 19.09.2025).
8. Долуев, И.Ю. Российская модель госпитальных школ / И.Ю. Долуев // Вестник Мининского университета. – 2025. – № 1. – С. 7–10.
9. Шариков, С.В. Подготовка педагогических кадров для госпитальных школ / О.А. Иванова, М.М. Шалашова, С.В. Шариков, И.Ю. Долуев // Мир науки, культуры, образования. – 2022. – № 2 (93). – С. 260–264.

10. Зык, А.Н. Методическое сопровождение профессиональной деятельности педагогов г. Минска, обеспечивающих образовательный процесс для учащихся в условиях учреждений здравоохранения и на дому / А.Н. Зык // Госпитальная педагогика. Лучшие практики обучения детей, находящихся на длительном лечении в медицинских организациях и на дому : материалы 5-й Всероссийской науч.-практ. Конф. С межд. Участием (Москва, 1-3 ноября 2023 г.) / ФГБНУ ИВФ РАО : под ред. Н. М. Курикаловой [и др.]. – Москва. – 2023. – С. 18–24.

References

1. Sharikov, S.V. Hospital'naya pedagogika – sovremennoe napravlenie v pedagogicheskoy nauke / A.F. Loskutov, S.V. Sharikov, E.A. Yamburg, A.G. Rumyantsev // Narodnoe obrazovanie. – 2023. – № 1 (1496). – S. 166-172.
2. Vagarina, V.V. Poyavlenie sistemy` gospital'ny`x shkol kak razvitie zaboty` obshhestva o detyax, nuzhdayushhixsya v dlitel`nom lechenii / V.V. Vagarina, A.S. Obuxov, A.A. Filatov, S.V. Sharikov // Problemy` sovremennogo obrazovaniya. – 2021. – № 1. – S. 17-32.
3. Kodeks Respubliki Belarus` ob obrazovanii : 13 yanv. 2011 g. № 243-Z : prinyat Palatoj predstavitelej 2 dek. 2010 g. : odobr. Sovetom Resp. 22 dek. 2010 g. : v red. Zakona Resp. Belarus` ot 5 dek. 2024 g. № 46-Z. – URL: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk1100243> (Accessed 07.12.2025).
4. Umanskaya, T.M. Mediko-biologicheskij 164omponent v podgotovke uchitelej dlya gospital'noj pedagogiki / T.M. Umanskaya // Nauka I shkola. – 2018. – № 6. – S.150–154.
5. Vagarina, V.V. Professional'no-lichnostny`e pozicii pedagogov gospital'ny`x shkol / V.V. Vagarina, A.S. Obuxov, A.A. Filatov, S.V. Sharikov // Pedagogika. – 2020. – №10. – T. 84. – S. 76-87.
6. Hopkins, L. A pedagogy of hospital space: The nature and impact of the learning environment within a childrens hospital / L. Hopkins // Journal of Child Health Care. – 2014. – Vol. 18. – № 3. – P. 264–272.
7. HOPE : [publications]. – [Leuven], 2025. – URL: <https://www.hospitalteachers.eu/what/publications> (Accessed 19.09.2025).
8. Doluev, I.Yu. Rossijskaya model` gospital'ny`x shkol / I.Yu. Doluev // Vestnik Mininskogo universiteta. – 2025. – № 1. – S. 7–10.
9. Sharikov, S.V. Podgotovka pedagogicheskix kadrov dlya gospital'ny`x shkol / O.A. Ivanova, M.M. Shalashova, S.V. Sharikov, I.Yu. Doluev // Mir nauki, kul'tury`, obrazovaniya. – 2022. – № 2 (93). – S. 260–264.
10. Zy`k, A.N. Metodicheskoe soprovozhdenie professional'noj deyatel`nosti pedagogov g. Minska, obespechivayushhix obrazovatel'ny`j process dlya uchashhixsya v usloviyax uchrezhdenij zdravooxraneniya I na domu / A.N. Zy`k // Hospital'naya pedagogika. Luchshie praktiki obucheniya detej, naxodyashhixsya na dlitel`nom lechenii v medicinskix organizacijax I na domu : materialy` 5-j Vserossijskoj nauch.-prakt. Konf. S mezhd. Uchastiem (Moskva, 1-3 noyabr. 2023 g.) / FGBNU IVF RAO : redkol: N. M. Kurikalova [I dr.]. – Moskva. – 2023. – S. 18–24.

УДК 371.14

**ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ МАГИСТРАНТОВ
В ГОСПИТАЛЬНОЙ ШКОЛЕ КАК ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА**

Лоскутов Александр Федорович

кандидат педагогических наук

специализированное структурное подразделение

ГБОУ Школа № 109 «Госпитальная школа «УчимЗнаем»

старший методист

ведущий научный сотрудник лаборатории госпитальной педагогики

ФГБНУ «ИРЗАР»

loskutov.af@uchimznaem.ru

Бабенков Николай Дмитриевич

руководитель службы психолого-педагогического

и социального сопровождения,

специализированное структурное подразделение

ГБОУ Школа № 109 «Госпитальная школа «УчимЗнаем»

babenkov.nd@uchimznaem.ru

**THE EXPERIENCE OF ORGANIZING PRACTICUM FOR MASTER'S
STUDENTS IN HOSPITAL SCHOOLS AS AN IMPORTANT TOOL FOR
DEVELOPING THE PROFESSIONAL COMPETENCE
OF FUTURE TEACHERS**

Loskutov Alexander Fedorovich

Leading Research Fellow, Laboratory of Hospital Pedagogy,

Federal State Budgetary Scientific Institution "Institute for the Development of

Education of the Russian Academy of Education"

Candidate of Pedagogical Sciences (Ph.D. in Pedagogical Sciences)

loskutov.af@uchimznaem.ru

Babenkov Nikolay Dmitrievich

Head of the Service for Psychological, Pedagogical and Social Support,

Specialized Structural Unit,

GBOU School No. 109

babenkov.nd@uchimznaem.ru

Аннотация. В материале рассмотрены направления деятельности магистрантов, проходящих практику в госпитальной школе. Практика включает теоретическую подготовку и практическое взаимодействие с длительно болеющими детьми в условиях медицинского стационара. Такой подход способствует формированию у будущих педагогов профессиональных навыков и компетенций для работы в специализированной образовательной среде.

Ключевые слова: практика магистров, специфика образовательной среда, обучающиеся с особыми образовательными потребностями, госпитальная педагогика, дети, нуждающиеся в длительном лечении

Abstract. The report is devoted to fields of activities of master's students undertaking practicum in a hospital school. This school practicum includes theoretical training and practical interaction with children undergoing long-term medical treatment in hospital settings. This approach promotes acquisition of professional skills and competences by aspiring teachers for their working in tailored learning setting.

Keywords: practicum of master's students, learning setting, children with special educational needs, hospital pedagogy, children undergoing long-term medical treatment.

Педагогическая практика магистрантов является важным этапом в подготовке будущих педагогов, особенно тех, кто будет работать в госпитальных школах [1, 2]. Учитель такой образовательной организации должен быть осведомлен в психолого-педагогических особенностях детей, находящихся на длительном лечении, учитывать их эмоциональные и физические потребности. Цель практики магистрантов в госпитальной школе всесторонне подготовить их к профессиональной деятельности, обеспечивая углубление теоретической подготовки, развитие практических навыков и необходимых компетенций в области психолого-педагогического и социального сопровождения особой категории обучающихся и создания поддерживающей образовательной среды [3, 4].

В рамках практики магистрантов в госпитальной школе мы выделяем два вида практики:

- теоретическая подготовка;
- практическая подготовка.

Теоретическая подготовка нацелена на формирование первичных представлений об особенностях педагогической деятельности специалиста в условиях медицинского стационара и реабилитационного центра. Такой вид практики может быть организован как в очном, дистанционном, так и смешанном формате.

Теоретическая подготовка включает лекции специалистов госпитальной школы разного профиля, которые знакомят с образовательной средой госпитальной школы, с палитрой методов и приёмов работы с детьми, находящимися на длительном лечении, с особенностями построения коммуникаций с детьми и их семьями (законными представителями) в условиях стационара и реабилитационного центра.

После прохождения теоретической практики магистранты могут приступить ко второму виду практики: практическая подготовка. Данный вид практики направлен на приобретение опыта и навыков самостоятельной научно-исследовательской и практической деятельности в области госпитальной педагогики.

В ходе практической подготовки магистранты могут выбрать два направления:

- теоретико-практическое, которое нацелено на углубление знаний о работе с детьми, находящимися на длительном лечении и включает проведение урочных и внеурочных (воспитательных) занятий для закрепления полученных теоретических знаний.

- практическое, которое нацелено на подготовку выпускной квалификационной работы по тематике госпитальной педагогики и включает реализацию заранее согласованных методик обучения и сбор данных в процессе проведения магистрантами занятий в сотрудничестве с тьюторами госпитальной школы.

После окончания практики организуется итоговое мероприятие совместно с наставниками магистров, на котором происходит обсуждение результатов практической деятельности будущих педагогов в госпитальной школе. По результатам практики подготавливается научная статья, выступление на научной конференции с докладом или участие в конкурсе научно-исследовательских проектов в области госпитальной педагогики, проводимый в рамках ежегодной конференции «УчимЗнаем» – Заботливая школа.

Опыт проведения практики магистрантов в госпитальной школе проявил заинтересованность будущих педагогов в погружении в образовательную среду, созданную непосредственно в медицинском учреждении. Организация и проведение практики в госпитальной школе дает возможность магистрантам педагогических и психолого-педагогических вузов увидеть всю полноту деятельности госпитального педагога с особой категорией детей, оценить свои силы и возможности в реальной образовательной среде, овладеть основами специфических компетенций и сделать осознанный выбор будущего места своей профессиональной деятельности.

Литература

1. Иванова, О.А. Подготовка педагогических кадров для госпитальных школ / О.А. Иванова, М.М. Шалашова, С.В. Шариков, И.Ю. Долуев // Мир науки, культуры, образования. – 2022. – № 2(93). – С. 260-264.
2. Лоскутов, А.Ф. Опыт сопровождения профессиональной деятельности молодых специалистов Проекта госпитальных школ «УчимЗнаем» / А.Ф. Лоскутов, И.Ю. Долуев, И.А. Гусев, Н.М. Курикалова // Школа будущего. – 2023. – № 3. – С. 28-37.
3. Зорина, Е.С. Психолого-педагогическая практика в госпитальной школе: от первого знакомства до формирования дидактического портфеля / Е.С. Зорина // Педагогическое образование: история становления и векторы развития. материалы международной научно-практической конференции, посвященной

100-летию открытия педагогического факультета при 2-м МГУ. Москва. – 2022. – С. 1419-1423.

4. Шариков, С.В. Педагогическая поддержка образовательных возможностей детей, находящихся на длительном лечении в медицинских стационарах / С.В. Шариков // Альманах Института коррекционной педагогики. – 2020. – № 40. – С. 22-42.

References

1. Ivanova, O.A. Podgotovka pedagogicheskix kadrov dlya gospi tal'ny'x shkol / O.A. Ivanova, M.M. Shalashova, S.V. Sharikov, I.Yu. Doluev // Mir nauki, kul'tury', obrazovaniya. – 2022. – № 2(93). – S. 260-264.

2. Loskutov, A.F. Opy't soprovozhdeniya professional'noj deyatel'nosti molody'x specialistov Proekta gospi tal'ny'x shkol «UchimZnaem» / A.F. Loskutov, I.Yu. Doluev, I.A. Gusev, N.M. Kurikalova // Shkola budushhego. – 2023. – № 3. – S. 28-37.

3. Zorina, E.S. Psixologo-pedagogicheskaya praktika v gospi tal'noj shkole: ot pervogo znakovstva do formirovaniya didakticheskogo portfelya / E.S. Zorina // Pedagogicheskoe obrazovanie: istoriya stanovleniya i vektory' razvitiya. materialy' mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii, posvyashhennoj 100-letiyu otkry'tiya pedagogicheskogo fakul'teta pri 2-m MGU. Moskva. – 2022. – S. 1419-1423.

4. Sharikov, S.V. Pedagogicheskaya podderzhka obrazovatel'ny'x vozmozhnostej detej, naxodyashhixsya na dlitel'nom lechenii v medicinskix stacionarax / S.V. Sharikov // Al'manax Instituta korrekcionnoj pedagogiki. – 2020. – № 40. – S. 22-42.

УДК 159.9.072.42

ОСОБЕННОСТИ ВЫГОРАНИЯ ГОСПИТАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ

Родецкая Виктория Алексеевна

клинический психолог

va-rodetskaya@mail.ru

Бочаров Виктор Викторович

кандидат психологических наук, доцент, руководитель лаборатории

клинической психологии и психодиагностики

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр

психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева»

bochvikvik@gmail.com

FEATURES OF HOSPITAL TEACHERS' BURNOUT

Rodetskaya Viktoria Alekseevna

Clinical Psychologist

va-rodetskaya@mail.ru

Bocharov Viktor Viktorovich

Ph.D. in Psychology, Associate Professor

Head of the Laboratory of Clinical Psychology and Psychodiagnostic

V.M. Bekhterev National Research Medical Center of Psychiatry and Neurology,

bochvikvik@gmail.com

Аннотация. Рассматриваются результаты исследования синдрома выгорания госпитальных учителей, а также факторы, способствующие и препятствующие ему. Впервые была изучена связь выгорания с эмоциональным интеллектом, с областями рабочей жизни и профилем стационара, в котором работают педагоги.

Ключевые слова: госпитальная педагогика, выгорание, эмоциональный интеллект.

Abstract. This article examines the results of a study on burnout syndrome among teachers in hospital schools, analyzing both contributing and mitigating factors. It presents the first investigation into the interrelationship between teacher burnout, emotional intelligence, facets of work life, and the specific type of inpatient care setting.

Keywords: hospital pedagogy, burnout, emotional intelligence.

Целью исследования стало изучение синдрома выгорания госпитальных учителей, а также поиск предикторов и протекторов его развития. **Выборку** составили 48 педагогов, в возрасте 21 – 74 лет, работающих в разных регионах Российской Федерации в стационарах онкологического и травматологического профиля от 4 месяцев до 28 лет. **Гипотезой** послужило предположение о наличии взаимосвязи синдрома выгорания и эмоционального интеллекта, в частности его внутриличностного компонента.

В рамках исследования с учителями проводилось интервью, включающее закрытые и открытые вопросы. Выгорание изучалось опросниками «Эмоциональное выгорание» В.В. Бойко («ЭВ») и «Профессиональное выгорание» Н.Е. Водопьяновой и Е.С. Старченковой («ПВ»), эмоциональный интеллект оценивался методикой М.А. Манойловой («МЭИ»), измерения восприятия учителями рабочей среды проводились опросником «Сферы профессиональной жизни» («AWS») М. Лейтера и К. Маслач. Для обработки полученных данных использовались математико-статистические методы.

Согласно полученным результатам с выгоранием госпитальных педагогов связаны такие факторы, как психотравмирующие обстоятельства (физическое состояние и смерть учеников), количество рабочих часов, профиль учреждения – у работающих в онкологических отделениях симптоматика более выражена. При этом статистически значимых связей выгорания **со стажем работы, возрастом и регионом** проживания выявлено не было.

Влияние **организационных факторов** измерялось методикой «Сферы профессиональной жизни», которая оценивала: 1) уровень рабочей нагрузки; 2) степень автономии при выполнении обязанностей; 3) субъективное восприятие признания и вознаграждения; 4) качество взаимодействия и сотрудничества внутри коллектива; 5) равномерность и прозрачность распределения ресурсов в организации, 6) степень совпадения личных ценностей сотрудников с декларируемыми ценностями организации [1]. Результаты показали высокий уровень согласованности между условиями труда и личными предпочтениями большинства опрошенных педагогов, что говорит об общей удовлетворенности работой.

Однако специфика работы в медицинском учреждении (строгий гигиенический режим, эмоционально насыщенное общение с длительно болеющими детьми, наблюдение за их страданиями, возможность ухудшения здоровья и смерти учеников) требуют постоянных психоэмоциональных затрат и особых личностных качеств [2].

Опрошенные учителя воспринимают работу как «смысл жизни», «миссию», возможность «облегчить жизнь детей», «помочь ребенку», «делать что-то важное», «быть нужным» и в целом предъявляют высокие требования к себе. Качествами, необходимыми для работы в госпитальной школе, они считают эмпатию, чуткость, способность «сострадать, но не пропускать через себя», умение «контролировать эмоции – быть внимательным, но не показывать жалость и страх», «всегда быть в ресурсе», «заражать хорошим настроением, вне зависимости от собственных переживаний». При этом известно, что «эмоциональный труд» – необходимость выражения социально ожидаемых

эмоций, «усталость от сострадания» – длительное сопереживание негативным эмоциям других людей, а также чрезмерная открытость, эмоциональная близость с пациентами и их семьями способствуют психофизиологическим перегрузкам и могут приводить к выгоранию [3, 4].

Учителя знакомы с методами профилактики выгорания, однако применяют их редко из-за недостатка сил и времени («некогда жалеть себя»), нежелания проявлять слабость («когда видишь больного ребенка, не можешь думать о себе»), представлений об избирательности развития синдрома («невозможно выгореть, когда любишь свою работу», «нет выгоревших, есть некомпетентные»). Данную тенденцию ученые называют **стигматизацией** выгорания и считают одной из помех эффективной профилактики [3].

При этом согласно методике «ЭВ» формирующиеся или сформированные **признаки синдрома выгорания** присутствуют у 36% учителей. Наиболее проявлены симптомы «расширение сферы экономии эмоций» (сформирован у 25%), «переживание психотравмирующих обстоятельств» (сформирован у 25%). В стадии формирования находятся «эмоциональная отстраненность» (у 31%), «редукция профессиональных обязанностей» (у 28%), «эмоциональный дефицит» (у 30%), «психосоматические нарушения» (у 19%).

Согласно методике «ПВ» высокий уровень выгорания выявлен у 23% учителей, средний – у 35%. Наиболее выраженным компонентом является «эмоциональное истощение»: у 33% педагогов оно проявлено высоком уровне, у 31% – на среднем.

Ключевым средством преодоления симптомов выгорания может стать **эмоциональный интеллект** – навык, который может развиваться в течение всей жизни [5]. В ходе исследования изучался интегральный эмоциональный интеллект педагогов и два его аспекта: 1) внутриличностный, включающий компоненты «осознание своих чувств» и «управление своими чувствами», и 2) межличностный, включающий компоненты «осознание чувств других» и «управление чувствами других»

Большинство опрошенных педагогов («МЭИ») обладают высоким уровнем интегрального эмоционального интеллекта (63%) и его внутриличностного аспекта (60%). При этом компоненты внутриличностного эмоционального интеллекта проявлены неравномерно: «управление своими эмоциями» на высоком уровне у 73%, а «осознание своих эмоций» лишь у 27% педагогов. Однако есть мнения, что именно умение осознавать свои эмоции может препятствовать выгоранию [6].

В ходе корреляционного анализа обнаружена отрицательная связь интегрального эмоционального интеллекта и субшкал методики «ПВ» «деперсонализация», «редукция персональных достижений», «эмоциональное истощение». Также были выявлены значимые связи компонента **«осознание своих эмоций»** со шкалами «редукция достижений» и «деперсонализация». («ПВ») и с симптомами «личностная отстраненность», «тревога и депрессия», «неудовлетворенность собой», «расширение сферы экономии эмоций», «переживание психотравмирующих обстоятельств» («ЭВ»).

Таким образом, гипотеза о связи эмоционального интеллекта и синдрома выгорания у госпитальных учителей была подтверждена. Это позволяет предполагать, что развитие эмоционального интеллекта, в частности, навыка понимания своих эмоций, позволит повысить адаптационные ресурсы педагогов к воздействию стрессоров.

Также важным фактором профилактики может стать критическое переосмысление распространенных стереотипов и предубеждений о возникновении и распространении выгорания, о необходимости профилактики синдрома и о сотрудниках, демонстрирующих его признаки.

Литература

1. Шишкова, А.М. Кросс-культурная адаптация методики «Сферы профессиональной жизни» (Areas of Worklife Survey, AWS) на русскоязычной выборке медицинских работников онкологического стационара / А.М. Шишкова, В.В. Бочаров, Н.Г. Васильев, Е.С. Цыганкова, А.Я. Вукс // Консультативная психология и психотерапия. – 2025. – № 33(1). – С. 106-126.
2. Шариков, С.В. Педагогическая поддержка образовательных возможностей детей, находящихся на длительном лечении в медицинских стационарах / С.В. Шариков // Альманах Института коррекционной педагогики. – 2020. – № 40. – С. 22-42.
3. Булгаков, И.А. Современные направления изучения феномена эмоционального выгорания / И.А. Булгаков // Современная зарубежная психология. – 2023. – Том 12. – № 2. – С. 94-103.
4. Клипинина, Н.В. Психологические трудности и рекомендации по профессиональной адаптации в работе паллиативных медицинских сестер / Н.В. Клипинина // Pallium: Паллиативная и хосписная помощь. – 2019. – № 4. – С. 19-22.
5. Рудакова, О.А. Эмоциональный интеллект в структуре личности будущего психолога / О.А. Рудакова // Гуманитарные науки. – 2020. – Т. 10. – № 2. – С. 10-20.
6. Соловьева, И.А. Эмоциональный интеллект как фактор преодоления негативных психических состояний у педагогов / И.А. Соловьева, С.А. Соловьева, С.В. Велиева // Мир науки. Педагогика и психология. – 2024. – Т. 12. – №2. – URL: <https://mir-nauki.com/PDF/66PSMN224.pdf> (Дата обращения 01.09.2025)

References

1. Shishkova, A.M. Kross-kul'turnaya adaptaciya metodiki «Sfery` professional`noj zhizni» (Areas of Worklife Survey, AWS) na russkoyazy`chnoj vy`borke medicinskix rabotnikov onkologicheskogo stacionara / A.M. Shishkova, V.V. Bocharov, N.G. Vasil`ev, E.S. Cygankova, A.Ya. Vuks // Konsul`tativnaya psixologiya i psixoterapiya. – 2025. – № 33(1). – S. 106-126.
2. Sharikov, S.V. Pedagogicheskaya podderzhka obrazovatel`ny`x vozmozhnostej detej, naxodyashhixsya na dlitel`nom lechenii v medicinskix

stacionarax / S.V. Sharikov // Al'manax Instituta korrekcionnoj pedagogiki. – 2020. – № 40. – S. 22-42.

3. Bulgakov, I.A. Sovremenny'e napravleniya izucheniya fenomena e'mocional'nogo vy`goraniya / I.A. Bulgakov // Sovremennaya zarubezhnaya psixologiya. – 2023. – Tom 12. – № 2. – С. 94-103.

4. Klipinina, N.V. Psixologicheskie trudnosti i rekomendacii po professional'noj adaptacii v rabote palliativny`x medicinskix sester / N.V. Klipinina // Pallium: Palliativnaya i xospisnaya pomoshh`. – 2019. – № 4. – S. 19-22.

5. Rudakova, O.A. E'mocional'ny`i intellekt v strukture lichnosti budushhego psixologa / O.A. Rudakova // Gumanitarny'e nauki. – 2020. – T. 10. – № 2. – S. 10-20.

6. Solov`eva, I.A. E'mocional'ny`i intellekt kak faktor preodoleniya negativny`x psixicheskix sostoyaniĭ u pedagogov / I.A. Solov`eva, S.A. Solov`eva, S.V. Velieva // Mir nauki. Pedagogika i psixologiya. – 2024. – T. 12. – №2. – URL: <https://mir-nauki.com/PDF/66PSMN224.pdf> (Accessed 01.09.2025)

УДК 371.14

**ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ГОСПИТАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ: РЕСУРСЫ
СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ**

Гущина Людмила Ивановна

кандидат педагогических наук

Санкт-Петербургская академия постдипломного
педагогического образования им. К.Д. Ушинского

доцент кафедры педагогики окружающей среды
безопасности и здоровья человека

lig.08@bk.ru

Кот Татьяна Викторовна

кандидат психологических наук

Санкт-Петербургская академия постдипломного
педагогического образования им. К.Д. Ушинского
заведующий кафедрой педагогики окружающей среды
безопасности и здоровья человека

tvkot2010@mail.ru

**THEORY AND PRACTICE OF HOSPITAL PEDAGOGY: RESOURCES
OF THE ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION SYSTEM**

Gushchina Lyudmila Ivanovna

Candidate of Pedagogical Sciences

St. Petersburg Academy of Postgraduate Pedagogical Education
named after K.D. Ushinsky

Associate Professor of the Department of Environmental Pedagogy
Safety and Human Health

lig.08@bk.ru

Kot Tatiana Viktorovna

Candidate of Psychological Sciences

St. Petersburg Academy of Postgraduate Pedagogical Education
named after K.D. Ushinsky

Head of the Department of Environmental Pedagogy
Safety and Human Health

tvkot2010@mail.ru

Аннотация. В статье определена значимость интеграции деятельности специалистов образования, здравоохранения, молодежной и социальной политики для достижения целей госпитальной педагогики. Обозначена важность кадровой подготовки специалистов для педагогической деятельности в госпитальных школах. Представлены организационные и учебно-методические возможности дополнительного профессионального образования в решении актуальных задач госпитальной педагогики в системе современного образования.

Ключевые слова: госпитальная педагогика, госпитальная школа, дополнительное профессиональное образование, психолого-педагогическая компетентность.

Abstract. The article focuses on the importance of integrating the activities of specialists in education, healthcare, youth and social policy in order to achieve the goals of hospital pedagogy. The importance of personnel training of specialists for teaching activities in hospital schools is highlighted. The article presents the organizational, educational and methodological possibilities of additional professional education in solving urgent problems of hospital pedagogy in the modern education system.

Keywords: hospital pedagogy, hospital school, additional professional education, psychological and pedagogical competence.

«Теория без практики мертва, практика без теории слепа»

А.В. Суворов

«Одна педагогическая практика без теории – то же, что знахарство в медицине»

К.Д. Ушинский

«Не тот пропал, кто в беду попал, а тот пропал, кто духом упал»

Русская народная пословица

Госпитальная педагогика в настоящее время рассматривается как область междисциплинарного научного взаимодействия и часть комплексной медико-социальной реабилитации детей, находящихся длительное время на лечении в условиях клинического стационара или же на дому. Являясь частью педагогической науки и практики, госпитальная педагогика решает актуальные задачи, связанные с реализацией права детей, имеющих особые медицинские и образовательные потребности, на полноценное образование.

Обучение детей, находящихся в стационаре, осуществляется по таким же образовательным программам, как в обычной школе, но имеет свою специфику, связанную с необходимостью подбора и использования методик, которые максимально учитывают индивидуальные потребности и особенности обучающихся. Образовательная среда для длительно и часто болеющих ребят во многом связана с личностью госпитального педагога, его умением быть в контакте, быть чутким, сопереживать, но без жалости, а с уважением к личности ребенка, которому порою нелегко справляться с самыми простыми жизненными

задачами. Безусловно, это требует от педагогов особого взгляда на свою профессиональную компетентность и педагогический процесс в целом.

Достижение оптимальных медицинских и образовательных результатов в значительной степени обусловлено пониманием особенностей состояния здоровья и учетом компенсаторных возможностей учеников, наличием компетенций, необходимых для построения индивидуальной траектории лечения и обучения.

При планировании и осуществлении образовательного процесса с больным ребенком важно учитывать ряд факторов, осложняющих процесс обучения, таких как длительность лечения, режим приема лекарств и лечебных процедур, необходимость адаптироваться к организационным особенностям лечебного учреждения, актуальным изменениям в состоянии здоровья и настроении детей. Педагогу важно иметь знания, позволяющие ему учитывать при организации учебного процесса медицинский, психологический и социальный статус конкретного ребёнка. Следовательно, подготовка педагогов госпитальных школ должна носить междисциплинарный характер, интегрирующий несколько областей научных знаний, в первую очередь – медицинских, психологических и педагогических [1, 2].

С помощью полученных в ходе профессиональной подготовки специфических знаний по физиологии и медицине, педагог сможет лучше понимать суть происходящего, осознавать влияние различных видов медикаментозного воздействия на организм ребёнка, соответствующие изменения в его физической активности и умственной работоспособности, грамотно подбирать методику, темп занятий и объём учебной нагрузки в зависимости от текущего состояния здоровья.

Безусловно, эффективность обучения в госпитальной школе во многом зависит от оптимально подобранного маршрута обучения, учитывающего все нюансы физиологического состояния ребенка, однако многое зависит от качества коммуникации педагога – с детьми, их родителями, медицинским персоналом. Умение устанавливать эмоциональный контакт, выражать сочувствие, демонстрировать принятие – важные навыки общения, эмпатии и рефлексии, которые педагогу госпитальной школы следует развивать и совершенствовать постоянно.

Основная идея госпитальной педагогики связана не с подстраиванием ребенка к специфической образовательной среде лечебного учреждения, а с формированием образовательной среды, адаптированной к нуждам болеющего человека. Главный принцип госпитальной педагогики заключается в том, чтобы создать для болеющего ребенка комфортные условия для выздоровления и полноценного участия в образовательном процессе с учетом тех возможностей, которые у него есть. Важно, чтобы госпитальный педагог смог обеспечить моральную поддержку детям, быть для них опорой, оперативно реагировать на изменения, уметь отвечать не только на узко предметные вопросы, но и на сложные философские, в том числе о жизни и смерти.

Находясь рядом с болью ребенка, сопереживая и сочувствуя ему, педагог госпитальной школы постоянно находится в зоне риска такой профессиональной

деформации как эмоциональное выгорание. В этой связи ему важно обладать навыками самодиагностики и саморегуляции. Важно уметь своевременно обращаться за помощью к руководству, коллегам, психологам, принимать участие в индивидуальной и групповой работе профилактической направленности, в супервизионных и балинтовских группах, позволяющих лучше понимать, что с тобой происходит не только в педагогическом процессе, но и при личном взаимодействии с больными детьми, их родителями, медицинским персоналом [2].

В госпитальных школах ребенку крайне необходим положительный эмоциональный настрой и отвлечение от негативных переживаний, обретение смысла в борьбе с болезнью. Поэтому образовательный процесс должен быть максимально направлен не столько на непосредственное обучение детей и подростков школьному предмету, сколько на развитие их творческих способностей и раскрытие личностных качеств. Помощь в сохранении спокойствия, поддержка интереса к предмету, раскрытие творческого потенциала оказывают благотворное терапевтическое воздействие и способствуют выздоровлению.

Психологическая компетентность педагога как интегративное многоуровневое личностное образование, развивается на основе совокупности системных знаний, умений, навыков, практического опыта, рефлексивной деятельности и диалогической культуры, и выражается в готовности специалиста к эффективной профессионально-педагогической деятельности. Критериями психологической компетентности являются диагностические и проектировочные умения, позволяющие направлять диагностический материал на индивидуальное развитие ребенка, владение навыками конструктивного педагогического общения, способность педагога оказывать помощь ребенку и его родителям в сложные периоды жизни, и др. [3].

Одной из важных задач госпитальной педагогики является обеспечение преемственности между госпитальной и обычной школой, в которую вернется ребенок после пребывания в стационаре, разъяснение особенностей выстраивания образовательного процесса с учетом текущего состояния и возможностей ребенка.

Специалисты системы дополнительного профессионального образования педагогов при проектировании образовательных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки должны учитывать необходимость включения знаний по применению здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе, что поможет методически подготовить педагогов обычных школ тому, как выстраивать стратегию обучения болеющего ребенка, какую информацию надо знать о периоде восстановления здоровья, то есть о периоде ремиссии и т.д. Применение здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе становится важной задачей современного педагога [3, 4].

Образовательная деятельность в больнице требует специфической подготовки кадров к ее осуществлению. Для решения проблемы повышения

квалификации педагогов, работающих в лечебных учреждениях, необходимо тесное сотрудничество специалистов разных профилей.

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования имени К.Д. Ушинского (далее – СПб АППО) имеет многолетний опыт успешной реализации образовательных программ профессиональной переподготовки «Педагогика безопасности», «Педагогика здоровья», «Тьюторская и волонтерская деятельность педагога в области здоровьесбережения», «Педагогика и психология безопасности: помощь в чрезвычайных и кризисных ситуациях» и ряда программ повышения квалификации, в которые включены специальные тематические модули, направленные на обучение некоторым разделам медицины, фармакологии, специальной (коррекционной) педагогики, клинической психологии и др.

Учебный модуль «Основы медицинских знаний» направлен на повышение медицинской культуры педагога. Учебный модуль «Педагогика здоровья и профессиональное здоровье педагога» ориентирован на формирование у педагогов ценности жизни и здоровья, культуры здорового образа жизни, профилактику эмоционального выгорания. Учебный модуль «Возрастная физиология и психология» нацелен на изучение физиологических и психологических особенностей детей и подростков, что позволяет осуществлять дифференцированный подход к их обучению и воспитанию.

Отвечая на вызовы времени, связанные с решением задач развития социальной инклюзии, кафедрой педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья человека СПб АППО разработана программа «Теория и практика госпитальной педагогики». Программа дает представление об основных понятиях этого раздела педагогической науки, историческом развитии психолого-педагогической помощи детям, находящимся в условиях длительного лечения в медицинских стационарах или на дому, методике работы с такими детьми на основе медицинских и психологических знаний.

В рамках изучения данной программы представляется современная система организации деятельности образовательного учреждения, оказывающего психолого-педагогическую помощь детям, находящимся в условиях длительного лечения. Раскрывается важнейший принцип госпитальной педагогики, суть которого заключается в индивидуальном подходе к каждому болящему ребенку. Подчеркивается важность знания и учета психологических особенностей личности, эмоционально-волевых состояний ребенка, проведения психолого-педагогической коррекции в целях эффективной реабилитации. Предлагается система развития креативных и социальных навыков обучающихся, находящихся в условиях изоляции, на длительном лечении. У слушателей курсов формируются профессиональные навыки разработки и реализации индивидуального образовательного маршрута.

Комплексный подход к обучению педагогов, интегрирующий педагогические, медицинские и психологические знания, который реализуется в Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования имени К.Д. Ушинского, направлен на системную подготовку педагогов

госпитальных школ к работе с детьми разных возрастов, на всех ступенях общего образования.

Литература

1. Адамян, Е.И. Госпитальная педагогика: Учебно-методическое пособие / Е.И. Адамян, Л.И. Адамян, И.Д. Демакова [и др.]. – Москва: Московский педагогический государственный университет. – 2025. – 236 с.
2. Шариков, С.В. Педагогическая поддержка образовательных возможностей детей, находящихся на длительном лечении в медицинских стационарах / С.В. Шариков // Альманах Института коррекционной педагогики. – 2020. – № 40. – С. 22-42.
3. Шевелева, Д.Е. Профессиональная подготовка и компетенции педагогов для работы в госпитальных школах / Д.Е. Шевелева // Коррекционно-педагогическое образование. – 2025. – № 2 (42). – С. 34-41.
4. Кот, Т.В. Особенности и содержание диагностической компетенции психолога / Т.В. Кот, Л.В. Абдалина // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2010. – № 12 (92). – С. 156-159.
5. Тарасова, О.А. Критерии и уровни готовности будущего учителя к реализации здоровьесберегающих технологий / О.А. Тарасова, Е.В. Колтыгина, П.П. Сапрыкин // Проблемы современного педагогического образования. – 2024. – № 83-4. – С. 197-199.

References

1. Adamyan, E.I. Hospital'naya pedagogika: Uchebno-metodicheskoe posobie / E.I. Adamyan, L.I. Adamyan, I.D. Demakova [i dr.]. – Moskva: Moskovskij pedagogicheskij gosudarstvenny`j universitet. – 2025. – 236 s.
2. Sharikov, S.V. Pedagogicheskaya podderzhka obrazovatel'ny`x vozmozhnostej detej, naxodyashhixsya na dlitel'nom lechenii v medicinskix stacionarax / S.V. Sharikov // Al'manax Instituta korrekcionnoj pedagogiki. – 2020. – № 40. – S. 22-42.
3. Sheveleva, D.E. Professional'naya podgotovka i kompetencii pedagogov dlya raboty` v hospital'ny`x shkolax / D.E. Sheveleva // Korrekcionno-pedagogicheskoe obrazovanie. – 2025. – № 2 (42). – S. 34-41.
4. Kot, T.V. Osobennosti i sodержanie diagnosticheskoy kompetencii psixologa / T.V. Kot, L.V. Abdalina // Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarny`e nauki. – 2010. – № 12 (92). – S. 156-159.
5. Tarasova, O.A. Kriterii i urovni gotovnosti budushhego uchitelya k realizacii zdorov'esberegayushhix texnologij / O.A. Tarasova, E.V. Kolty`gina, P.P. Sapry`kin // Problemy` sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya. – 2024. – № 83-4. – S. 197-199.